小野町高齢者保健福祉計画

第 10 期介護保険事業計画

素案（第 14 版）

計画期間：令和 9 年度～令和 11 年度

令和 8 年 10 月

小　野　町

目　次

各行をクリックすると本文へ移動します。ページ番号は Word で開いた時点で更新されます

本素案について……1
未確定箇所の凡例……2
目次……5
第１章　計画策定にあたって……6
1　計画策定の趣旨……6
2　第 10 期計画の基本指針……6
3　計画の位置づけと期間……8
4　計画策定の視点……9
5　日常生活圏域の設定……10
6　計画の進行管理・推進体制……10
7　計画の策定体制……12
第２章　小野町の高齢者・介護等の状況……14
1　人口と世帯の状況……14
2　令和７年度調査のまとめ……14
3　小野町の介護保険事業の状況……16
4　介護保険財政の状況……19
5　サービス提供体制の状況……20
6　高齢者数等の将来推計……22
7　第 10 期計画における課題の整理……24
第３章　第９期計画の実施状況と評価……27
1　第９期計画の基本目標と達成状況……27
2　地域支援事業の実績……27
3　介護保険事業の実績……28
4　第９期の評価と第 10 期への課題……29
第４章　計画の基本的考え方……30
1　計画の基本理念と目標……30
2　計画の体系……30
3　関連計画との役割分担……31
4　障がい福祉計画との接点……34
第５章　施策の展開……37
基本目標１　介護予防と生きがいづくりの推進……37
基本目標２　安全・安心な暮らしの確保……41
基本目標３　介護サービスの充実……51
第６章　介護保険事業等の見込み……57
1　要介護認定者数の見込み……57
2　介護給付等サービスの見込量……57
3　介護保険サービス事業費の見込み……60
4　地域支援事業の見込量と事業費……61
5　第１号被保険者の保険料……64
6　人材の供給制約からみた見込量の妥当性……66
7　見える化システムによる算定との突合……67
8　介護施設等の整備の基本方針と必要利用定員総数……69
9　老人福祉事業の量の目標……70
10　低所得者支援……71
11　中長期の見通し（令和 22 年・令和 32 年）……71

12　将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策……73
資料編……76
8　成果指標の定義……76
9　年次評価の様式……78
10　施策の見直しの基準……78
11　主な参照資料……79
12　地域分析の指標（国の基本指針の案の別表1）……79
13　図表番号一覧……80
参考　本素案の確定に必要な事項……85

本素案について

本素案は、骨子案（第3版）に基づき、計画書の本文を作成したものです。第9期介護保険事業計画（令和6年3月）の章構成・基本理念・基本目標・施策体系を継承し、第3期地域福祉計画（令和8年3月）との役割分担を整理したうえで、令和7年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査の結果、地域包括ケア「見える化」システムによる分析結果を反映しています。

【表1】本素案について

区分	内容
計画期間	令和9年度から令和11年度までの3年間
位置づけ	老人福祉法第20条の8に基づく市町村老人福祉計画及び介護保険法第117条に基づく市町村介護保険事業計画を一体のものとして策定する。あわせて、認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画を包含する
第1版からの変更	第1版（令和8年7月31日）は第9期計画本文の確認前に作成したもので、独自の4基本目標・6本柱の施策体系を採っていた。第9期の実際の体系は3基本目標・14施策であり、第2版で全面的に改めたうえ、以後の版で受領資料を順次反映している
第7版（令和8年9月29日）の変更	町からお預かりした令和7年度調査結果報告書の原本（104頁）と、本素案に載せている集計値を1件ずつ突き合わせた。第2章2及び第5章 基本目標2③ の認知症の設問の項目名を訂正している（54.1％は「相談窓口の充実」ではなく「地域での見守りや声掛け」）。その他の値はすべて原本と一致した
第8版（令和8年10月4日）の変更	**他団体の第10期計画との構成の対比で残っていた3項目を埋めた。①第6章11「中長期の見通し（令和22年・令和32年）」を新設**（国が第10期に2040年等の中長期を見据えることを求めているため）。**②第1章2に、国が第10期に求める5点と、確認すべき制度改正5件の表を加えた。**③資料編12「図表番号一覧」を新設し、すべての表に通し番号を振った
第9版（令和8年10月5日）の変更	**第5章の各施策に【関連データ】の表を加えた（12施策）。**他団体の第10期計画は施策ごとに（1）現状と課題（2）関連データ（3）施策の方向性（4）主な事業（5）達成目標の5項目を置いており、本町は（2）が無く根拠の数値が本文の中に散っていた。**値は一次資料の台帳から引いている。**台帳は、町からお預かりした原本と本素案の数値を1件ずつ突き合わせたもの（286件）で、**ここに載るのは原本と照合済みの値だけになる。**あわせて、単価の趨勢（第6章5の注記）を算定値を参照する形に改めた
第10版（令和8年10月14日）の変更	**社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により本計画の法定記載事項が増えたことを反映した。** 原典は厚生労働省・こども家庭庁「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」。**①第6章12「将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策」を新設**（第6章11の中長期の推計と対になる記載事項）。**②第6章2の冒頭に、医療と介護の連携の状況および有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等の入居定員を勘案した旨を記載**し、第2章5に介護保険給付によらない住まいの定員の表を設けた。**③第1章2の制度改正の表に4件を加えた**（法律第51号の記載事項の追加／適用の可否を確かめるもの／民法等改正による成年後見制度の見直し／介護支援専門員の更新制の廃止）。**都道府県が定める事項（人材確保・生産性向上の協議会等）は本計画の記載事項に数えず、連携の記述にとどめている**
第11版（令和8年10月15日）の変更	**新旧対照条文（厚生労働省・全353頁）を入手し、第10版の記載を条文で確かめて改めた。** 第10版は概要（全17頁）によっており、条・項・号の別が読み取れていなかった。**①第6章11を介護保険法第117条第2項第3号に基づくものとして位置づけ、地域支援事業の量の中長期的な推計を加えた**（改正により、量が第3項（努力義務）から第2項（義務）に移り、地域支援事業の量が加えられたため）。**②第6章12を同条第2項第4号に基づくものとして位置づけ、地域支援事業の実施の面を加えて6つとした**（条文が「サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施」と並べているため）。**③第2章5・第6章2の勘案事項を、同条第5項の条文どおりに改めた。**勘案の対象は2類型（老人福祉法第29条第1項の届出をした有料老人ホーム、及び高齢者住まい法第7条第5項の登録住宅）で、いずれも特定施設入居者生活介護等の指定を受けていないものに限られる。**区域の単位が第1号（本町の区域）と第2号（県の区域）で異なる。④第4章4（障がい福祉計画との接点）に、介護保険法第115条の48第5項と障害者総合支援法第89条の3第5項により支援会議と支援協議会の相互の連携が法定の努力義務となったことを加えた**
第11版の追記（同	**本町に山村振興法第7条第1項の振興山村（旧夏井村の区域）があることを第1章2及び第2章5に記**

日）	**載した。** 振興山村は介護報酬の特別地域加算の算定要件に挙げられており、国の検討では特別地域加算の対象地域を特定地域（中山間・人口減少地域）の基準に含めることとされている。**ただし基準は厚生労働省令で定まるものであり、指定の有無は本文に書いていない**
第12版（令和8年10月20日）の変更	**策定チェックリスト（手引き目次対応・176項目）で第11版を確かめ、素案の修正が要るとした17件を反映した。 ①第4章1に「本町の地域包括ケアの姿」を定め、第6章11・12から参照した。**②第4章3に、保健・認知症の分野の関連計画との役割分担の表を加えた。③第1章7に庁内の検討体制を加え、住宅担当の関与を書いた。**④資料編8に成果指標の種類（アウトプット／アウトカム）の一覧を加え、第5章 基本目標2⑥に介護職員の定着の指標を加えた。**⑤第1章3に新たな地域医療構想を、第5章に総合事業のガイドライン・ケアプランデータ連携・地域医療介護総合確保基金・重層的支援体制整備事業の確認事項を加えた。**町・県の資料を受けて埋めるものは、未確定の印を付けて置いている**
第13版（令和8年10月20日）の変更	**国資料（令和8年3月・7月の全国課長会議資料、地域分析の手引き改訂版）と介護保険部会の資料に照らし、誤り2件を改め、5件を書き足した。 誤り：①所得段階の年金収入等の基準額を80万円から82.65万円に改めた**（介護保険法施行令第38条。令和8年政令第274号による改正後）。**②基本指針の告示時期を、国のスケジュールどおり令和8年11月頃に改めた。** 書き足し：③介護保険の特定地域について、本町は振興山村の一部指定として国の一覧に載っていること（第1章2・第6章12）、④地域の類型（中山間・人口減少地域）（第1章4）、⑤基本指針案の別表1の指標と本計画の対応（資料編12）、⑥介護予防支援拠点事業（第5章 基本目標1②）、⑦頼れる身寄りがいない高齢者等の相談（第5章 基本目標2②）
本版（第14版・令和8年10月20日）の変更	**介護SCR（厚生労働科学研究班のデータ）と、見える化システムの第1回出力を反映した。** ①資料編12に介護SCRの表を加え、第6章2・第5章 基本目標2⑤⑦の現状に介護SCRを加えた。②第6章11に介護SCRの将来推計を並べ、2つの推計が同じ形（令和27年頃にピーク）を示すことを書いた。③第2章6の認知症高齢者数を、自立度Ⅲａ・Ⅲｂを含む完全な値（見える化Ｂ7）で置き直した。④成果指標の現状値（認定者に対する受給者の比率、認知症サポーター数、町内の事業所数）を埋めた。**見える化の未着分（施設の事業所数、退院退所加算の算定回数、協議体）は印を残した**
確定していない事項の表示	**確定していない箇所は、その理由により5種類に区別して表示している。**内訳は次頁の「未確定箇所の凡例」のとおり

※ 本素案は協議会での検討用であり、確定稿ではありません。サービス見込量及び保険料は、認定者数の確定後に算定します。

未確定箇所の凡例

本素案には確定していない箇所が184あります。**第2版（令和8年8月5日）では158箇所ありましたが、令和8年9月に介護保険事業状況報告（年報）令和3〜7年度、国保連合会業務統計表（月報）、第10期将来推計用推計人口を受領したことにより-26箇所が解消しました。**とくに第2章6の将来推計（被保険者数・認定者数）と第5章のサービス見込量・給付費・保険料が確定しています。

※ 各施策の【現状と課題】【施策の方向】は本文の見出しであり、未確定箇所ではありません。上の件数には含めていません。

残る箇所の性格は一様ではないため、次の5区分に分けて表示しています。町からのデータ受領を待っているのは102箇所（55.4％）で、最も多いのは協議会で設定する成果指標の目標値56箇所（30.4％）です。

【表2】本素案について　未確定箇所の凡例

表示	意味	箇所	割合	解消の方法
【協議会で設定】	成果指標の目標値。現状値は調査・年報・見える化で取得済みのものが多い	56	30.4％	**協議会での議論により設定する**
【町データ待ち】	**年報・見える化では取得できず、町の内部データが必要なもの**	**102**	**55.4％**	**町からの受領。**地域支援事業費の事業別内訳、介護給付費準備基金の残高、事業実績、健診受診率、相談件数、個別避難計画、移送・配食等の利用者数、令和7年8〜9月の

				認定者数の計上方法の変更の有無
【算定後に記載】	**受託者が算定するもの。データの受領を待っているのではない**	0	0.0％	**令和 8 年 9 月 24 日にすべて解消した。**サービス見込量・給付費・標準給付費・地域支援事業費・保険料基準額・所得段階別保険料率（13 段階）・必要利用定員総数・地域支援事業の量・認知症高齢者数まで算定済み
【決定後に記載】	町または国の意思決定を待つもの。データではない	21	11.4％	国の基本指針、第 1 号被保険者負担割合を定める政令、協議会・パブリックコメントの日程、施設整備の予定、委員名簿・策定経過・パブリックコメントの結果
【見える化出力待ち】	地域包括ケア「見える化」システムから取得できるが、まだ出力していないもの	5	2.7％	**見える化システムから出力する。**将来推計総括表は仕様書 4(2)が求める成果でもあり、入力作業とあわせて行う

これまでに解消した主なものは次のとおりです。

【表 3】本素案について　未確定箇所の凡例（2）

箇所	解消前	解消後	出所
第 2 章 3　認定者数・受給者数・給付費の実績	見える化の値のみ	令和 3〜7 年度の 5 年分が確定	年報 様式 1・様式 1 の 5・様式 1 の 6・様式 2
第 2 章 4　保険料収納状況・保険給付支払状況	【町データ待ち】	令和 3〜7 年度が確定。第 9 期の見込みとの対比も作成	年報 様式 3
第 2 章 5　町内の定員	【見える化出力待ち】	令和 7 年度の定員が確定。見込量との突合も実施	見える化 D 25〜D 27
第 2 章 6　被保険者数・認定者数の見込み	【見える化出力待ち】39 箇所	**全て確定**	第 10 期将来推計用推計人口
第 5 章③　サービス見込量	【算定後に記載】	**回数・日数ベースで確定**	年報 様式 2＋国保連月報（サービス種類別給付状況その 2・日数）
第 5 章③　給付費・標準給付費・保険料	【算定後に記載】	**保険料基準額月額 6,053 円まで算定**	年報 様式 2・様式 4＋第 9 期計画の公表値からの逆算
第 2 章 5　必要利用定員総数	記載なし（法定記載事項の欠落）	**地域密着型 3 サービスについて各年度の必要利用定員総数を設定**	介護保険法 117 条 2 項 1 号＋見える化 D 25〜D 27
第 2 章 6　認知症高齢者数の見込み	記載なし	**自立度Ⅱ以上の下限を算定（令和 9 年度 335 人）**	見える化（自立度）＋認定者数の見込み
第 5 章③　地域支援事業の量の見込み	記載なし（法定記載事項の欠落）	**介護予防・生活支援サービス事業の 3 事業を算定**	介護保険法 117 条 2 項 2 号＋国保連月報（総合事業 A 1〜A F）
第 5 章③　所得段階別保険料率	【算定後に記載】5 箇所（第 1〜4 段階と第 5 段階以上のみ）	**13 段階すべてについて乗率・年額・被保険者数・構成比を算定**	年報 様式 1（所得段階別）令和 7 年度末
第 5 章③　認知症施策	認知症施策推進大綱の 5 本柱で整理	**認知症基本法第 14〜21 条の基本的施策に組み替え**	共生社会の実現を推進するための認知症基本法

※ 見える化システムの指標リスト（991 指標）と突合した結果、次の項目については同システムに該当する指標が存在しないことを確認しました。特定健診等の健診関連、地域包括支援センターの相談件数、個別避難計画・福祉避難所、要介護度の

維持・改善率、老人クラブ会員数。一方、認知症サポーター養成、認知症カフェの箇所数、協議体、地域ケア会議、介護給付適正化については同システムに指標があるため、追加出力で解消します。

目次

【表 4】目次

章	節
第 1 章　計画策定にあたって	1 計画策定の趣旨／2 第 10 期計画の基本指針／3 計画の位置づけと期間／**4 計画策定の視点／5 日常生活圏域の設定／6 計画の進行管理・推進体制（推進体制・毎年度の点検項目）**／7 計画の策定体制
第 2 章　小野町の高齢者・介護等の状況	1 人口と世帯の状況／2 令和 7 年度調査のまとめ／3 小野町の介護保険事業の状況／4 介護保険財政の状況／5 サービス提供体制の状況／6 高齢者数等の将来推計／7 第 10 期計画における課題の整理
第 3 章　第 9 期計画の実施状況と評価	**1 第 9 期計画の基本目標と達成状況／2 地域支援事業の実績／3 介護保険事業の実績／4 第 9 期の評価と第 10 期への課題**
第 4 章　計画の基本的考え方	1 計画の基本理念と目標／2 計画の体系／3 関連計画との役割分担
第 5 章　施策の展開	基本目標 1 介護予防と生きがいづくりの推進／基本目標 2 安全・安心な暮らしの確保／基本目標 3 介護サービスの充実
第 6 章　介護保険事業等の見込み	**1 要介護認定者数の見込み／2 サービス見込量／3 給付費の見込み／4 地域支援事業／5 第 1 号被保険者の保険料／6 人材の供給制約からみた妥当性／7 見える化システムとの突合／8 介護施設整備に係る基本方針と必要利用定員総数／**9 老人福祉事業の量の目標**／10 低所得者支援／11 中長期の見通し／12 将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策**
資料編	策定経過／委員名簿／パブリックコメントの結果／令和 7 年度調査の概要／統計資料／認知症施策推進基本計画との対応表／用語解説／成果指標の定義／年次評価の様式／施策の見直しの基準／主な参照資料／図表番号一覧

第 1 章　計画策定にあたって

1　計画策定の趣旨

本町では、令和 6 年 3 月に「小野町高齢者保健福祉計画・第 9 期介護保険事業計画」を策定し、「健康で自分らしく暮らせるまち」を基本理念として、介護予防と生きがいづくりの推進、安全・安心な暮らしの確保、介護サービスの充実の 3 つの基本目標のもとに施策を進めてきました。

この間、本町の高齢化率は令和 6 年の 39.4％から令和 8 年には 41.1％に達する見込みであり、総人口が減少する一方で高齢者の割合は高まり続けています。要支援・要介護認定者数は平成 30 年 9 月末の 700 人から令和 7 年 7 月 31 日の 953 人へ 8 年間で 36.1％増加し、認定率も 24.4％から 27.3％へ一貫して上昇しました（いずれも 9 月末／10 月 1 日を基準日とする系列）。**ただし令和 8 年 3 月末は 792 人と前年から 152 人減っており、この減少が令和 7 年 9 月審査分の 1 か月に集中していることから、認定の計上方法の変更による可能性を町とともに確認しています（第 2 章 1）。**

また、高齢者のみで暮らす世帯が増え、支える側である家族介護者の高齢化も進んでいます。令和 7 年度に実施した在宅介護実態調査では、主な介護者の 69.8％が 60 歳以上であり、前回調査の 65.2％から 4.6 ポイント上昇しました。一方で、働きながら介護をしている方が 46.5％と前回の 25.0％から大きく増え、介護を理由に離職・転職した家族・親族がいる世帯が 12.9％ありました。

こうした状況を踏まえ、令和 9 年度から令和 11 年度までを計画期間とする「小野町高齢者保健福祉計画・第 10 期介護保険事業計画」を策定します。第 9 期計画の評価を行い、令和 7 年度調査の結果と介護給付費等の分析結果に基づいて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるための施策の方向を定めます。

2　第 10 期計画の基本指針

介護保険事業計画は、国が定める基本指針に即して策定します。第 10 期計画において特に踏まえるべき事項は次のとおりです。

【表 5】第 1 章 2　第 10 期計画の基本指針

事項	内容	本計画での対応
認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画	共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づき、市町村は認知症施策推進計画を策定するよう努めることとされている	**本計画に包含する。**第 5 章 基本目標 2③ に位置づけ、資料編に対応表を掲載する
地域包括ケアシステムの深化・推進	医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制の構築	第 5 章の全体に反映。特に在宅医療・介護連携と生活支援体制整備
介護人材の確保と生産性の向上	ICT・介護テクノロジーの導入、業務改善、文書負担の軽減	第 5 章 基本目標 2⑥
給付と負担の見直し	制度改正の内容を保険料算定に反映する	第 5 章 基本目標 3③
地域共生社会の実現	重層的支援体制整備事業、属性を問わない相談支援	**第 3 期地域福祉計画が担う。**本計画は介護保険制度に基づく具体化に集中する。本町での重層的支援体制整備事業の実施の有無は【町データ待ち】

※ 国の基本指針の最終的な内容は【決定後に記載】。示され次第、本節及び関係する施策に反映します。

第 10 期計画について、国は次の点を特に求めています。

【表 6】第 1 章 2　第 10 期計画の基本指針（2）

国が求めていること	内容	本計画での対応
2040 年等の中長期を見据	3 年間のサービス見込量だけでな	**第 6 章 11 に、令和 22 年・令和 32 年の認定者数・給付**

えた見込量	く、2040 年（令和 22 年）等の中長期を見据えて計画を定めること	**費・第 1 号被保険者 1 人当たりの負担の見通しを置いた**
中山間・人口減少地域への対応	人口減少が進む地域で、サービスの提供をどう維持するか	**第 5 章 基本目標 1②（多様な担い手）、第 6 章 6（人材の供給制約からみた見込量の妥当性）**
医療・介護連携	在宅医療・介護連携推進事業の深化	**第 5 章 基本目標 2⑦（4 つの場面ごとの目指すべき姿）**
高齢者向け住まい	サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等の把握と、介護サービスの提供体制との関係の整理	本町の該当施設は【町データ待ち】。第 2 章 5 で把握する。**福島県高齢者居住安定確保計画も、市町村に対し「各々の住まいの役割に応じた必要量の把握と供給量の調整」を求めている（第 1 章 3）**
人材確保・生産性向上・経営改善支援	ICT・介護テクノロジーの導入、業務改善、文書負担の軽減、事業所の経営状況の把握	**第 5 章 基本目標 2⑥。ただし事業所調査を実施していないため、経営状況は把握できていない**

介護保険法そのものの改正については、公布されている内容を確認したうえで本節に加えます。確認すべき事項は次のとおりです。

【表 7】第 1 章 2　第 10 期計画の基本指針（3）

確認すること	本計画のどこに効くか	状況
第 1 号被保険者負担割合（政令）	**保険料基準額。1 ポイントで月額 269 円動く**	**第 10 期の政令の公布状況を確認中。本計画は 23％で算定している**
介護報酬の改定率	**サービス単価、総給付費、保険料基準額**	**令和 8 年 12 月から令和 9 年 1 月に示されるのが通例。本計画は令和 7 年度の単価で固定し、実績の趨勢で置いた場合の幅を第 6 章 5 に注記している**
給付と負担の見直し	利用者負担割合、高額介護サービス費の上限、多床室の室料負担、第 5 章 基本目標 3③	【町データ待ち】
地域支援事業の見直し	総合事業の類型、介護予防ケアマネジメントの類型、第 5 章 基本目標 1	**令和 6 年 8 月 5 日の地域支援事業実施要綱等の改正により、介護予防ケアマネジメント B・C で一部の省略・簡略化が可能になっている（本町は現在 A のみ）**
医療計画・医療介護総合確保の計画との整合	在宅医療の体制、病床の機能分化との接続、第 5 章 基本目標 2⑦	**福島県の医療計画及び介護保険事業支援計画（第 10 期）との整合は、県計画の公表後に照合する（【町データ待ち】）**
社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第 51 号）	**計画の記載事項そのものが増える。**①介護サービス量の中長期的な推計（第 6 章 11）②将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策（第 6 章 12）③医療と介護の連携の状況・有料老人ホーム等の入居定員の勘案（第 2 章 5・第 6 章 2）	**原則 令和 9 年 4 月 1 日施行。本計画の期間の初日に当たる。本計画は①〜③を反映済み。推計の年次と方法は県へ照会している**
同（適用の可否を確かめるもの）	特定地域サービス・特定地域居宅サービス等事業（中山間・人口減少地域）、有料老人ホームの登録制度・登録施設介護支援	**対象地域は、人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定める（介護保険法第 42 条第 1 項第 3 号）。**国の基準の素案では、特別地域加算等の対象地域（市町村の全部指定・一部指定とも）を基準に含めることとされている。**本町は、国の対象地域の一覧に「振興山村・一部指定」として載っている**（旧夏井村の区域。山村振興法第 7 条第 1 項）。**このため、旧夏井村の区域が対象となる見込みである。町全域ではない**（障がい福祉の特定地域は要件が異なり、過疎地域を含むため町全域が対象となる見込み。障がい福祉計画 第 3 部第 3 章）。基準は省令で定まり、指定は町の意向を踏まえて県が行う（【決定後に記載】）

民法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第 45 号）	成年後見制度。後見・保佐を廃止し補助に一元化。家庭裁判所が市町村長等に本人の状況について意見を求められる。第 5 章 基本目標 3③	**令和 8 年 6 月 24 日公布。公布から 2 年 6 月を超えない範囲内の政令で定める日。本計画の期間中に施行される。現行制度として断定せず、施行に備えた体制整備として書く**
介護支援専門員の更新制の廃止・法定研修の見直し	介護支援専門員の負担、第 5 章 基本目標 3②	**令和 8 年法律第 51 号。公布後 1 年 6 月以内の政令で定める日。本計画の期間中に施行される**

※ 本節の記載は、公布・公表が確認できた事項に限っています。**確認できていない改正内容を先取りして書くことはしていません。**公布・公表され次第、本節と関係する施策・算定に反映します。

3　計画の位置づけと期間

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 に基づく市町村老人福祉計画と、介護保険法第 117 条に基づく市町村介護保険事業計画を一体のものとして策定するものです（**同条第 7 項（改正後第 8 項）**が、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成することを**義務**としています）。また、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和 5 年法律第 65 号）**第 13 条第 1 項**に基づく**市町村認知症施策推進計画**を包含します。

※ 同項は、市町村が国の認知症施策推進基本計画（都道府県計画が策定されているときは両方）を基本とするとともに、当該市町村の実情に即した市町村認知症施策推進計画を**策定するよう努める**こととしています（努力義務）。**同条第 2 項は、市町村計画が市町村地域福祉計画・市町村老人福祉計画・市町村介護保険事業計画その他認知症施策に関連する計画と調和が保たれたものでなければならないと定めています。**本計画は、これらを一体又は包含する形で策定することによりこの要請を満たします。※ 福島県の認知症施策推進計画の策定状況は【町データ待ち】。

計画期間は令和 9 年度から令和 11 年度までの 3 年間です。

※ 認知症基本法第 13 条第 3 項が準用する第 12 条第 6 項は、市町村計画について少なくとも 5 年ごとの検討を求めています。本計画は 3 年を一期とするため、この要請は計画の更新により満たされます。

【表 8】第 1 章 3　計画の位置づけと期間

計画	期間	本計画との関係
小野町総合計画	町の最上位計画	基本理念・まちづくりの方向との整合
小野町第 3 期地域福祉計画	令和 8〜12 年度	**福祉分野の最上位計画。**成年後見制度の利用促進、高齢者虐待防止、災害・感染症対応、地域の支え合いを担う（第 4 章 3 参照）
おのまち障がい者計画・障がい福祉計画	令和 9〜11 年度	障がいのある高齢者、65 歳到達時の制度移行
小野町こども計画	—	ヤングケアラー、家族介護における若年者の状況
小野町地域公共交通計画	—	**移送・外出支援。**通院・買物・通いの場への移動手段の確保
小野町地域防災計画	—	避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所
小野町過疎地域持続的発展計画	—	拠点整備、情報化、交通等の財源接続
福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画	令和 9〜11 年度	施設整備の広域調整、県事業の活用
福島県高齢者居住安定確保計画	**令和 4〜8 年度**	**高齢者住まい法第 4 条に基づく県の計画。**高齢者の住まいの確保、住宅改修、サービス付き高齢者向け住宅・老人ホームの供給。**同計画は、主語が書かれていない文の主語を県及び市町村としており、本町に直接及びます**
福島県住生活基本計画	令和 4〜13 年度	住生活基本法に基づく県の計画。上記の上位計画
福島県賃貸住宅供給促進計画	—	**住宅セーフティネット法第 5 条に基づく県の計画。**住宅確保要配慮者（高齢者を含む）への賃貸住宅の供給
福島県保健医療計画（第八次）・地域医療構想	令和 6〜11 年度	**3 課長連名通知が整合を求めるもの**（法律上の義務ではありません。下記の※を参照）。在宅医療の体制、病床の機能分化・連携（第 5 章 基本目標

		2⑦）。**本町は県中医療圏**（郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）**に属します**

※ 本計画が求められる関係は 2 種類あります。 介護保険法第 117 条第 10 項（改正後第 11 項）は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第 5 条第 1 項の市町村計画に対して整合性の確保を、同条第 11 項（改正後第 12 項）は、市町村地域福祉計画（社会福祉法第 107 条第 1 項）・市町村高齢者居住安定確保計画（高齢者住まい法第 4 条の 2 第 1 項）その他の計画に対して調和を求めています。※ 医療計画（医療法第 30 条の 4 第 1 項）との整合性の確保は、第 118 条第 10 項が都道府県介護保険事業支援計画に求めるもので、市町村介護保険事業計画の法律上の義務ではありません。第 117 条には「医療計画」の語が 1 度も現れません（現行条文・e-Gov 法令 API 令和 8 年 10 月 19 日取得で確認）。**本計画が県保健医療計画との整合を図るのは、下記の 3 課長連名通知によるものです。国の基本指針は、調和を保つ相手方として、市町村地域福祉計画・市町村賃貸住宅供給促進計画・市町村障害福祉計画・市町村健康増進計画・生涯活躍のまち形成事業計画を挙げています。**※ 本町が市町村高齢者居住安定確保計画・市町村賃貸住宅供給促進計画・医療介護総合確保促進法第 5 条第 1 項の市町村計画を定めているかは【町データ待ち】。**※ 地域医療構想は、現行では医療計画の一部ですが（医療法第 30 条の 4 第 2 項第 7 号）、令和 9 年 4 月 1 日からは県が医療計画とは別に定める「将来の医療提供体制に関する構想」に改まります（改正後の同法第 30 条の 3 の 3 第 1 項）。**県の新たな地域医療構想が示された段階で第 5 章 基本目標 2⑦ に反映します（【決定後に記載】）。**※ 福島県高齢者居住安定確保計画は令和 8 年度で計画期間が満了し、本計画の期間の初日には現行計画が存在しません。**改定の時期と内容を県に確かめています（【町データ待ち】）。

資料：福島県高齢者居住安定確保計画（令和 4 年 3 月・福島県土木部）。整合性の確保の方法は「医療計画及び介護保険事業（支援）計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」（令和 8 年 7 月 14 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長・老健局介護保険計画課長・保険局医療介護連携政策課長連名通知）による。

4　計画策定の視点

本計画は、次の 6 つの視点に立って策定します。いずれも第 9 期計画の評価と令和 7 年度調査から導いたものです。

【表 9】第 1 章 4　計画策定の視点

視点	内容
① 中長期の時間軸	**3 年間の事業量だけでなく、令和 22 年（2040 年）に向けた人口・需要・供給の変化を示します。**本町の生産年齢人口は令和 2 年の 4,677 人から令和 32 年の 2,399 人へ半減する一方、認定者数は横ばいで推移する見込みです（第 2 章 7）
② 需要と供給の分離	**利用実績だけでは需要を測れません。**在宅の要介護認定者の 42.1％がサービスを利用していない一方、その理由の上位は需要側のものです（第 2 章 2）。「使われていない」ことと「足りていない」ことを区別します
③ 供給の空白の可視化	**給付がないことと、事業所がないことは違います。**町内に事業所がないサービスを明らかにし、町外の事業所による給付で足りているかを自給率で確かめます（第 2 章 5）
④ 本人・家族の生活成果	活動の件数だけでなく、在宅生活の継続、介護者の負担、支援への接続、社会参加といった住民の状態の変化で評価します
⑤ 活動と成果の対応	施策ごとに、投入（何をするか）、活動量（どれだけ行ったか）、住民の状態（どう変わったか）を対応させて記述します。成果指標は第 5 章の各施策に置きます
⑥ 実行可能性	**人材が足りないことを前提に組み立てます。**介護職員の必要数に対する供給の見通し（第 5 章 基本目標 2⑥）を踏まえ、既存の資源の活用、業務の効率化、広域での利用を組み合わせます
⑦ 地域の類型	**国の基本指針の案は、「大都市部」「中山間・人口減少地域」「一般市等」の地域の類型を念頭に、「時間軸」「地域軸」の両面から計画を立てることを求めています。** 本町は、総人口 8 千人台で人口の減少が続き、町全域が過疎地域、旧夏井村の区域が振興山村であることから、**「中山間・人口減少地域」の類型に当たります。** 地域の現状は、基本指針の案の別表 1 の指標を参考に把握します（資料編 12）

5　日常生活圏域の設定

介護保険法第 117 条第 2 項第 1 号は、市町村が、住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して区域（日常生活圏域）を定めることとしています。

本町は、町全域を 1 つの日常生活圏域とします。第 9 期計画から変更はありません。

【表 10】第 1 章 5　日常生活圏域の設定

勘案する条件	本町の状況	判断
地理的条件	町の面積 【町データ待ち】。役場、公立小野町地方綜合病院、保健センター、地域包括支援センターはいずれも中心部にある。**なお、本町には山村振興法第 7 条第 1 項の振興山村（旧夏井村の区域）がある**	**分割する地理的な必然性は乏しい**
人口	総人口 8,378 人（令和 8 年・推計）、第 1 号被保険者 3,443 人（令和 8 年 3 月末・年報 様式 1）。要支援・要介護認定者は 792 人（同）	**圏域を分けると、1 圏域あたりの認定者数が統計として扱えない規模になる**
交通事情	町内は自家用車による移動が中心で、ニーズ調査では主な移動手段を「自動車（自分で運転）」とする方が 73.2％。公共交通の運行状況は 【町データ待ち】	**日常生活の移動は町内で完結しており、圏域をまたぐ移動を前提とする必要がない**
サービス提供施設の整備状況	地域密着型サービスを含め、事業所は町内に分散しておらず中心部に集まる。特別養護老人ホーム・認知症対応型共同生活介護はいずれも町内 1 か所	**施設を圏域ごとに配置する規模にない**

※ 総人口は第 2 章 1 の推計による。第 1 号被保険者数・認定者数は介護保険事業状況報告（年報）様式 1（令和 8 年 3 月末現在）による。※ 移動手段の割合は令和 7 年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（複数回答・n=1,835）による。※ 町の面積と町営バス・デマンド型交通の運行状況は確認中です（【町データ待ち】）。

このため、本計画の統計・分析、サービス基盤の整備、地域包括支援センターの担当区域は、いずれも町全域を単位とします。地域密着型サービスの必要利用定員総数（第 2 章 5・第 6 章 8）も、町全域を 1 つの区域として定めます。

6　計画の進行管理・推進体制

計画は、立てるだけでなく、毎年度その達成状況を点検し、必要に応じて見直します。本計画では、次の 3 つの層に分けて評価します。

【表 11】第 1 章 6　計画の進行管理・推進体制

層	見るもの	掲載場所
成果指標	住民・利用者の状態の変化、供給の持続性、保険運営の成果	第 5 章の各施策、資料編
活動の指標	個別の事業の実施状況、到達度、質	第 5 章の各施策の主な事業
需給・財政のモニタリング	認定者数・サービス見込量・給付費・保険料の見込みと実績の対比	第 5 章 基本目標 3③、毎年度の協議会資料

評価は、達成・おおむね達成・未達・評価できない の 4 区分で判定します。**未達のときは、需要・供給・人材・制度・実施方法・データのどこに原因があるかを区分し、次年度の対応を定めます。**詳しくは第 6 章に定めます。

(1)　推進体制

本計画の推進にあたっては、町の関係課、地域包括支援センター、介護サービス事業者、医療機関、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、行政区、老人クラブ等の関係機関・団体と連携します。

【表12】第1章6　計画の進行管理・推進体制（2）

主体	役割
町（健康福祉課）	計画の総合的な推進、介護保険事業の運営、関係課との調整
地域包括支援センター	総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメント、認知症施策
介護サービス事業者	質の高いサービスの提供、虐待防止、業務継続計画の整備
医療機関	在宅医療、退院時連携、認知症の早期診断
社会福祉協議会	生活支援体制整備、地域福祉活動、ボランティアの育成
民生委員・児童委員	見守り、相談、行政へのつなぎ
行政区・老人クラブ等	地域活動、通いの場、見守り
小野町高齢者福祉サービス推進協議会	計画の進行管理、施策の評価と提言

また、周知と情報提供にあたっては、住民の情報入手先が広報おのまち85.0％、防災無線51.7％、新聞やテレビ50.6％である一方、公式ウェブサイト7.3％、公式LINE 7.0％にとどまることを踏まえ、**紙媒体と防災無線を軸とした周知**を行います。

(2)　毎年度の点検項目

介護保険法は、市町村が、施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、計画の実績に関する評価を行うものとしています（同法第117条。令和8年法律第51号による改正後は第9項。**改正により第5項が新設されたため、第5項以降の項番号が1つ繰り下がります**）。**評価の対象となるのは、同条第2項第5号に規定する施策と同項第6号に規定する目標です。**第2項に第3号・第4号（中長期的な推計と中長期の施策）が新設されたため、**従前の第3号（施策）・第4号（目標）が第5号・第6号に繰り下がりました。**

本計画は、PDCAサイクルにより進行管理を行います。毎年度、次の項目について現状を把握し、見込量や目標値に対する点検・分析を行い、小野町高齢者福祉サービス推進協議会に報告します。

【表13】第1章6　計画の進行管理・推進体制（3）

点検項目	確認内容	資料
要介護認定者等の推移	要介護度別・年齢階層別の認定者数、認定率、認定審査の運用	介護保険事業状況報告、町の認定データ
介護保険給付費の状況	サービス別給付費・受給者数、見込量との乖離、供給の状況	給付実績、見える化システム
地域支援事業の進捗状況	総合事業、包括的支援事業、任意事業の事業別実績。**特に通いの場の実施箇所・参加者数**	事業実績、決算
介護給付適正化の進捗状況	要介護認定の適正化、ケアプランの点検、縦覧点検・医療情報との突合	適正化事業の実施報告
介護保険財政の状況	**歳入歳出、介護給付費準備基金の残高と取崩、繰越金、保険料収納率**	決算、基金の状況
成果指標の進捗	**第5章に設定した成果指標の達成状況**	事業実績、次期調査
認知症施策の実施状況	**第5章③に掲げた施策の実施状況。初期集中支援チームの対象者の把握、推進員の活動、カフェ、相談窓口の認知度**	事業実績、見える化システム、次期調査
保険者機能強化推進交付金等の評価結果	**評価指標に対する本町の該当状況と得点、全国・県内での位置。得点していない項目について、取組の水準によるものか事業に**	厚生労働省の評価結果、町の得点票

	着手していないことによるものかを分けて確認する	

※ 保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の評価指標は、**計画の進捗状況のモニタリング結果を外部の関係者を含む議論の場で検証すること**、**評価結果を関係者間で共有して自立支援等に資する取組を検討すること**を求めています。評価結果を協議会にお諮りすること自体が評価の要件にあたるため、毎年度の協議会資料として報告し、検証します。**なお、評価年度と交付年度は 1 年ずれるため、本計画に基づく取組が最初に評価に現れるのは令和 10 年度の交付金です。**

※ 認知症施策の実施状況を独立した点検項目としました。**認知症基本法第 13 条第 3 項が準用する第 12 条第 5 項は、市町村計画に基づいて実施する施策の実施状況の評価を適時に行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めることを求めています。**同条第 7 項により、評価結果の取りまとめにあたっては認知症の人及びその家族等の意見を聴くよう努めることとされています。本町では、毎年度の点検結果を協議会に報告するとともに町ホームページで公表します。

※ 第 9 期計画の点検項目（要介護認定者等の推移、介護保険給付費の状況、介護給付適正化計画の進捗状況、地域支援事業の進捗状況）に加え、**介護保険財政の状況と成果指標の進捗を新たに点検項目としました。**第 9 期の評価にあたり、財政面（繰越金・基金）の状況が計画の点検項目に含まれていなかったことが課題として明らかになったためです。

7　計画の策定体制

本計画の策定にあたり、「小野町高齢者福祉サービス推進協議会」を設置し、保健・医療・福祉の関係者、被保険者の代表等の意見を聴きながら検討を進めます。また、令和 7 年度に介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査を実施し、高齢者の生活実態と意向を把握しました。計画案については、パブリックコメントを実施し、町民の意見を反映します。

庁内では、介護保険・高齢者福祉の担当を事務局とし、関係する担当と連携して検討します。関係する担当と、それぞれが関わる事項は下表のとおりです。庁内の会議の名称・構成・開催予定は【決定後に記載】。

【表 14】第 1 章 7　計画の策定体制

関係する担当	関わる事項	本計画での位置
保健（健康づくり）	健康増進計画、特定健診、一体的実施	第 4 章 3、第 5 章 基本目標 1①・②
障がい福祉	障がい福祉計画との接点、共生型サービス	第 4 章 4
地域福祉	第 3 期地域福祉計画、重層的支援体制整備事業	第 4 章 3
住宅	**有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の入居定員の把握、県の高齢者居住安定確保計画との調和、公営住宅**	第 1 章 3、第 2 章 5、第 6 章 2
防災	避難行動要支援者名簿、個別避難計画、福祉避難所	第 5 章 基本目標 2④
企画（公共交通）	町営バス・デマンド型交通、移送・外出支援	第 1 章 5、第 5 章 基本目標 2⑤

あわせて、介護保険法第 117 条第 14 項の規定により、本計画のうちサービスの種類ごとの量の見込み・地域支援事業の量の見込み及び中長期的な推計（第 6 章 2・第 6 章 4・第 6 章 11）を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ福島県の意見を聴きます。改正前から量の見込みについて意見を聴くことが求められており、**令和 8 年法律第 51 号により中長期的な推計が対象に加わりました**（令和 9 年 4 月 1 日施行）。また、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく県に提出します。

意見を聴く時期と様式は県に確認しています（【町データ待ち】）。確認のうえ、下表の策定の経過に加えます。

【表 15】第 1 章 7　計画の策定体制（2）

区分	内容
小野町高齢者福祉サービス推進協議会	開催回数・時期 【決定後に記載】
庁内の検討体制	会議の名称・構成・開催予定 【決定後に記載】

福島県への意見聴取（介護保険法第117条第14項）	時期 【町データ待ち】
令和7年度調査	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（配布2,700件・回収1,835件・回収率67.9％）、在宅介護実態調査（配布500件・回収319件・回収率63.8％）。いずれも郵送により令和7年11月～12月に実施
パブリックコメント	実施時期 【決定後に記載】

第 2 章　小野町の高齢者・介護等の状況

1　人口と世帯の状況

本町の人口は減少を続ける一方、高齢化率は上昇しています。

【表 16】第 2 章 1　人口と世帯の状況

区分	令和 6 年	令和 7 年	令和 8 年	令和 12 年
総人口（人）	8,868	8,620	8,378	7,426
年少人口（0〜14 歳）	736	675	612	414
生産年齢人口（15〜64 歳）	4,640	4,471	4,323	3,666
高齢者人口（65 歳以上）	3,492	3,474	3,443	3,346
前期高齢者（65〜74 歳）	1,691	1,672	1,633	1,460
後期高齢者（75 歳以上）	1,801	1,802	1,810	1,886
高齢化率	39.4％	40.3％	41.1％	45.1％
後期高齢者の割合	20.3％	20.9％	21.6％	25.4％

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計

高齢者人口そのものは令和 6 年の 3,492 人から令和 12 年の 3,346 人へ緩やかに減少しますが、後期高齢者は 1,801 人から 1,886 人へ増加します。**支援を必要とする層が増える一方、支える側の生産年齢人口は 4,640 人から 3,666 人へ 21.0％減少します。**

高齢者のいる世帯の状況は次のとおりです。

【表 17】第 2 章 1　人口と世帯の状況（2）

区分	平成 22 年	平成 27 年	令和 2 年
高齢独居世帯の割合	9.1％	10.0％	12.6％
高齢夫婦世帯の割合	7.7％	8.8％	10.3％
高齢者 1 人あたり現役世代数	2.1 人	1.8 人	1.5 人

資料：国勢調査（見える化システムによる）

令和 7 年度の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、「1 人暮らし」が 15.7％、「夫婦 2 人暮らし（配偶者 65 歳以上）」が 28.4％で、**高齢者のみの世帯が 44.1％を占めています。**

※ 本節の人口は見える化システムの将来推計（暦年）であり、本章 6 の被保険者数の見込み（第 10 期将来推計用推計人口・年度）とは出所が異なります。高齢者人口でみると令和 6 年 3,492 人に対し令和 6 年度 3,465 人、令和 7 年 3,474 人に対し令和 7 年度 3,460 人、令和 8 年 3,443 人に対し令和 8 年度 3,449 人で、差は最大 27 人（0.8％）です。**サービス見込量と保険料の算定には、本章 6 の第 10 期将来推計用推計人口を用いています。**第 10 期将来推計用推計人口は年少人口・生産年齢人口の内訳を含まないため、人口構造の全体像は本節の系列で示しています。※ このほか、第 3 期地域福祉計画は住民基本台帳を基礎としたコーホート変化率法により人口を推計しており、令和 8 年の総人口を 8,520 人としています。本節の推計とは総人口で 120〜196 人、高齢者人口で最大 53 人の差が生じます。

2　令和 7 年度調査のまとめ

令和 7 年 11 月から 12 月にかけて、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査を実施しました。主な結果は次のとおりです。詳細は「令和 7 年度調査 集計結果・分析報告書」によります。

（1）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（n=1,835）

要介護状態になるリスクの該当率は次のとおりです。

【表 18】第 2 章 2　令和 7 年度調査のまとめ

リスク項目	令和 7 年度	前回（令和 4 年度）	増減
認知機能の低下	47.9％	50.1％	▲2.2pt
社会的役割の低下	47.7％	50.4％	▲2.7pt
知的能動性の低下	41.5％	41.5％	±0
うつ傾向	38.3％	40.2％	▲1.9pt
転倒リスク	**36.5％**	35.8％	**＋0.7pt**
口腔機能の低下	27.5％	31.1％	▲3.6pt
閉じこもり傾向	24.1％	30.0％	▲5.9pt
運動器機能の低下	14.6％	17.4％	▲2.8pt
IADL の低下	12.3％	13.8％	▲1.5pt
低栄養傾向	1.1％	0.9％	＋0.2pt

10 項目のうち 6 項目が 1.0 ポイント以上低下しました。**ただし回収率が 77.7％から 67.9％へ 9.8 ポイント低下しているため、改善と断定することはできません。**増加したのは転倒リスク（＋0.7 ポイント）と低栄養傾向（＋0.2 ポイント）です。

認知機能の低下は 65〜69 歳の時点ですでに 39.1％が該当し、85 歳以上では 53.1％となります。IADL の低下は 65〜69 歳の 4.4％から 85 歳以上の 37.2％へ 8.5 倍になります。

その他の主な結果は次のとおりです。

【表 19】第 2 章 2　令和 7 年度調査のまとめ（2）

区分	項目	結果
社会参加	介護予防のための通いの場への参加（週 1 回以上）	5.5％
	同（年数回以上を含む）	13.8％
	同（参加していない）	76.2％
	地域活動に参加者として参加する意向	50.9％
	地域活動に企画・運営者として参加する意向	32.0％
	介護予防事業への参加の条件：開催場所・時間	63.7％
外出	主な移動手段：自動車（自分で運転）	73.2％
	外出を控えている	19.8％（理由：足腰などの痛み 57.0％、交通手段がない 17.6％）
	昨年と比べ外出回数が減っている	29.7％
認知症	認知症に関する相談窓口を知っている	**33.2％**
	同（知らない）	60.0％
	地域で支えるために必要なこと：地域での見守りや声掛け	54.1％
	同：認知症に関する情報提供	51.9％
生きがい	生きがいが「思いつかない」	36.5％
相談	家族や友人・知人以外に相談する人がいない	38.0％
災害	災害時に一人で避難できない	**14.2％**（高齢者人口換算で約 495 人）
	災害時に助けてくれる人がいない	11.3％（同 約 394 人）

（2）在宅介護実態調査（n=366）

【表 20】第 2 章 2　令和 7 年度調査のまとめ（3）

区分	項目	結果	前回（令和 5 年度）
属性	85 歳以上	61.4％	—
	要支援 1・2	45.3％	—
	単身世帯	23.5％	—
利用	**介護保険サービスを利用していない**	**42.1％**	—
未利用理由	現状では、サービスを利用するほどの状態ではない	**46.8％**	—
	本人にサービス利用の希望がない	**29.2％**	—
	家族が介護をするため必要ない	**16.9％**	—
	利用したいサービスが利用できない、身近にない	0.6％	—
必要な支援	移送サービス（介護・福祉タクシー等）	20.8％（最多）	21.2％（最多）
	外出同行（通院、買い物など）	15.6％	15.6％
施設	**入所・入居を検討または申込済み**	**24.0％**	—
介護者	**60 歳以上**	**69.8％**	65.2％
	就労している（フルタイム+パートタイム）	**46.5％**	25.0％（n=24）
	介護を理由に離職・転職した家族・親族がいる	**12.9％**	—
	不安に感じる介護：認知症状への対応	33.0％（最多）	36.7％（最多）
	仕事と介護を続けていくのは難しい	16.2％（n=86）	16.7％（n=6）

資料：令和 7 年度調査結果報告書（町から受領した原本・104 頁）。**本素案に載せている集計値は、1 件ずつ同報告書と突き合わせて確かめたものです。**※ 在宅介護実態調査は、同報告書 p.2 の配布・回収の表では回収数 319 件ですが、集計の基数はすべて 366 です（問 8 の内訳も 利用 203 人＋未利用 154 人＋無回答 9 人＝366）。**この食い違いは町を通じて調査の実施事業者に確認中であり、本素案は集計値との整合を優先して 366 を採っています。**※ 介護予防のための通いの場（同報告書 p.25）は、本文が「67.2％は参加していない」、図が 76.2％となっています。内訳の合計（0.7＋1.4＋3.4＋3.8＋4.5＋76.2＋10.0）が 100.0％で合うことから、本素案は 76.2％を採っています。※ 同報告書 p.84 のまとめでは、仕事と介護の両立に効果があると思う支援の項目名が重複しています（同 p.81 の図では、25.6％は「労働時間の柔軟な選択」、24.4％が「介護休業・介護休暇等の制度の充実」）。**いずれも町を通じて確認中です。**

3　小野町の介護保険事業の状況

（1）要支援・要介護認定者数の推移

本町の要支援・要介護認定者数は増加を続けてきました。各年 3 月末（年度末）を基準とした推移は次のとおりです。

【表 21】第 2 章 3　小野町の介護保険事業の状況

基準日	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	対前年増減
平成 30 年 3 月末	36	71	139	165	106	89	85	691	▲1
令和元年 3 月末	56	81	134	159	117	91	84	722	＋31
令和 2 年 3 月末	57	95	134	157	114	108	89	754	＋32

令和3年3月末	49	118	151	165	144	134	100	861	**＋107**
令和4年3月末	50	122	137	157	151	151	104	872	＋11
令和5年3月末	54	144	136	158	149	145	112	898	＋26
令和6年3月末	59	149	145	153	166	141	106	919	＋21
令和7年3月末	65	136	161	158	166	143	115	944	＋25
令和8年3月末	70	129	143	125	145	108	72	792	**▲152**

資料：地域包括ケア「見える化」システム。出典は厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（ただし令和7年3月末・令和8年3月末のみ月報）。第1号被保険者と第2号被保険者の合計。**この表と後掲の認定者数の推計（本章5）はいずれも年度末を基準日としています。**年度末基準の認定率（合計÷第1号被保険者数）は、令和4年3月末24.9％、令和5年3月末25.8％、令和6年3月末26.3％、令和7年3月末27.0％、令和8年3月末23.0％です。

年齢階層別の内訳は次のとおりです。

【表22】第2章3　小野町の介護保険事業の状況（2）

基準日	第1号被保険者	65〜74歳	75〜84歳	85歳以上	第2号被保険者
平成30年3月末	680	49	205	426	11
令和元年3月末	711	60	205	446	11
令和2年3月末	746	66	211	469	8
令和3年3月末	846	66	236	544	15
令和4年3月末	861	65	232	564	11
令和5年3月末	885	71	232	582	13
令和6年3月末	907	74	224	609	12
令和7年3月末	935	89	214	632	9
令和8年3月末	783	64	204	515	9

※ 65〜74歳＝第1号被保険者−75歳以上、75〜84歳＝75歳以上−85歳以上として算出。**認定者の8割前後が85歳以上であり、認定者数の動きは後期高齢者、特に85歳以上の動向によって決まる構造です。**

参考として、各年9月末／10月1日を基準とした系列は次のとおりです。第9期計画及び第3期地域福祉計画に掲載されています。

【表23】第2章3　小野町の介護保険事業の状況（3）

基準日	合計	認定率（対第1号被保険者）
平成30年9月末	700	—
令和元年9月末	740	—
令和2年9月末	799	—
令和3年10月1日	861	24.4％
令和4年10月1日	888	25.0％
令和5年10月1日	912	25.7％
令和6年10月1日	937	26.5％
令和7年7月31日	953	27.3％

資料：介護保険事業状況報告（第9期計画及び第3期地域福祉計画の掲載値）。**3月末系列と交互に並べると、令和7年7月31日まで一貫して増加しており、整合しないのは令和8年3月末の1点のみです。※ この系列の基準日は9月末／10月1日であり、年度末を基準日とする上表及び本章5の推計とは基準日が異なります。**したがって、この表の26.5％・27.3％と本章5の22.7％とを直接比べることはできません。年度末基準でそろえると令和7年3月末27.0％→令和8年3月末23.0％であり、**低下の原因は基準日の違いではなく、令和7年9月審査分に生じた認定者数の断層（本節末尾及び本章5の注を参照）です。**

平成19年3月末の519人から令和7年3月末の944人へ、18年間で425人（81.9％）増加しました。**20年の系列で増減が突出しているのは2点のみです。**令和2年度の＋107人（＋14.2％）と、令和7年度の▲152人（▲16.1％）です。他の年の増減幅は▲6人〜＋39人にとどまります。

第9期計画は計画期間中の認定者数を令和6年度869人、令和7年度873人、令和8年度850人と見込んでいましたが、実績はこれを上回って推移しています。

【表24】第2章3　小野町の介護保険事業の状況（4）

区分	令和6年度	令和7年度	令和8年度
第9期計画の推計（人）	869	873	850
実績（人）	937（令和6年10月1日）	953（令和7年7月31日）	—
差	＋68（＋7.8％）	＋80（＋9.2％）	—

※ 令和8年3月末の値（792人）は、令和7年7月31日の953人から8か月で161人（16.9％）減少することになり、上記の一貫した増加傾向と整合しません。県内59市町村の同期間の認定率の変化（平均＋0.30ポイント、標準偏差1.02ポイント）からみても4.3σの外れ値です。**減少の77.0％が85歳以上に集中している一方、85歳以上の中でも重度ほど減少幅が大きい単調なパターンが現れます。**また、令和2年度の＋107人は新型コロナウイルス感染症に伴う要介護認定の有効期間の延長特例（令和2年2月〜）の時期と一致するため、令和2年度に積み上がった認定が令和7年度に一斉に満了した可能性があります。**町の認定台帳による確認を行っています。**

（2）サービス受給の状況

【表25】第2章3　小野町の介護保険事業の状況（5）

区分	平成26年度	令和7年度	変化
合計受給率（在宅サービス）	12.2％	10.3％	▲1.9pt
合計受給率（施設サービス）	3.5％	4.0％	＋0.5pt
合計受給率（居住系サービス）	1.0％	1.4％	＋0.4pt
在宅サービス利用率	59.3％	44.1％	**▲15.2pt**
訪問介護　受給者1人あたり利用回数	10.9回	15.7回	＋4.8回
通所介護　受給者1人あたり利用日数	7.4日	9.3日	＋1.9日
訪問看護　受給者1人あたり利用回数	3.1回	6.8回	＋3.7回

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和7年度は令和8年1月サービス提供分まで）

在宅サービスを利用する人は減り、利用する人は多く利用する、という形に変化しています。施設・居住系の受給率は上昇しており、給付費全体の49.9％を占めています。

（3）全国・県内との比較

【表26】第2章3　小野町の介護保険事業の状況（6）

指標	値	位置づけ
要介護認定率（性・年齢調整後の地域差指	1.24	全国平均を24％上回る。**令和7年3月末の合計認定率**

数）		**26.8％は県内 2 位**
第 1 号被保険者 1 人あたり給付月額（同）	1.08	全国平均を 8％上回る
在宅サービスの給付月額	10,361 円	**県内 28 位／59**
施設・居住系サービスの給付月額	14,113 円	**県内 33 位／59**

認定率は県内でも高い方にある一方、給付月額は県内中位です。認定を受けてもサービス利用に至っていない層が一定数存在することを示しています。

令和 7 年度の在宅介護実態調査では、在宅の要介護認定者の 42.1％が介護保険サービスを利用していませんでした。その理由は「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」46.8％、「本人にサービス利用の希望がない」29.2％、「家族が介護をするため必要ない」16.9％と、**上位 3 つはいずれも需要側の理由です。**供給制約（「利用したいサービスが利用できない、身近にない」）は 0.6％、費用は 3.9％、手続きの分かりにくさは 4.5％にとどまりました。

（4）サービス別給付の状況

サービス種類別の給付費は、収支実績調査票（令和元〜8 年度）により令和 6 年度決算まで確定しています（令和 8 年 10 月 15 日受領。決算状況（歳出）の款 2 の合計と一致）。受給者 1 人あたり給付月額は見える化システムによるもので、次のとおりです。

【表 27】第 2 章 3　小野町の介護保険事業の状況（7）

サービス	受給者 1 人あたり給付月額
認知症対応型共同生活介護	257,430 円（全サービス中最高）
特定施設入居者生活介護	214,417 円
小規模多機能型居宅介護	158,193 円
認知症対応型通所介護	109,004 円
短期入所療養介護	84,916 円
短期入所生活介護	81,071 円
通所介護	78,214 円
訪問介護	48,876 円
訪問看護	40,831 円

4　介護保険財政の状況

介護保険特別会計の歳入歳出は次のとおりです。

【表 28】第 2 章 4　介護保険財政の状況

区分	平成 26 年度	平成 30 年度	令和 2 年度	令和 5 年度
歳入合計	1,115.5	1,295.3	1,459.3	1,468.3
保険料	166.9	252.9	248.9	249.7
繰越金	32.4	49.9	155.9	182.0
歳出合計	1,090.2	1,199.3	1,294.0	1,310.1
保険給付費	1,005.1	1,097.1	1,121.3	1,106.0
地域支援事業	28.4	46.2	47.8	63.4
実質収支（歳入−歳出）	25.3	95.9	165.3	158.2

単位：百万円。資料：介護保険事業状況報告（見える化システムによる）。令和 6 年度以降は【町データ待ち】

実質収支は10年度すべてでプラスであり、繰越金は32.4百万円から182.0百万円へ5.6倍に増加しました。令和5年度の繰越金は同年度の保険給付費の16.5％にあたります。

介護給付費準備基金は、平成26年度以降の10年度で積立が108.0百万円、取崩が19.9百万円であり、差引88.1百万円が純増しています。取崩は平成26年度と平成29年度の2回のみで、令和2年度以降は行われていません。

保険料収入が10年で49.6％増加した一方、保険給付費は10.0％の増加にとどまり、平成29年度をピークにほぼ横ばいで推移しています。この差が繰越金と基金に蓄積しており、令和5年度末時点で270百万円程度の財政的な余力がある計算になります。

【表29】第2章4　介護保険財政の状況（2）

区分	内容
第1号保険料月額	平成30年度以降 6,600円で据置
必要保険料月額（見える化システム）	令和7年度 6,131円
差	現行保険料が必要保険料を469円上回る
第9期の保険料算定	算定値は月額6,886円。介護給付費準備基金3,500万円の取崩により6,597円となり、100円未満切上げで最終的に年額79,200円・月額6,600円とした

※ 第9期が見込んだ基金取崩3,500万円は、行われていません。決算状況（歳入）の介護給付費準備基金繰入金は、**令和2年度から令和8年度まで毎年度0円**です。一方、決算状況（歳出）の介護給付費準備基金積立金は**年3,000万円**（令和6年度のみ0円）で、令和2年度から令和7年度までの積立額は1億5,000万円になります。**第10期に取り崩せる額は基金残高によりますが、残高そのものは受領した資料にないため確認中です。**

5　サービス提供体制の状況

本節は、第6章2の見込量を立てる際に勘案する事項でもあります。社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、**介護保険法第117条第5項**が新たに置かれ、市町村は区域・サービス量の見込み・中長期的な推計を定めるにあたり、次の2つを**勘案しなければならない**こととされました（施行　令和9年4月1日。本計画の期間の初日に当たります）。

・['**第1号**\u3000**本町が定める区域ごと**の、老人福祉法第29条第1項の届出をした有料老人ホーム及び高齢者住まい法第7条第5項の登録住宅（サービス付き高齢者向け住宅）の、**それぞれの入居定員総数。特定施設入居者生活介護等の指定を受けていないものに限られます。**', '**第2号**\u3000**県が定める区域ごと**の、医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者・居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との**連携の状況**。']

2つは区域の単位が異なります。第1号は本町が定める区域（日常生活圏域）ごと、第2号は**県が定める区域**ごとです。

※ 第9期計画（令和6年3月）第4章（1）③は、「老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は…町では県や近隣市町村との連携を強化し、施設の設置状況や介護サービスの提供状況などの把握に努めます」としていました。把握に努める段階であったものが、改正により勘案しなければならないものになります。入居定員総数は、老人福祉法第29条第1項の届出と高齢者住まい法の登録をいずれも**県**が受けるため、県への照会が要ります（【町データ待ち】）。

【表30】第2章5　サービス提供体制の状況

区分	平成27年度	令和元年度	令和4年度	令和7年度
施設サービス定員（人）	50	83	112	112
介護老人福祉施設	50	54	54	54
地域密着型介護老人福祉施設	—	29	58	58
居住系サービス定員（人）	35	35	71	98

認知症対応型共同生活介護	35	35	71	98
通所系サービス定員（人）	155	164	191	191

施設サービス定員は令和元年度から令和 2 年度にかけて 54 人から 112 人へ倍増しました（地域密着型介護老人福祉施設 58 人の整備）。居住系サービス定員は、認知症対応型共同生活介護が令和 4 年度 71 人から令和 6 年度 98 人へ 27 人（38.0％）拡大しています。

一方、在宅サービスの提供体制には縮小がみられます。

【表 31】第 2 章 5　サービス提供体制の状況（2）

区分	従前	直近	評価
居宅介護支援事業所	5 か所	**3 か所**	人口 10 万人あたり事業所数の偏差値 47.84。ケアマネジメント基盤の縮小
訪問看護	—	1 か所	居宅（医療系）サービス事業所数の偏差値 41.49
介護サービス自給率	令和 5 年度 72.43％	令和 7 年度 **67.57％**	町外利用の拡大
施設・居住系	—	59.74％	県内 24 位
短期入所系	—	—	12.5 ポイント低下。町内での受入が縮小

資料：地域包括ケア「見える化」システム（D 25〜D 27）。通所系の合計には小規模多機能型居宅介護の通い（30 人）と宿泊（10 人）を含みます。**※ 認知症対応型共同生活介護の定員は、平成 27〜令和元年度の 35 人から令和 2 年度 53 人、令和 4 年度 71 人、令和 6 年度 98 人へと 3 回にわたって増えており、10 年間で 63 人（1.8 倍）拡大しています。**このうち令和 6 年度の 27 人増は第 9 期計画の期間中にあたります。第 9 期計画は「新規施設整備は原則行わず、地域密着型サービス・居宅サービスの充実を基本とする」方針でしたので、増床の経緯については【町データ待ち】。

介護保険給付によらない住まいの定員（第 117 条第 5 項第 1 号）

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は、介護保険の給付による施設ではありませんが、入居者が居宅サービスを利用するため、**見込量に影響します。** 勘案の対象は**次の 2 類型**で、いずれも**特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けていないもの**に限られます。

【表 32】第 2 章 5　サービス提供体制の状況（3）

勘案の対象（第 117 条第 5 項第 1 号）	町内の施設数	入居定員	うち要介護認定者
① **有料老人ホーム**（老人福祉法第 29 条第 1 項の届出をしたもの）	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】
② **登録住宅**（高齢者住まい法第 7 条第 5 項。サービス付き高齢者向け住宅）	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】

（参考）勘案の対象ではないが、把握しておくもの

【表 33】第 2 章 5　サービス提供体制の状況（4）

区分	町内の施設数	入居定員	扱い
有料老人ホーム（介護付き・特定施設入居者生活介護の指定あり）	【町データ待ち】	【町データ待ち】	**勘案の対象外。** 第 6 章の特定施設の見込量に計上
養護老人ホーム・軽費老人ホーム（措置・契約）	【町データ待	【町データ待ち】	老人福祉法の施設。第 5 章 基本目標 2

	ち】		

町内に該当する施設があるかを含めて町にご確認いただきます（資料提供確認依頼書）。 該当する施設がない場合は「本町には該当する施設がありません」と記載します。**令和8年法律第51号は、あわせて中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームについて都道府県等への登録制度（登録有料老人ホーム）を導入し、入居者の相談支援を行う「登録施設介護支援」を新設します（公布後2年以内・3年以内の政令で定める日）。この登録有料老人ホームは、上記の勘案の対象とは別の制度です。**該当する施設がある場合は、第5章 基本目標2に取扱いを書き加えます。

地域密着型サービスのうち、次の3サービスについては、介護保険法第117条第2項第1号により各年度の必要利用定員総数を定めることとされています。本計画では次のとおり設定します。

【表34】第2章5　サービス提供体制の状況（5）

サービス	町内定員（令和6年度）	令和7年度の利用（人／月）	令和9年度	令和10年度	令和11年度
認知症対応型共同生活介護	98人	45.8	98人	98人	98人
地域密着型特定施設入居者生活介護	0人	0.0	0人	0人	0人
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	58人	40.8	58人	58人	58人

※ 本町は町全域を1つの日常生活圏域とするため、圏域別の区分は生じません。※ 「令和7年度の利用」は本町の被保険者が1月あたりに利用した人数で、町外の事業所の利用を含みます。認知症対応型共同生活介護は介護給付と予防給付の合計です。**※ 認知症対応型共同生活介護は町内定員98人に対し本町の被保険者の利用が月45.7人の見込みであり、定員は制約として働いていません。**施設・居住系サービスの自給率が59.74％であることから、町内の定員の相当部分が町外の方に利用されていることになります。町外利用の割合と増床の経緯については【町データ待ち】。※ 地域密着型特定施設入居者生活介護は町内に事業所がなく、整備の予定もないため0人とします。

6　高齢者数等の将来推計

被保険者数の見込みは、厚生労働省が保険者に配布する第10期将来推計用推計人口（コーホート変化率法。各年10月1日時点）によります。

本町の第1号被保険者数は、計画期間を通じてほぼ横ばいです。令和9年度3,438人から令和11年度3,418人へ20人（0.6％）減るにとどまります。一方で内訳は動き、前期高齢者（65〜74歳）が1,583人から1,524人へ59人減る反面、**75〜84歳は1,150人から1,217人へ67人増えます。**85歳以上は705人から677人へ28人減ります。

総人口が令和9年度8,591人から令和11年度8,232人へ4.2％減るなかで高齢者数が横ばいであるため、高齢化率は40.0％から41.5％へ上昇します。

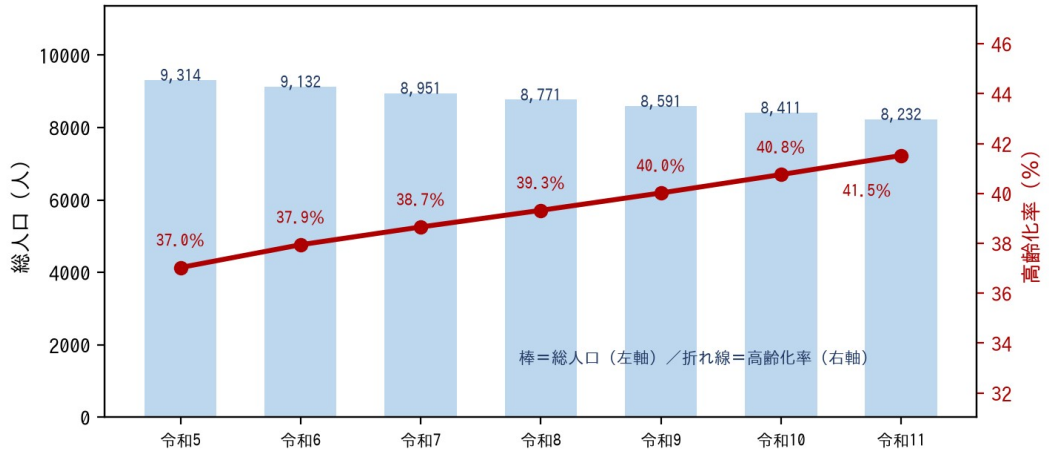
【表35】第2章6　高齢者数等の将来推計

区分	令和7年度（実績）	令和9年度	令和10年度	令和11年度
総人口（人）	8,740	8,591	8,411	8,232
第1号被保険者数（65歳以上）	3,443	3,438	3,428	3,418
前期高齢者（65〜74歳）	1,634	1,583	1,554	1,524
後期高齢者（75歳以上）	1,809	1,855	1,874	1,894
うち75〜84歳	1,090	1,150	1,183	1,217
うち85歳以上	719	705	691	677

高齢化率（％）	39.4	40.0	40.8	41.5
第 2 号被保険者数（40〜64 歳）	—	2,251	2,207	2,163

※ 第 1 号被保険者数の実績は介護保険事業状況報告（年報）様式 1 の年度末現在。推計は第 10 期将来推計用推計人口（各年 10 月 1 日）による。令和 7 年度は年報 3,443 人に対し推計 3,460 人で、差は 0.5％にとどまる。※ 総人口の実績は住民基本台帳による。※ 高齢化率は第 1 号被保険者数÷総人口。

【図 1】総人口と高齢化率の推移・推計



資料：第 10 期将来推計用推計人口（各年 10 月 1 日）。**棒が総人口（左軸）、折れ線が高齢化率（右軸）。総人口が減る一方、高齢化率は上がり続ける。**※ 本図の高齢化率はいずれの年も推計人口による。上の表の令和 7 年度（39.4％）は年報と住民基本台帳の実績によるため、0.7 ポイントの差がある。

要支援・要介護認定者数の推計は次のとおりです。年齢階層別の認定率（令和 7 年度実績。65〜74 歳 3.92％、75〜84 歳 18.72％、85 歳以上 71.63％）を将来の年齢階層別人口に乗じたものです。**推計の対象は第 1 号被保険者であるため、実績側も第 1 号被保険者にそろえています（基準日は各年度末）。**

認定者数はゆるやかに減り、令和 9 年度 782 人から令和 11 年度 772 人となります（▲10 人）。75〜84 歳が増える一方で 85 歳以上が減るためで、認定率の高い 85 歳以上の減少が上回ります。認定率は 22.6〜22.7％で推移します。

【表 36】第 2 章 6　高齢者数等の将来推計（2）

要介護度	令和 8 年 3 月末（実績）	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
要支援 1	70	70	70	69
要支援 2	128	128	127	126
要介護 1	143	142	142	141
要介護 2	125	125	124	123
要介護 3	142	142	141	140
要介護 4	104	104	103	103
要介護 5	71	71	70	70
合計	783	782	777	772
第 1 号被保険者数	3,443	3,438	3,428	3,418
認定率（第 1 号認定者÷第 1 号被保険者）	22.7％	22.7％	22.7％	22.6％

※ 令和 8 年 3 月末の実績は年報 様式 1 の 5 による。**第 1 号被保険者 783 人で、第 2 号被保険者 9 人を加えた総数は 792 人です。**本章 1（2）の年度末系列は総数によるため、同じ令和 8 年 3 月末でも 792 人・認定率 23.0％となります。※ 要介護度別の推計は、令和 8 年 3 月末の第 1 号被保険者の構成比を認定者数の見込みに当て、最大剰余法で合計に一致させたもの。※ 第 1 号被保険者数は、実績が年報 様式 1（年度末現在）、推計が第 10 期将来推計用推計人口（各年 10 月 1 日）による。※ 本表の 22.7〜22.8％と本章 1（2）の 26.5％・27.3％は基準日も被保険者区分も異なるため、直接比べることはできません。※ 地域包括ケア「見える化」システムの自然体推計は、令和 9 年度 849 人・令和 10 年度 850 人・令和 11 年度 841 人としています。**同システムは令和 7 年 9 月の 865 人を基点としており、その後令和 8 年 3 月末の 792 人まで減った動きを織り込んでいないため、本計画では令和 8 年 3 月末の実績と接続する上表の系列を用います。**

認知症高齢者数の見込みは次のとおりです。認定者に占める認知症高齢者（日常生活自立度Ⅱ以上）の割合（令和 8 年 4 月末実績）を認定者数の見込みに乗じたものです。

【表 37】第 2 章 6　高齢者数等の将来推計（3）

区分	令和 8 年 3 月末	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
認定者数（第 1 号・人）	783	782	781	780
認知症高齢者数（人）	**445**	**445**	**442**	**439**
対認定者	56.9％	56.9％	56.9％	56.9％

資料：地域包括ケア「見える化」システム B 7（認知症高齢者自立度の状況）。**令和 8 年 4 月末の認知症高齢者の日常生活自立度は、Ⅱa 140 人、Ⅱb 174 人、Ⅲa 117 人、Ⅲb 28 人、Ⅳ 43 人、M 18 人で、自立度Ⅱ以上は計 520 人。認定者 914 人に対し 56.9％です。※ 第 13 版までは自立度Ⅲa・Ⅲb の値がなく、下限の値を示していました。※ B 7 の認定者数（914 人）は介護保険総合データベースによるもので、令和 7 年 9 月に生じた認定者数の断層（本章 1）が現れていません。そのため人数ではなく割合を用い、令和 8 年 3 月末の認定者数に乗じています。**断層では重度ほど減少幅が大きい傾向が現れており、自立度の構成も変わっている可能性があります。このため上表は実態把握の目安であり、サービス見込量の算定には用いていません（第 5 章③）。

なお、令和 8 年 3 月末の認定者数 792 人は、令和 7 年 3 月末の 944 人から 152 人（16.1％）減っています。国保連合会業務統計表（月報）により、この減少が令和 7 年 9 月審査分の 1 か月に集中していること（961 人→862 人）と、**同じ月に給付件数は 1,303 件から 1,365 件へ増えていること**が確認できました。年度でみても、認定者が 16.1％減るのに対し受給者延は 4.6％減、給付費は 7.4％減であり、認定者の減り方だけが突出しています。

このため本計画では、サービス見込量の推計を認定者数ではなく第 1 号被保険者数を基礎として組んでいます。令和 3〜7 年度の給付件数を各分母で割ったときの変動係数は、第 1 号被保険者数 1.63％に対し認定者数 5.18％で、認定者数は基礎として安定しません。令和 7 年 8〜9 月の計上方法の変更の有無は【町データ待ち】です。

7　第 10 期計画における課題の整理

第 9 期計画の課題と、その後に判明した状況を踏まえ、第 10 期計画における課題を次のとおり整理します。

課題 1　介護予防・健康づくり・生きがいづくり

【表 38】第 2 章 7　第 10 期計画における課題の整理

区分	内容
第 9 期での課題	転倒、閉じこもり、口腔機能、うつ傾向、認知機能のリスクに 3 割以上が該当。介護・介助が必要に

	なった理由は高齢による衰弱、骨折・転倒、心臓病が多い
令和 7 年度調査からみた状況	リスク 10 項目のうち 6 項目が 1.0 ポイント以上低下したが、認知機能 47.9％、社会的役割 47.7％、知的能動性 41.5％、うつ 38.3％、転倒 36.5％は依然 3 分の 1 以上が該当する。**転倒リスクは唯一の増加項目（＋0.7 ポイント）で、85 歳以上では 48.8％に達する。**介護・介助が必要になった原因は高齢による衰弱 31.4％、骨折・転倒 11.8％で構造は変わらない。生きがいが「思いつかない」は 36.5％
介護予防の実施状況	見える化システムでは週 1 回以上の通いの場が平成 28 年度以降 0 か所である一方、調査では週 1 回以上の参加が 5.5％あった。**一般介護予防事業費は令和 3～5 年度が 1 百万円前後で推移した後、令和 6 年度に 5.3 百万円へ 5.3 倍に増え、令和 7 年度は 6.0 百万円である。増えたのはすべて地域介護予防活動支援事業で、介護予防把握事業・介護予防普及啓発事業・一般介護予防事業評価事業・地域リハビリテーション活動支援事業は令和 5～7 年度のいずれも 0 円である**（地域支援事業交付金（国庫）実績報告書）
多様なサービス・活動の実施状況	**本町の訪問型サービス B・通所型サービス B（住民主体によるサービス）は、令和 7 年度の事業費が、いずれも 0 円となっている。**地域支援事業交付金（国庫）実績報告書によると、**訪問型 B は令和 5 年度 1,474,200 円→令和 6 年度 352,800 円→令和 7 年度 0 円、通所型 B は令和 5 年度 1,667,800 円→令和 6 年度 139,500 円→令和 7 年度 0 円**で、2 年のうちに実績がなくなっている。厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査結果」では、令和元年度から令和 3 年度にかけて「実施の有無＝有」と回答され、市町村内の事業所（団体）数は平成 29 年度から令和 4 年度まで各 1 で一貫していた。**一方、訪問型サービス A 及び通所型サービス A は実施していない。**介護予防ケアマネジメントは A のみで、B・C は実施していない。**実績がなくなった経緯（担い手の団体が活動を終えたのか、別の枠組みに移ったのか）は【町データ待ち】**
第 10 期での課題	**① 転倒予防を介護予防の重点項目として明示する。② 通いの場の拡充。**参加意向は 50.9％あるが企画・運営者としては 32.0％にとどまり、参加の条件の最上位は開催場所・時間（63.7％）である。**③ 生きがいづくりと社会参加。**特に社会的役割の低下が男性で 51.7％と女性より 7.5 ポイント高い

課題 2　安全・安心な暮らしの確保

【表 39】第 2 章 7　第 10 期計画における課題の整理（2）

区分	内容
第 9 期での課題	高齢者単身世帯・高齢者夫婦世帯が大きく増加。介護者の 6 割以上が 60 歳以上。8050 問題や認知症など複合的な課題。認知症への対応が介護者の不安で最多
令和 7 年度調査からみた状況	高齢者のみの世帯が 44.1％。主な介護者の 60 歳以上は 65.2％から 69.8％へ上昇し、70 代が 12.7％から 19.5％へ増加した。不安に感じる介護は「認知症状への対応」33.0％で引き続き最多。**認知症に関する相談窓口を知っているのは 33.2％にとどまる。**家族や友人・知人以外に相談する人がいないは 38.0％
認知症施策の実施状況	認知症高齢者自立度Ⅱａは 68 人から 148 人、M は 7 人から 29 人へ増加。認知症地域支援推進員は 1 人から 4 人へ増員（県内 19 位）したが、**認知症初期集中支援チームの訪問実績は 0 件、認知症カフェは 1 か所で横ばい**
災害時の状況	災害時に一人で避難できないが 14.2％（高齢者人口換算で約 495 人）、助けてくれる人がいないが 11.3％（同約 394 人）
第 10 期での課題	**① 認知症施策は体制整備から周知へ重点を移す。**相談窓口を知っているのは 33.2％にとどまり、60.0％が「知らない」と答えている。地域で支えるために必要なことでも、認知症に関する情報提供が 51.9％で第 2 位である（第 1 位は地域での見守りや声掛け 54.1％）。**② 老々介護と就労介護の同時進行への対応。③ 個別避難計画の対象規模を踏まえた目標設定。④ 成年後見制度の利用促進、高齢者虐待防止、一般的な災害・感染症対応は第 3 期地域福祉計画に移管・連携する（第 4 章 3）**

課題 3　介護サービスの充実

【表 40】第 2 章 7　第 10 期計画における課題の整理（3）

区分	内容
第 9 期での課題	働きながらの介護継続に 8 割以上が問題を抱える。介護者自身の高齢化

令和 7 年度調査からみた状況	**働きながら介護をしている方が 46.5％と前回の 25.0％から大きく増えた。**介護を理由に離職・転職した家族・親族がいる世帯が 12.9％。仕事と介護を続けていくのが難しいは 16.2％（n=86）。必要な支援は労働時間の柔軟な選択 25.6％、介護休業等の制度の充実 24.4％
新たに判明した課題	**在宅の要介護認定者の 42.1％が介護保険サービスを利用しておらず、その理由は需要側のものが上位を占める（複数回答・n=154）。**供給側の理由を挙げた方は 1 人、費用は 6 人、手続きの分かりにくさは 7 人にとどまる（複数回答・n=154）
供給体制の状況	居宅介護支援事業所が 5 か所から 3 か所へ減少。訪問看護は 1 か所。介護サービス自給率は 67.57％で、短期入所系は 12.5 ポイント低下
財政の状況	繰越金 182.0 百万円（保険給付費の 16.5％）、介護給付費準備基金の純増 88.1 百万円。合わせて 270 百万円程度の財政的な余力
第 10 期での課題	**① 認定と利用のギャップへの対応。**供給確保ではなく、認定の運用の確認、本人の利用意向への働きかけ、家族介護に依存する層へのレスパイトを軸とする。**② 仕事と介護の両立支援。③ ケアマネジメント基盤の確保。④ 保険料水準の判断。**据置・引下げ・基金取崩のいずれを採るか

第3章　第9期計画の実施状況と評価

第10期の施策を定めるにあたり、まず第9期計画（令和6〜8年度）がどこまで達成できたかを確かめます。令和8年9月に介護保険事業状況報告（年報）の令和3〜7年度分を受領し、令和6・7年度の実績が確定しました。令和8年度は年度の途中であるため、確定しているのは2か年です。

1　第9期計画の基本目標と達成状況

第9期計画は、基本理念「健康で自分らしく暮らせるまち」のもとに3つの基本目標を掲げました。第9期計画が第5章2(2)で自ら定めた点検項目に沿って評価します。

【表41】第3章1　第9期計画の基本目標と達成状況

基本目標	第9期の主な取組	達成状況	評価
1　介護予防と生きがいづくりの推進	介護予防・日常生活支援総合事業、一般介護予防事業、通いの場の推進、生きがいづくり	**通いの場は週1回以上が0か所のまま。**一般介護予防事業費は令和3〜5年度が1百万円前後で、令和6年度に5.3百万円へ増えたが、何の事業かは確認中。一方、ニーズ調査ではリスク該当率10項目のうち8項目が改善	**未達。ただし調査の回収率が9.8ポイント下がっており、リスクの改善は断定できない**
2　安全・安心な暮らしの確保	地域包括支援センターの運営、認知症施策、生活支援体制整備、災害時の要支援者対応	**認知症地域支援推進員は1人から4人に増えた一方、初期集中支援チームの訪問実績は0件。**認知症カフェは1か所で横ばい。相談窓口を知っている方は33.2％	**一部達成。**体制は整ったが活動につながっていない
3　介護サービスの充実	介護給付の適正化、サービスの質の向上、必要なサービス量の確保	**介護給付適正化の主要3事業はいずれも実施。**縦覧点検と医療情報との突合は交付金の配点満点。標準給付費は見込みに対し令和6年度98.6％、令和7年度91.1％	**達成。**ただし給付費が見込みを下回った理由の分析が要る

資料：介護保険事業状況報告（年報）令和3〜7年度、地域包括ケア「見える化」システム、令和8年度保険者機能強化推進交付金の該当状況調査票集計表、令和7年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査。**評価は、達成・一部達成・未達・評価できない の4区分による（第1章6）。**

2　地域支援事業の実績

第9期計画は、地域支援事業費を3年間で207,260千円（うち介護予防・日常生活支援総合事業費110,960千円）と見込みました。

【表42】第3章2　地域支援事業の実績

区分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	第9期3年計の見込み
第9期の見込み（千円）	—	**67,320**	**69,120**	**207,260**
うち総合事業費	—	36,220	37,020	110,960
実績（千円）	63,275	**63,916**	【町データ待ち】	—
うち総合事業費	35,670	34,581	【町データ待ち】	—
うち一般介護予防事業費	**993.7**	**5,304.7**	【町データ待ち】	—
見込みに対する実績の割合	—	**94.9%**	【町データ待ち】	—

資料：第9期計画本文及び介護保険事業状況報告（年報）様式4。**※ 令和7年度は年報 様式4 が未入力ですが、地域支援事業交付金（国庫）実績報告書と決算状況（歳出）により事業別の内訳が取れます**（令和8年10月15日受領。両者は完全に一致）。

令和6年度の実績は見込みの94.9%で、見込みを下回りました。

一般介護予防事業費は、令和 3〜5 年度が 1 百万円前後で推移した後、令和 6 年度に 5.3 百万円へ 5.3 倍に増えています。増えたのはすべて地域介護予防活動支援事業で、介護予防把握事業・介護予防普及啓発事業・一般介護予防事業評価事業・地域リハビリテーション活動支援事業は令和 5〜7 年度のいずれも 0 円です（地域支援事業交付金（国庫）実績報告書）。**増えたとはいえ地域支援事業費全体の 8.3％であり、週 1 回以上の通いの場が 0 か所のままであることと合わせてみると、第 9 期計画が掲げた通いの場の推進が支出の面でも立ち上がっていないことを示しています。**

3　介護保険事業の実績

(1)　標準給付費の見込みと実績

【表 43】第 3 章 3　介護保険事業の実績

区分	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	3 年計
第 9 期の見込み　標準給付費見込額（千円）	**1,185,894**	**1,189,712**	**1,190,880**	**3,566,486**
うち総給付費	1,106,604	1,110,764	1,112,373	—
実績　標準給付費（千円）	**1,169,470**	**1,083,513**	—（年度途中）	—
見込みに対する実績の割合	**98.6％**	**91.1％**	—	—

資料：第 9 期計画本文及び介護保険事業状況報告（年報）様式 3。実績の標準給付費は算定対象審査支払手数料を含まない。

令和 6 年度は見込みの 98.6％、令和 7 年度は 91.1％にとどまりました。2 か年続けて見込みを下回り、下回り方が大きくなっています。

(2)　見込みを下回った理由

【表 44】第 3 章 3　介護保険事業の実績（2）

要因	内容	第 10 期への反映
認定者数の減少	**令和 8 年 3 月末の認定者数は 792 人で、前年の 944 人から 152 人（16.1％）減りました。**減少は令和 7 年 9 月審査分の 1 か月に集中しており、計上方法の変更による可能性を町とともに確認しています（【町データ待ち】）	**第 10 期の見込みは、認定者数を年報の実数から置き直しました（第 6 章 1）**
在宅サービスの利用の低下	在宅サービスの利用率は令和 3 年度の 59.3％から令和 7 年度の 44.1％へ 15.2 ポイント下がりました。在宅の要介護認定者の 42.1％がサービスを利用していません	**利用率を上げる前提を置かず、実績の水準から延ばしました**
見込みの置き方	第 9 期は第 1 号被保険者 1 人当たりの利用率を過去 3 年の平均で置いていました。利用率が下がり続けている系列では、3 年平均が実績を上に引きます	**第 10 期は直近年度の水準を起点とし、国保連月報で令和 8 年度の実績を確かめたうえで延ばしました（第 6 章 2）**

(3)　計画との乖離が大きいサービス

サービス別にみると、乖離の方向は一様ではありません。

【表 45】第 3 章 3　介護保険事業の実績（3）

区分	サービス	状況
下回った	在宅サービス全般	利用率の低下により、見込みを下回った

	地域密着型通所介護	**令和 3 年度 14 件・令和 4 年度 10 件・令和 5 年度 1 件と減り、令和 6・7 年度は 0 件。**事業所の休廃止によるものか、利用が他のサービスに移ったのかを確認しています（【町データ待ち】）
上回った／横ばい	施設・居住系サービス	定員に対する利用が続いており、見込みに近い水準

4　第 9 期の評価と第 10 期への課題

第 9 期の評価から、第 10 期に引き継ぐ課題は次の 4 つです。

【表 46】第 3 章 4　第 9 期の評価と第 10 期への課題

#	課題	第 9 期での状況	第 10 期での対応
1	**介護予防が支出の面でも立ち上がっていない**	週 1 回以上の通いの場は 0 か所。一般介護予防事業費は令和 6 年度に 5.3 百万円へ増えたが、地域支援事業費全体の 8.3％	**第 5 章 基本目標 1②。通いの場の立ち上げを具体の目標として置く**
2	**認知症施策は体制が整ったが活動につながっていない**	推進員 1 人→4 人、初期集中支援チームの訪問実績 0 件、相談窓口を知っている方 33.2％	**第 5 章 基本目標 2③。体制整備から周知へ重点を移す**
3	**認定と利用のあいだに開きがある**	認定率は県内でも高い方にある一方、在宅の要介護認定者の 42.1％がサービスを利用していない	**第 5 章 基本目標 3①・②。利用につながらない理由を需要側・供給側に分けて見る**
4	**在宅医療・介護連携の取組が国の評価指標に届いていない**	令和 8 年度交付金の支援Ⅲは 55 点／100 点で、8 つの目標のうち唯一、全国平均を下回る	**第 5 章 基本目標 2⑦。4 つの場面ごとの目指すべき姿を定める**

※ 第 9 期計画の評価の詳細は、「小野町高齢者福祉サービス推進協議会資料　第 9 期計画の評価及び令和 7 年度調査結果の整理」によります。

第 4 章　計画の基本的考え方

1　計画の基本理念と目標

健康で自分らしく暮らせるまち

本町は、第 8 期計画において「健康で自分らしく暮らせるまち」を基本理念として掲げ、第 9 期計画もこれを踏襲しました。高齢者一人ひとりが、健康と自分らしさを保ちながら、住み慣れた地域で暮らし続けられることを目指すという考え方は、第 10 期においても変わりません。**本計画もこの基本理念を継承します。**

この基本理念のもとに、第 9 期計画から引き続き 3 つの基本目標を設定します。

【表 47】第 4 章 1　計画の基本理念と目標

基本目標	考え方	第 9 期からの変更
基本目標 1 介護予防と生きがいづくりの推進	高齢者が健康を維持し、社会とのつながりを持ち続けられるよう、健康づくり、介護予防、生きがいづくりと社会参加を進める	**継承（強化）。**転倒予防を明示し、通いの場の拡充を最重点とする
基本目標 2 安全・安心な暮らしの確保	認知症、災害、生活の困りごとなど、高齢者とその家族が抱える不安に対応できる体制を整える	**継承（施策を再編）。**成年後見制度の利用促進は第 3 期地域福祉計画に移管し、高齢者虐待防止・災害対応・地域の支え合いは同計画と連携する
基本目標 3 介護サービスの充実	必要な人に必要なサービスが届き、持続可能な形で介護保険事業が運営されるようにする	**継承（強化）。**「認定と利用をつなぐ支援」を新設する

※ 基本理念・基本目標は、小野町高齢者福祉サービス推進協議会に諮り確定します。

本計画が目指す「本町の地域包括ケアの姿」は、次のとおりです。

町全域を 1 つの日常生活圏域として（第 1 章 5）、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保され、高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域でその有する能力に応じて自分らしい暮らしを続けられる状態をいいます。**令和 22 年に向けて支える人の数が減るなかで、少ない担い手で必要なサービスを届けられる体制を保つことを含みます。**その見通しを第 6 章 11 に、体制を確保する施策を第 6 章 12 に示します。

※ 地域包括ケアシステムの定義は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第 2 条第 1 項による（e-Gov 法令 API 令和 8 年 10 月 20 日取得で確認）。

2　計画の体系

第 9 期計画の施策体系（3 基本目標・14 施策）と、第 10 期の体系は次のとおりです。

【表 48】第 4 章 2　計画の体系

基本目標	第 9 期の施策	第 10 期	変更の理由
1　介護予防と生きがいづくりの推進	① 健康づくりの推進	継承	—
	② 介護予防・日常生活支援総合事業の推進	**継承（強化）**	通いの場の拡充を最重点とする。転倒予防を明示する
	③ 生きがいづくりと社会参加の推進	継承	—

2　安全・安心な暮らしの確保	① 地域の支え合いの支援	**地域福祉計画と連携**	同計画 基本目標 2 推進施策 3① と重複。本計画は生活支援体制整備事業に絞る
	② 包括的支援事業・任意事業の推進	**継承（強化）**	居宅介護支援事業所が 5 か所から 3 か所に減少。ケアマネジメント基盤の確保を明記する
	③ 成年後見制度の利用促進	**地域福祉計画に移管**	同計画が第 6 章に「小野町第 1 期成年後見制度利用促進基本計画」を一体的に策定した
	④ 認知症施策の充実	**継承（強化）**	認知症施策推進基本計画に基づく市町村計画として包含。体制整備から周知へ重点を移す
	⑤ 高齢者虐待防止の推進	**地域福祉計画と連携**	同計画 基本目標 3 推進施策 3② と重複。本計画は介護サービス事業所における虐待防止に絞る
	⑥ 災害・感染症対応等の充実	**地域福祉計画と連携**	同計画 基本目標 3 推進施策 2③ と重複。本計画は避難行動要支援者名簿・個別避難計画・福祉避難所に絞る
	⑦ 多様な生活支援の充実	継承（一部連携）	移送・買物・配食は地域公共交通計画とも接続。介護保険の給付・地域支援事業で対応する部分を本計画で具体化する
	⑧ 介護人材の確保とサービスの質の向上	継承	—
3　介護サービスの充実	① 自立支援・重度化防止に向けた取り組み	継承	—
	② 介護保険サービス等の充実	**継承（強化）**	**「認定と利用をつなぐ支援」を新設する。**在宅の要介護認定者の 42.1％が未利用であり、その理由は需要側のものが上位を占める（複数回答・n=154）
	③ 介護サービスの見込みと保険料	継承	—

以上により、第 10 期の施策体系は 3 基本目標・12 施策となります。第 9 期の 14 施策のうち、成年後見制度の利用促進は第 3 期地域福祉計画に移管し、高齢者虐待防止の推進は包括的支援事業及び認知症施策のなかで扱います。

【表 49】第 4 章 2　計画の体系（2）

基本目標	施策
1　介護予防と生きがいづくりの推進	① 健康づくりの推進／② 介護予防・日常生活支援総合事業の推進／③ 生きがいづくりと社会参加の推進
2　安全・安心な暮らしの確保	① 地域の支え合いの支援／② 包括的支援事業・任意事業の推進／③ 認知症施策の充実／④ 災害時等の要支援者への対応／⑤ 多様な生活支援の充実／⑥ 介護人材の確保とサービスの質の向上
3　介護サービスの充実	① 自立支援・重度化防止に向けた取り組み／② 介護保険サービス等の充実／③ 介護サービスの見込みと保険料

3　関連計画との役割分担

令和 8 年 3 月に策定された「小野町第 3 期地域福祉計画」（令和 8〜12 年度）は、基本理念「ともに助け合い・支え合い、みんなが笑顔で元気に暮らせる 小野町」のもとに 3 つの基本目標を置き、福祉分野の最上位計画として横断的な施策を整理しています。同計画は第 6 章に「小野町第 1 期成年後見制度利用促進基本計画」を一体的に策定しており、第 9 期高齢者計画の施策と重複が生じています。

そのため、本計画では次のとおり役割分担を明確にし、**介護保険制度に基づく具体化（誰に、何を、どの体制で実施するか）に集中します。**

【表 50】第 4 章 3　関連計画との役割分担

第 9 期高齢者計画の施策	第 3 期地域福祉計画の対応箇所	本計画での扱い
成年後見制度の利用促進	第 6 章「小野町第 1 期成年後見制度利用促進基本計画」（一体策定）	**移管。**本計画では、認知症高齢者の意思決定支援の観点から連携先として記載する
高齢者虐待防止の推進	基本目標 3　推進施策 3「権利擁護の推進」②高齢者虐待問題への対応	**連携。**本計画では、介護サービス事業所における虐待防止（運営基準）に絞る
災害・感染症対応等の充実	基本目標 3　推進施策 2「安全で安心して暮らせる社会の形成」③災害と感染症等の発生時への対応	**連携。**本計画では、避難行動要支援者名簿・個別避難計画・福祉避難所に絞る
地域の支え合いの支援	基本目標 2　推進施策 3「地域福祉を支える体制の整備」①住民主体の福祉ネットワークづくり	**連携。**本計画では、生活支援体制整備事業（協議体・生活支援コーディネーター）に絞る
多様な生活支援の充実（生活基盤・交通）	基本目標 1　推進施策 2① ひとり暮らしの高齢者の孤立解消、基本目標 2　推進施策 1① 高齢者世帯への生活自立に向けた支援	**一部連携。**移送・買物・配食は地域公共交通計画とも接続する。介護保険の給付・地域支援事業で対応する部分を本計画で具体化する
認知症施策の充実（見守り部分）	基本目標 3　推進施策 2② 認知症の高齢者等への見守り活動	**役割整理。**地域での見守りは地域福祉計画、初期集中支援・地域支援推進員・認知症カフェ・医療連携は本計画で具体化する

一方、地域福祉計画に記載された高齢者関係の事項のうち、本計画で具体化するものは次のとおりです。

【表 51】第 4 章 3　関連計画との役割分担（2）

地域福祉計画の記載	本計画で具体化する内容
基本目標 1　推進施策 1②　高齢者一人ひとりの生活機能の向上に向けたサービス提供	介護予防・日常生活支援総合事業、一般介護予防事業、通いの場の拡充、介護予防ケアマネジメント（基本目標 1②）
基本目標 2　推進施策 2②　高齢者の介護マネジメント	地域包括支援センターの体制強化、居宅介護支援事業所の確保、認定と利用をつなぐ支援（基本目標 2②・3②）
基本目標 3　推進施策 2①　ひとり暮らし高齢者等の緊急時への対応	緊急時の受入体制、短期入所、24 時間対応の在宅サービス（基本目標 3②）
基本目標 3　推進施策 2②　認知症の高齢者等への見守り活動	認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、認知症カフェ、医療・介護連携（基本目標 2③）

※ 第 3 期地域福祉計画の策定にあたって実施された関係団体ヒアリング（令和 7 年 8 月、小野町自立支援協議会及び民生児童委員協議会）では、「移動支援やヘルパーが不足しており、外出や就労が困難」「高齢・障がいなどの分野別の縦割りが強く、分野横断的な連携体制が必要」等の指摘がありました。本計画でも同じ課題認識を共有します。

保健・認知症の分野の関連計画との役割分担は、次のとおりです。

【表 52】第 4 章 3　関連計画との役割分担（3）

関連計画・事業	根拠	本計画での扱い
市町村健康増進計画	健康増進法第 8 条第 2 項（努力義務）	**連携。**生活習慣病の予防と健康づくりの全般は同計画が担う。本計画は、フレイル予防・介護予防につながる部分に絞る（第 5 章 基本目標 1①・②）
特定健康診査等実施計画・データヘルス計画（国民健康保険）	高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条第 1 項、国民健康保険法第 82 条第 1	**連携。**特定健診の受診勧奨と生活習慣病の重症化予防は同計画が担う。本計画は、受診率を成果指標と

	項	して参照する（第 5 章 基本目標 1①）
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	高齢者の医療の確保に関する法律第 125 条の 2 第 1 項（後期高齢者医療広域連合からの委託）	**本計画で具体化。**ハイリスク者への個別支援と、通いの場等への専門職の関与（第 5 章 基本目標 1①・②）
市町村認知症施策推進計画	共生社会の実現を推進するための認知症基本法第 13 条第 1 項（努力義務）	**本計画に包含。**第 5 章 基本目標 2③ に位置づける

※ 本町の健康増進計画・データヘルス計画・特定健康診査等実施計画の計画名と計画期間は【町データ待ち】。※ 条文は e-Gov 法令 API（令和 8 年 10 月 20 日取得）で確認した。

（参考）小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業（令和 9 年 4 月 1 日新設）

令和 9 年 4 月 1 日に、社会福祉法第 106 条の 6 が「小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業」に差し替わります。小規模市町村とは、「その人口規模、その人口の減少の状況等からみて福祉サービスを提供する体制の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市町村として**厚生労働省令で定める基準**に該当するもの」をいいます（同条第 1 項）。該当する市町村は、包括的な支援体制の整備を促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、この事業を**行うことができます**（任意）。

この事業は、分野ごとに別々に行っている事業を「一体のものとして実施する」点に要点があります（同条第 2 項）。一体的に行う事業は次のとおりで、**高齢者分野の事業がそのまま対象に含まれています。**

【表 53】第 4 章 3　関連計画との役割分担（4）

区分	一体的に行う事業（4 分野すべてを行うもの）
相談（第 2 項第 1 号）	**介護保険法第 115 条の 45 第 2 項第 1 号から第 3 号まで**（総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援＝**地域包括支援センターの事業**）／障害者総合支援法第 77 条第 1 項第 3 号（相談支援）／子ども・子育て支援法第 59 条第 1 号／生活困窮者自立支援法第 3 条第 2 項各号
地域づくり（第 2 項第 3 号）	**介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 2 号のうち厚生労働大臣が定めるもの**（一般介護予防事業の一部）／**同条第 2 項第 5 号（生活支援体制整備事業）**／障害者総合支援法第 77 条第 1 項第 9 号／子ども・子育て支援法第 59 条第 9 号
連携・協働の促進（第 2 項第 2 号）	地域住民等と支援関係機関の相互の連携又は協働の促進のための事業

本町が小規模市町村に該当するかどうかは、厚生労働省令の基準によります（【町データ待ち】）。県に照会しています。**なお、基準を定める厚生労働省令は、令和 8 年 10 月 19 日現在、公布されていません。** 社会福祉法施行規則について法令 API で確かめたところ、**「小規模市町村」の語を含む条は 1 つもありません。** 該当し、かつ本事業を行う場合は、**地域包括支援センターの 3 事業と生活支援体制整備事業を、障がい・子ども・生活困窮の各事業と一体に実施することになります。**本計画の第 6 章 4（地域支援事業）の立て方に関わるため、省令と県の方針が示された段階で改めて整理します。

※ 従事する職員及びその員数の基準は厚生労働省令で定められ、小規模市町村はこれに従うものとされます（同条第 3 項）。**分野を超えて職員を配置できることが、この事業の実益です。** また、こども家庭センター、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第 3 条第 2 項各号の事業を行う者その他の支援関係機関との緊密な連携を図るものとされ（同条第 4 項）、事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に**委託することができます**（同条第 5 項）。**※ 改正前の第 106 条の 6（支援会議）は、第 106 条の 3 の 2 に移ります。** 第 4 章 4 に掲げる相互連携の規定（介護保険法第 115 条の 48 第 5 項）が名指ししている社会福祉法の支援会議は、**この移った後の条のもの**です。

出所：社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）令和 9 年 4 月 1 日時点。e-Gov 法令 API（デジタル庁）により令和 8 年 10 月 19 日に取得。改正の本体は社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第 51 号。公布 令和 8 年 6 月 25 日）。

※ 市町村地域福祉計画の記載事項も 1 つ増えます。 社会福祉法第 107 条第 1 項に第 6 号が新設され、「地域における保健医療、労働、教育、**住まい**、地域再生及び防災に関する施策、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策その他の関連施策との連携に関する事項」を定めるものとされます（令和 9 年 4 月 1 日施行）。**第 4 期地域福祉計画の策定時に関わる事項であり、本計画の住まいの施策（第 2 章 5）と接続します。**

4　障がい福祉計画との接点

本町では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画と、障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を**同じ期間（令和 9 年度〜令和 11 年度）で同時に策定**しています。

両制度の間には、同じ方が年齢や状態の変化によって行き来する場面があります。 どちらの制度がどちらに当たるかを決める手順を両計画で揃えておかないと、**同じ方の同じ利用が両方の見込量に入る**、あるいは**どちらにも入らない**ということが起こります。なお、同じ方が両制度のサービスを併せて使うことはあり、その場合はそれぞれの計画に計上します。

本節は、その判定の手順と、判定に用いる言葉を定めるものです。**両計画に同じ内容を掲げています。**

【表 54】第 4 章 4　障がい福祉計画との接点

#	場面	制度の内容	本町での扱い
1	40 歳から 64 歳までの方（第 2 号被保険者）との重なり	第 2 号被保険者は 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者です。介護保険の給付を受けるには、加齢に伴って生ずる**特定疾病**に起因して要介護・要支援の状態にあることが必要です。障がい福祉サービスを利用している方がこれに該当する場合、**65 歳未満でも介護保険が優先する場面があります。**	障がい福祉サービスの受給者のうち、特定疾病により要介護認定を受けている方の人数を、両計画で同じ数として扱います。
2	65 歳に達したときの判定と引継ぎ	65 歳に達した方は第 1 号被保険者になります。障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移るかどうかは、**一律に決まるものではなく、個別に判定します。**	到達の年月・現に利用しているサービスと量・介護保険に相当するサービスの有無・受入れの可否・本人の意向を 1 件ずつ確かめ、**実際に移る分だけを両計画の見込量に同じ年度で反映します。**地域包括支援センターと相談支援事業所が同時に動きます。
3	介護保険優先原則を一律に適用しないこと	障害者総合支援法は、介護保険の給付が受けられる場合にはそちらを優先するとしていますが、**国の通知により、一律に適用するのではなく市町村が個別に判断する**こととされています。	**「65 歳になったので介護保険へ」という扱いはしません。** 下の 4・5 の判定を経て決めます。
4	介護保険に相当するサービスがないもの	**共同生活援助、施設入所支援、就労系のサービス、同行援護、行動援護などは、介護保険に相当するサービスがありません。** これらは 65 歳に達した後も障がい福祉サービスとして続きます。また、必要な量が介護保険の支給限度基準額で足りない場合は、**足りない部分を障がい福祉サービスで併せて用います。**	障がい計画の見込量から、これらを一律に減らすことはしません。介護保険計画の見込量にも、これらに当たる分を積みません。
5	介護保険の適用除外となる施設の入所者	**指定障害者支援施設に、生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受けて入所している方は、介護保険の被保険者となりません。**「施設入所支援を使っているか」ではなく、**どのような支給決定を受けているか**で決まります。	**該当する方は第 1 号被保険者数から除きます。** 第 1 号被保険者数は保険料の分母であり、認定率の分母でもあるため、該当する方がいる場合は保険料の算定に影響します。
6	共生型サービスと基準該当障害福祉サービスの区別	**この 2 つは別の仕組みです。** 共生型サービスは、一方の制度の指定を受けた事業所が**申請して**もう一方の制度の指定を受けるものです。基準該当障害福祉サービスは、通常の指定を受けていない事業所について**市町村が給付の対象と**	**同じ事業所が両計画に現れます。** 事業所の数を数えるときは、事業所番号で名寄せし、どちらの指定によるものかを分けて書きます。

		するものです。	
7	介護保険へ移った方の利用者負担の軽減	障がい福祉サービスを長く利用してきた方が介護保険へ移ったときに、利用者負担を軽減する給付があります。**対象となるサービスの種類は限られており、介護予防サービスは対象外です。**	**申請の窓口は介護保険の側です。** 障がい福祉の担当から介護保険の担当へつなぐ手順を定め、両計画に同じ内容を書きます。
8	計画相談支援から居宅介護支援への引継ぎ	介護保険へ移った方のケアマネジメントは**居宅介護支援**が担います。その方は計画相談支援の対象から外れます。	障がい計画の計画相談支援の見込量から移った分を減らし、介護保険計画の居宅介護支援の見込量に同じ分を加えます。**どちらか一方だけを動かすと、合計が合わなくなります。**
9	両計画で同じ方・同じ量を二重に数えないこと	上の 1 から 8 までは、いずれも**同じ方が両方の計画に現れうる**場面です。両計画がそれぞれに見込むと、**同じ方のサービスを二重に見込むことになります。**	**移る方の一覧を 1 つ作り、両計画がそこから引きます。** 一覧は、到達の年度・利用しているサービス・移る先・移る年度を持つものとします。
10	支援会議と支援協議会が互いに連携すること（**法定**）	令和 8 年法律第 51 号により、**介護保険法第 115 条の 48 第 5 項**と**障害者総合支援法第 89 条の 3 第 5 項**が新たに置かれました。介護保険法の**支援会議**（改正前は「会議」）と、障害者総合支援法の**支援協議会**（改正前は「協議会」）は、同じ地方公共団体にもう一方が置かれているときは、**相互に連携を図るよう努めなければならない**こととされます。**互いの名前が互いの条文に書かれており、双方向の規定です。**令和 9 年 4 月 1 日施行で、本計画期間の初日に当たります。**なお、条文が名指ししているのは 2 つではなく 5 つです。** 介護保険法第 115 条の 48 第 5 項は、障害者総合支援法第 89 条の 3 第 1 項の支援協議会のほか、**社会福祉法第 106 条の 3 の 2 第 1 項の支援会議、住宅セーフティネット法第 81 条第 1 項の支援協議会、生活困窮者自立支援法第 9 条第 1 項の支援会議**、その他支援体制の構築に資する会議を挙げています（障害者総合支援法第 89 条の 3 第 5 項も同じ構成です）。	**上の 1 から 9 までの判定を、これらの会議の連携の場で行います。** 介護保険法の支援会議は、実施の一部を地域包括支援センターの設置者に委託することができ（同条第 6 項）、運営に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとされます（同条第 7 項）。本町にどれが置かれているかを確かめたうえで、**どの場で、いつ、誰が判定するかを両計画に同じ内容で書きます。**

両計画の人口の前提をそろえます。高齢者計画は、保険料を国の推計ワークシートにより算定するため、国が配布する推計用人口を用いています（第 2 章 6）。障がい計画はこれから人口の基礎を置くところであり、**高齢者計画と同じ系列を用います。**同じ町の 2 つの計画が同じ年の人口を違う数で載せることは避けます。

※ 10 に掲げた条項は、**e-Gov 法令 API（デジタル庁）により、令和 9 年 4 月 1 日時点に効力をもつ条文の現物で確かめたもの**です（令和 8 年 10 月 19 日取得）。令和 9 年 4 月 1 日は本計画期間の初日であり、**計画期間に適用される条文は改正後のものです。** 改正の本体は社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第 51 号。公布 令和 8 年 6 月 25 日）です。1 から 9 までの制度の内容について、**根拠となる条項の番号は原典で確かめたうえで記載します。 介護保険法施行法・同法施行令・同法施行規則・障害者総合支援法施行令・同法施行規則も、同じ法令 API で取得できます。 ただし告示は法令 API の対象外です。** 7 の対象となるサービスの種類も、原典で確かめてから具体に書きます。

上の判定を行うために、次のことを町に確かめます。

【表 55】第 4 章 4　障がい福祉計画との接点（2）

#	確かめること	効くもの

1	介護保険の適用除外に当たる方の有無（指定障害者支援施設に生活介護と施設入所支援の両方の支給決定を受けて入所している方）	5（保険料の分母）
2	令和9年度から令和11年度までに65歳に達する障がい福祉サービス利用者の一覧（到達年度・利用しているサービスと量・障害支援区分・市町村民税の課税状況）	2・4・7・9（両計画の見込量）
3	第2号被保険者の認定者のうち、障がい福祉サービスの受給者証をお持ちの方の人数と利用しているサービス	1（両計画の見込量）
4	町内事業所の事業所番号と指定の種類（共生型サービスの指定の有無、基準該当障害福祉サービスの有無）	6（事業所の数え方）
5	計画相談支援の実利用者数のうち、65歳以上の方の人数	8（引継ぎ）
6	**障害者総合支援法第89条の3の支援協議会（自立支援協議会）と、介護保険法第115条の48の支援会議の設置の有無。**単独設置か田村地方での共同設置か、年間の開催回数と構成員	10（判定を行う場）
7	**社会福祉法第106条の3の2の支援会議、住宅セーフティネット法第81条第1項の居住支援協議会、生活困窮者自立支援法第9条第1項の支援会議の設置の有無。**改正後の介護保険法第115条の48第5項は、これらとの相互の連携も努力義務としているため、置かれている会議体を一覧にします	10（判定を行う場）

いずれも【町データ待ち】です。**2の一覧が得られれば、2・4・7・9がまとめて片付きます。**

第 5 章　施策の展開

本章では、基本目標ごとに、**現状と課題、関連データ、施策の方向、主な事業、成果指標**の 5 つを示します。**関連データは、その施策の根拠になる数値を一覧にしたものです。**値・時点・出所を並べ、何にもとづいて施策を置いたかが 1 か所で分かるようにしています。成果指標の目標値は、認定者数及び事業実績の確定後に協議会で設定します（【協議会で設定】）。

基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進

① 健康づくりの推進

【現状と課題】令和 7 年度調査では、現在の健康状態を「よい」とした方が 79.9％、治療中もしくは後遺症のある病気は高血圧が 51.7％と最も多く、次いで目の病気 21.2％、糖尿病 16.8％となっています。介護・介助が必要になった主な原因は「高齢による衰弱」31.4％、「骨折・転倒」11.8％、「糖尿病」11.2％です。疾病の重症化を防ぎ、フレイルの進行を抑えることが、介護予防の入口として重要です。

【施策の方向】特定健診・後期高齢者健診等による疾病の早期発見・早期治療を進めるとともに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施により、国民健康保険・後期高齢者医療の保健事業と介護予防を切れ目なくつなぎます。

【関連データ】

【表 56】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進

指標	値	時点	出所
運動器機能の低下	14.60％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同（前回）	17.40％	第 9 期計画	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
低栄養	1.10％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
口腔機能の低下	27.50％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同（前回）	31.10％	第 9 期計画	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
転倒	36.50％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 57】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（2）

主な事業	内容	財源
疾病の早期発見・治療	特定健診、後期高齢者健診、各種がん検診、歯科健診	国保・後期高齢者医療の保健事業
疾病予防と心身の健康づくり	健康相談、健康教育、生活習慣病の重症化予防	一般会計、保健事業
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施	健診データ・医療レセプト・介護レセプトを活用したハイリスク者への個別支援、通いの場等への専門職の関与	後期高齢者医療広域連合からの受託
地域医療の強化	公立小野町地方綜合病院等との連携、在宅医療の体制	一般会計

【表58】第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（3）

成果指標（案）	現状値	目標値
特定健診受診率	【町データ待ち】	【協議会で設定】
後期高齢者健診受診率	【町データ待ち】	【協議会で設定】
一体的実施における個別支援の対象者数	【町データ待ち】	【協議会で設定】

② 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

【現状と課題】介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者及び事業対象者に対する訪問型・通所型サービスと、すべての高齢者を対象とする一般介護予防事業から構成されます。

介護予防・生活支援サービス事業の実績は次のとおりです。国保連合会業務統計表（月報）により、令和6・7年度の給付の状況が確認できます。

【表59】第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（4）

区分	令和6年度 件数	令和6年度 給付額（円）	令和7年度 件数	令和7年度 給付額（円）
訪問型サービス（独自）	266	4,745,665	294	4,940,600
通所型サービス（独自）	619	21,426,593	608	20,924,307
その他の生活支援サービス（配食・見守り等）	**0**	**0**	**0**	**0**
介護予防ケアマネジメント	570	2,573,400	545	2,453,900
計	1,455	28,745,658	1,447	28,318,807
うち事業対象者（再掲・件数）	4	—	**30**	—

※ 国保連合会業務統計表（月報）のサービス種類別給付状況による。件数は月あたりの利用者数の年間累計。**訪問型・通所型はいずれも「独自」であり、みなしサービスの実績はない。**※ 一般介護予防事業は保険給付ではないため、この統計には現れない。※ 総合事業の実施方針は、国の「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」の最新の内容と照合して確定します（【決定後に記載】）。

令和9年4月1日から、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を運営する事業が、総合事業に新たに位置づけられます（改正後の介護保険法第115条の45第1項第2号ロ。令和8年法律第51号）。通いの場の拡充（後述）を進める本町にとって、集会施設等を介護予防と支え合いの拠点として運営する際の財源の選択肢になります。本町で実施するかは、事業の要件が示された段階で判断します（【決定後に記載】）。

この実績から、3つのことが読み取れます。

第1に、その他の生活支援サービス（配食・見守り等）の実績が令和6・7年度とも0件です。総合事業の枠組みとしては用意されているものの、事業として動いていません。後述のとおり在宅生活の継続に必要な支援として移送・配食の要望が最も多いことと対照的であり、⑤多様な生活支援の充実とあわせて設計を要します。

第2に、事業対象者（基本チェックリストによる該当者）が令和6年度の4件から令和7年度の30件へ7.5倍に増えています。要支援認定を経ずに総合事業につなぐ経路が動き始めており、この流れを通いの場の拡充と結びつけることが有効です。

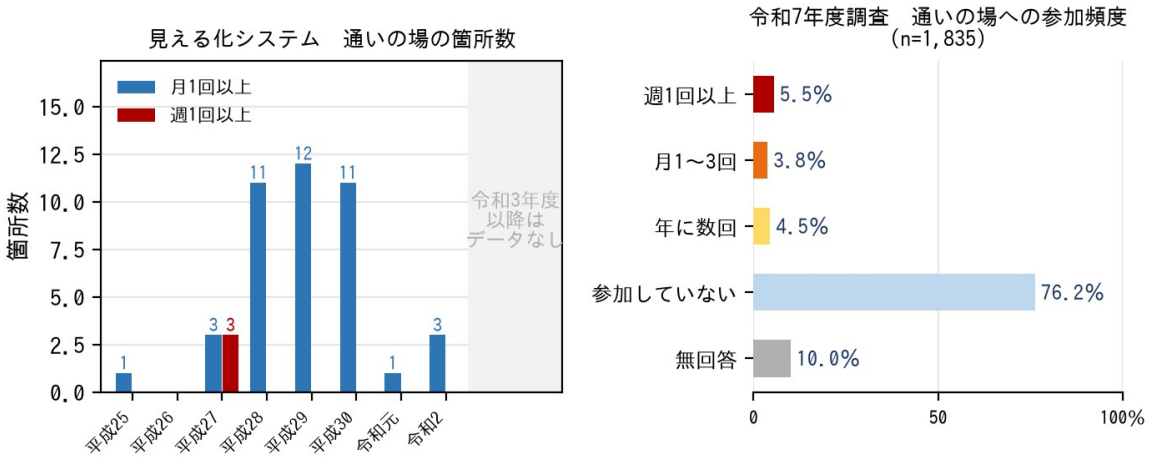
第3に、通所型サービスが給付額の73.9％を占めています。訪問型は17.4％、介護予防ケアマネジメントは8.7％です。通所型に偏った構成であり、訪問型の支え手をどう確保するかが課題となります。

一般介護予防事業費は、令和 5 年度の 1.0 百万円から令和 6 年度の 5.3 百万円へ 5.3 倍に増えています（年報 様式 4）。令和 3 年度 1.2 百万円、令和 4 年度 1.0 百万円、令和 5 年度 1.0 百万円と 3 年度続けて 1 百万円前後だったものが、令和 6 年度に動いています。**始めたのは地域介護予防活動支援事業です**（地域支援事業交付金（国庫）実績報告書）。**介護予防把握事業・介護予防普及啓発事業・一般介護予防事業評価事業・地域リハビリテーション活動支援事業は、令和 5〜7 年度のいずれも 0 円です。**令和 7 年度は 6.0 百万円で、第 10 期の一般介護予防事業はこの水準を出発点に組み立てます。

地域包括ケア「見える化」システムでは、週 1 回以上の通いの場が平成 28 年度以降 0 か所とされています。一方、令和 7 年度調査では、介護予防のための通いの場に週 1 回以上参加していると回答した方が 5.5％（高齢者人口換算で約 190 人規模）ありました。**両者は整合しないため、町の事業実績による確認を行っています（【町データ待ち】）。**

いずれにせよ、参加していない方が 76.2％と大多数を占めることに変わりはなく、通いの場の拡充が課題です。調査からは、そのボトルネックが住民の関心ではないことが読み取れます。

【図 2】通いの場の実施状況と調査の回答



資料：地域包括ケア「見える化」システム F1〜F6（左）及び令和 7 年度介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（右）。**システム上は平成 28 年度以降 0 か所である一方、調査では 13.8％が年に数回以上参加していると答えています。**※ 同システムの F 系列は令和 2 年度までで、**令和 3 年度以降のデータがありません。**※ 参加率の県内の位置は、令和 2 年度の週 1 回以上で 59 市町村中 38 位（中央値 0.9％）です。個別の団体名も個別の値も示していません。

【表 60】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（5）

調査結果	値	示唆
介護予防事業を「利用したいと思わない」	10.1％	**9 割に利用意向がある**
地域活動に参加者として参加する意向	50.9％	半数に参加意向がある
地域活動に企画・運営者として参加する意向	32.0％	**参加したくないが 54.8％。担い手の確保が課題**
参加の条件：開催場所・時間など	63.7％	**通いやすさが最大の条件**
参加の条件：参加料金が安いこと	53.4％	費用負担の設計
参加の条件：介護予防に効果があると感じられること	48.3％	効果の可視化
参加の条件：何をするのか事前に分かりやすく説明されていること	43.1％	周知の質
参加の条件：友人・仲間が一緒に参加すること	30.0％	誘い合いの仕組み

また、転倒リスクは 10 のリスク項目のうち唯一増加した項目であり（35.8％→36.5％）、85 歳以上では 48.8％が該当します。外出を控えている理由の最多も「足腰などの痛み」（57.0％）です。

【施策の方向】**通いの場の拡充を、第 10 期の介護予防における最重点事項として位置づけます。**住民主体の立ち上げを待つのではなく、既存の集会施設等を活用し、町及び社会福祉協議会が主導して開設する方式を検討します。開催場所と時間の設定を施策の中心に置き、移動手段を持たない方の分布を踏まえて配置します。また、**転倒予防を介護予防の重点項目として明示します。**

【関連データ】

【表 61】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（6）

指標	値	時点	出所
通いの場　週 1 回以上の参加	5.50％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
通いの場　年に数回以上の参加	13.80％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
通いの場　参加していない	76.20％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
週 1 回以上の通いの場の箇所数	すべて 0	平成 28 年度以降	地域包括ケア「見える化」システム
介護予防・生活支援サービス事業費	29,276,321 円	令和 6 年度	介護保険事業状況報告（年報）様式 4
一般介護予防事業費	5,304,726 円	令和 6 年度	介護保険事業状況報告（年報）様式 4

【表 62】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（7）

主な事業	内容	財源
介護予防・生活支援サービス事業	訪問型サービス、通所型サービス、介護予防ケアマネジメント	地域支援事業交付金
通いの場の拡充	既存の集会施設等を活用した開設、送迎の確保、運営の担い手（住民・社協・事業所）の組み合わせの検討、参加の呼びかけと効果の可視化	地域支援事業交付金（一般介護予防事業）
転倒予防	運動器機能向上プログラム、住環境の点検・助言、転倒予防に関する普及啓発	同上
一般介護予防事業	介護予防普及啓発、地域介護予防活動支援、地域リハビリテーション活動支援（専門職の関与）	同上
介護予防把握事業	リスクの高い高齢者の把握と支援へのつなぎ	同上

【表 63】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（8）

成果指標（案）	現状値	目標値
週 1 回以上の通いの場の箇所数	見える化 0 か所／調査 5.5％（【町データ待ち】）	【協議会で設定】
通いの場への参加率（65 歳以上）	13.8％（調査）	【協議会で設定】
転倒リスク該当者の割合	36.5％	【協議会で設定】
閉じこもり傾向該当者の割合	24.1％	【協議会で設定】
一般介護予防事業費	5.3 百万円（令和 6 年度・年報 様式 4）	【協議会で設定】

※ 成果指標の現状値は、見える化システムと調査で値が異なるため、町の事業実績の確認後に基準を統一します。

③ 生きがいづくりと社会参加の推進

【現状と課題】令和 7 年度調査では、社会的役割の低下に該当する方が 47.7％、知的能動性の低下が 41.5％でした。**社会的役割の低下は男性が 51.7％で、女性の 44.2％を 7.5 ポイント上回ります。**また、生きがいが「思いつかない」方が 36.5％、趣味が「思いつかない」方が 28.1％です。

一方、収入のある仕事に参加している方が 32.8％（うち週 4 回以上が 18.4％）、町内会・自治会が 32.1％、老人クラブが 14.2％となっています。第 3 期地域福祉計画の関係団体ヒアリングでも、「人口減少により企業の働き手不足が深刻化しており、高齢者や障がいのある方も含めた就労機会の確保が必要」との指摘がありました。

【施策の方向】就労、地域活動、趣味活動など、多様な社会参加の機会を確保します。特に、退職後に社会的役割を失いやすい男性が参加しやすい活動のあり方を検討します。

【関連データ】

【表 64】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（9）

指標	値	時点	出所
社会的役割の低下	47.70％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同（前回）	50.40％	第 9 期計画	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
知的能動性の低下	41.50％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
参加者としての参加意向	50.90％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
企画・運営者としての参加意向	32.00％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
生きがいが思いつかない	36.50％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 65】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（10）

主な事業	内容	財源
就労機会の拡大	シルバー人材センター等との連携、高齢者の就労相談	一般会計、県事業
交流機会の拡充	老人クラブへの支援、サロン活動の支援、世代間交流	一般会計、地域支援事業
生涯学習・趣味活動の支援	学習機会の提供、活動の場の確保	一般会計

【表 66】第 5 章基本目標 1　介護予防と生きがいづくりの推進（11）

成果指標（案）	現状値	目標値
社会的役割の低下該当者の割合	47.7％	【協議会で設定】
老人クラブ会員数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
シルバー人材センター会員数・就業実績	【町データ待ち】	【協議会で設定】

基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保

① 地域の支え合いの支援

【現状と課題】高齢者のみの世帯が 44.1％を占め、家族や友人・知人以外に相談する人がいない方が 38.0％います。日常生活の中で困っていることは「家の周りの草刈り等」18.7％、「体力や筋力の維持」17.1％、「体調の急変時の対応方法」12.9％です。

【施策の方向】生活支援体制整備事業により、協議体の運営と生活支援コーディネーターの配置を通じて、地域の生活支援の資源開発とネットワークづくりを進めます。**住民主体の福祉ネットワークづくりそのものは第 3 期地域福祉計画が担うため、本計画は介護保険の地域支援事業として実施する部分に集中します。**

【関連データ】

【表 67】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保

指標	値	時点	出所
家族・友人以外に相談する人がいない	38.00％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
閉じこもり	24.10％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同（前回）	30.00％	第 9 期計画	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
うつ傾向	38.30％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同（前回）	40.20％	第 9 期計画	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 68】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（2）

主な事業	内容	財源
生活支援体制整備事業	第 1 層・第 2 層協議体の運営、生活支援コーディネーターの配置、地域資源の把握と開発	包括的支援事業（社会保障充実分）
（連携）住民主体の見守り・支え合い活動	第 3 期地域福祉計画 基本目標 2 推進施策 3 による	—

【表 69】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（3）

成果指標（案）	現状値	目標値
協議体の開催回数	【見える化出力待ち】	【協議会で設定】
生活支援コーディネーターの活動実績	【町データ待ち】	【協議会で設定】
地域の支え合い活動の把握件数	【町データ待ち】	【協議会で設定】

② 包括的支援事業・任意事業の推進

【現状と課題】地域包括支援センターは、高齢者の総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援を担う中核機関です。令和 7 年度調査では、家族や友人・知人以外の相談先として「地域包括支援センター・役所・役場」を挙げた方が 19.2％である一方、**「そのような人はいない」が 38.0％**でした。

また、**居宅介護支援事業所が 5 か所から 3 か所に減少**しており、人口 10 万人あたり事業所数の偏差値は 47.84 です。在宅サービス利用率が 59.3％から 44.1％へ低下していることとの関連を確認する必要があります。

【施策の方向】地域包括支援センターの体制を強化し、相談の入口としての認知度を高めます。**ケアマネジメント基盤の確保を明確に施策として位置づけ、居宅介護支援事業所の状況を継続的に把握します。**

また、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談を、地域包括支援センターの総合相談で受けることが、令和 9 年 4 月の施行に向けて地域支援事業実施要綱で明確化される予定です（全国介護保険担当課長会議資料、令和 8 年 7 月 15 日）。日常生活の支援、入院等の手続、死後の事務に関する相談を受け、第 3 期地域福祉計画の権利擁護の取組と連携して対応します。

【関連データ】

【表 70】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（4）

指標	値	時点	出所
包括的支援事業・任意事業費	29,335,189 円	令和 6 年度	介護保険事業状況報告（年報）様式 4
同（前年度）	27,604,458 円	令和 5 年度	介護保険事業状況報告（年報）様式 4
認知症の相談窓口を知っている	33.20％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
家族・友人以外に相談する人がいない	38.00％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 71】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（5）

主な事業	内容	財源
総合相談支援業務	高齢者に関する各種相談への対応、実態把握、周知	包括的支援事業
権利擁護業務	高齢者虐待の早期発見と対応、消費者被害の防止、**成年後見制度は第 3 期地域福祉計画（第 6 章）と連携**	同上
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	介護支援専門員への支援、地域ケア会議の開催、多職種連携	同上
ケアマネジメント基盤の確保	居宅介護支援事業所の状況把握、開設・継続への働きかけ、介護支援専門員の確保支援	同上、県事業
在宅医療・介護連携推進事業	医療・介護関係者の情報共有、相談支援、退院時連携	包括的支援事業（社会保障充実分）
任意事業	家族介護支援、介護用品給付、成年後見制度利用支援、認知症サポーター等養成、住宅改修支援	任意事業

【表 72】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（6）

成果指標（案）	現状値	目標値
地域包括支援センターの相談件数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
地域包括支援センターの認知度	19.2％（相談先として挙げた割合）	【協議会で設定】
地域ケア会議の開催回数・検討件数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
居宅介護支援事業所数	3 か所	3 か所以上の維持

※ 介護用品給付券等の町単独事業については、財源科目と補助対象の可否を確認のうえ整理します（【町データ待ち】）。

③ 認知症施策の充実

本節は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第 13 条第 1 項に基づく**市町村認知症施策推進計画**を兼ねます。施策は同法第 3 条の基本理念にのっとり、同法第 14 条から第 21 条までの基本的施策に対応させて組み立てます。

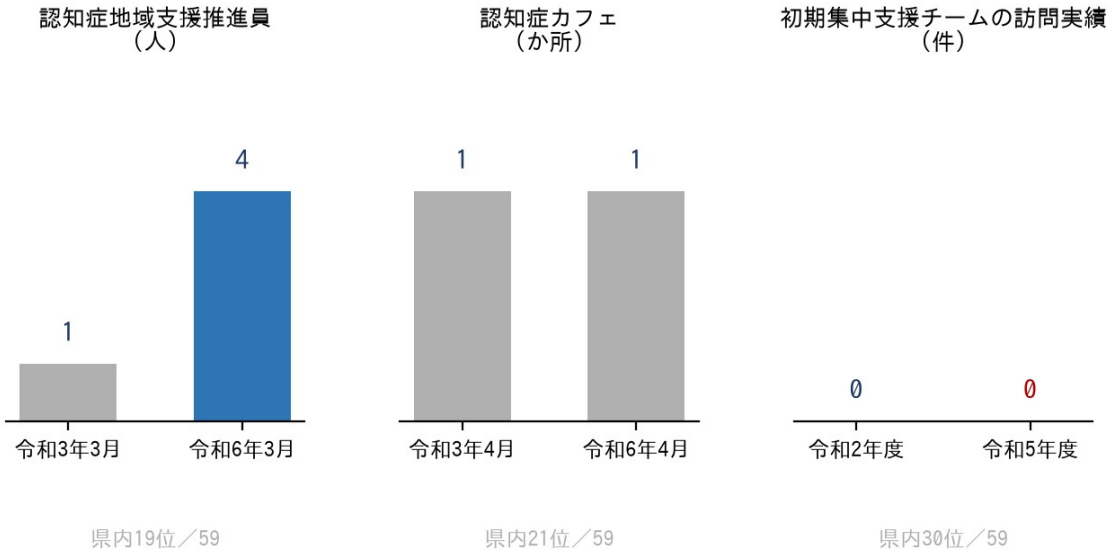
【現状と課題】本町の認知症高齢者は増加しています。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱａの方は**平成 24 年 4 月末の 68 人から令和 6 年 10 月末の 148 人**へ、Ｍの方は 7 人から 29 人へ増加しました。

ただし、同じ期間に認定者数そのものが635人から936人へ1.47倍になっている点に注意が要ります。認定者に占める割合でみると、Ⅱａは10.7％から15.8％、Ｍは1.1％から3.1％へ上がる一方、Ⅱｂは23.1％から18.9％へ下がっており、人数の増加のうち一定部分は認定者数そのものの増加によるものです。

在宅介護実態調査では、要介護認定者が現在抱えている傷病のうち認知症が20.8％で最多であり、主な介護者が不安に感じる介護も「認知症状への対応」が33.0％で最多です。

体制面では、認知症地域支援推進員を**令和3年3月の1人から令和6年3月の4人**へ増員しました（県内59市町村中19位。中央値3人）。**しかし、認知症初期集中支援チームの訪問実績は令和5年度で0件、認知症カフェは令和6年4月で1か所と横ばいです。**訪問実績が0件なのは59市町村のうち30団体で中央値も0件であり、小規模な町村では対象事案が年に数件にとどまるため、**件数そのものよりも対象者の把握経路が機能しているかが問われます。**

【図3】認知症施策の体制と活動



資料：地域包括ケア「見える化」システム（J16 初期集中支援チームの実施状況、J17 認知症地域支援推進員配置状況、J18 認知症カフェ設置状況。出典は厚生労働省「認知症総合支援事業等実施状況調べ」）。**推進員は1人から4人に増えた一方、カフェは1か所で横ばい、訪問実績は0件のままです。**県内順位は59市町村の中のもので、個別の団体名は示していません。

令和7年度調査では、**認知症に関する相談窓口を知っている方は33.2％にとどまり**、60.0％が「知らない」と回答しました。認知症の方や家族を地域で支えていくために必要なこととしては、「地域での見守りや声掛け」54.1％、「認知症に関する情報提供」51.9％が上位を占め、「認知症に関する講演会の開催」は18.7％、「認知症カフェの開催」は9.2％でした（複数回答）。

【施策の方向】**体制の追加整備よりも、相談窓口の周知と情報提供を優先します。**推進員4人という体制はすでに整っており、これを活動実績に結びつけることが課題です。周知の媒体は、住民の情報入手先である広報おのまち（85.0％）と防災無線（51.7％）を軸とします。

【関連データ】

【表73】第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（7）

指標	値	時点	出所
認知症地域支援推進員の配置人数	1→4人	令和3年→令和6年	地域包括ケア「見える化」システム
初期集中支援チームの訪問実績	0→0件	令和2年度→令和5年度	地域包括ケア「見える化」システム
相談窓口を知っている	33.20％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域

			ニーズ調査／在宅介護実態調査
相談窓口を知らない	60.00％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
支えるために必要なこと　地域での見守りや声掛け	54.10％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同　認知症に関する情報提供	51.90％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
本人・家族に認知症の症状がある	9.20％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
介護者が不安に感じる介護　認知症への対応	33.00％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同（前回）	36.70％	第 9 期計画	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 74】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（8）

認知症基本法の基本的施策	主な事業	内容
第 14 条　認知症の人に関する国民の理解の増進等	**相談窓口の周知**、認知症に関する情報提供、認知症サポーター養成講座（**小中学校を含む**）、チームオレンジ	**最重点。**広報・防災無線を軸に、相談窓口と支援内容を繰り返し周知する
第 15 条　認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進	**移動のための交通手段の確保**、見守りネットワーク、認知症の人に対応できる事業者の裾野の拡大	**同条は交通手段の確保を名指ししています。**本町の外出支援・移動手段の施策（基本目標 2）と接続させます。地域での見守りは第 3 期地域福祉計画が担います
第 16 条　認知症の人の社会参加の機会の確保等	本人が経験を語る機会の確保（本人発信支援）、通いの場等への参加、**若年性認知症の人への支援**	**若年性認知症（65 歳未満）は同条第 2 項が名指しする対象です。**本町の第 2 号被保険者の認定者は令和 8 年 3 月末で 9 人であり、町内の把握状況は【町データ待ち】。就労の継続については事業主への啓発を含みます
第 17 条　認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護	意思決定支援、成年後見制度の利用促進、**消費生活における被害の防止**	成年後見制度利用促進基本計画と連携します。**消費生活被害の防止は同条が名指しする事項であり、消費生活相談と見守りネットワークをつなぎます**
第 18 条　保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等	**認知症初期集中支援チーム**、認知症地域支援推進員、かかりつけ医・認知症サポート医との連携、認知症ケアパス、認知症介護の研修	体制はすでに整っており、課題は活動実績です。**対象者の把握経路（医療機関・地域包括支援センター・民生委員からの連絡）が機能しているかを点検します**
第 19 条　相談体制の整備等	総合相談窓口、**認知症カフェ**、家族介護者の交流、**孤立の防止**	**同条第 2 項は、本人・家族等が互いに支え合う交流活動への支援と孤立の防止を求めています。**認知症カフェをこの位置づけで運営します
第 20 条　研究等の推進等	本人・家族の実態の把握、次期調査への反映	基礎研究・臨床研究は国の役割です。**同条第 2 項は、社会参加の在り方や社会環境の整備についての調査研究を地方公共団体にも求めており、本町の役割は実態の把握にあります**
第 21 条　認知症の予防等	認知機能低下のリスクの把握、通いの場等での予防活動、早期発見・早期診断・早期対応	認知機能の低下は 65〜69 歳で 39.1％が該当。早い段階からの取組。**同条第 2 項は地域包括支援センター・医療機関・民間団体の連携協力体制の整備を求めています**

※ 第 9 期までは認知症施策推進大綱（令和元年）の 5 本柱（普及啓発・本人発信支援／予防／医療・ケア・介護サービス・介護者への支援／認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援／研究開発・産業促進・国際展開）で整理していました。**第 10 期は、認知症基本法の基本的施策の条立てに組み替えています。**大綱の柱では落ちていた若年性認知症・移動のための交通手段の確保・消費生活被害の防止・孤立の防止が、法では名指しされているためです。

【表 75】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（9）

成果指標（案）	現状値	目標値
認知症に関する相談窓口の認知度	**33.2％（令和 7 年度調査）**	【協議会で設定】
認知症初期集中支援チームの対象者の把握件数	訪問実績 0 件（令和 5 年度）	【協議会で設定】
認知症地域支援推進員の活動実績	配置 4 人（令和 6 年 3 月）	【協議会で設定】
認知症カフェの箇所数・参加者数	1 か所（令和 6 年 4 月）	【協議会で設定】
認知症サポーター数（65 歳以上人口 10 万対）	27,591（令和 5 年。福島県 36,515）	【協議会で設定】

※ 初期集中支援チームの指標は、訪問件数ではなく**対象者の把握件数**で置きます。訪問実績 0 件は県内 59 市町村のうち 30 団体に共通しており、件数を目標にすると件数を作ることが目的化するためです。

※ 資料編に、認知症施策推進基本計画の各項目と本計画の対応表を掲載します。

※ 本計画の策定にあたり認知症の人及びその家族等の意見を聴いた方法は【町データ待ち】。認知症基本法第 13 条第 3 項が準用する第 12 条第 3 項は、市町村計画の案の作成にあたり**認知症の人及び家族等の意見を聴くよう努める**こととしています。策定委員会の委員構成のほか、家族会・認知症カフェでの意見聴取の機会を設けるかを検討します。

④ 災害時等の要支援者への対応

【現状と課題】令和 7 年度調査では、**災害時に一人で避難できない方が 14.2％**、災害時に助けてくれる人がいない方が 11.3％でした。高齢者人口 3,483 人に換算すると、それぞれ約 495 人、約 394 人と推計されます。

【施策の方向】避難行動要支援者名簿の整備と個別避難計画の策定を進めます。**一般的な防災・感染症対策は第 3 期地域福祉計画及び地域防災計画が担うため、本計画では避難行動要支援者名簿・個別避難計画・福祉避難所に絞ります。**

【関連データ】

【表 76】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（10）

指標	値	時点	出所
災害時に一人で避難できない	14.20％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
災害時に助けてくれる人がいない	11.30％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
閉じこもり	24.10％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 77】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（11）

主な事業	内容	財源
避難行動要支援者名簿	名簿の整備と更新、地域の関係者との共有	一般会計、防災関連財源
個別避難計画の策定推進	介護支援専門員・相談支援専門員等の福祉専門職の関与による作成	同上
福祉避難所	指定・協定の締結、受入体制の確認、資機材の整備	同上
感染症発生時の対応	介護サービス事業所の業務継続計画（BCP）の確認、連絡体制	—

【表 78】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（12）

成果指標（案）	現状値	目標値

個別避難計画の策定率	【町データ待ち】	【協議会で設定】
（参考）対象規模	一人で避難できない方 約495人（調査からの推計）	—
福祉避難所の指定数	【町データ待ち】	【協議会で設定】

⑤ 多様な生活支援の充実

【現状と課題】令和7年度調査では、在宅生活の継続に必要な支援として**「移送サービス」が20.8％で最多**であり、「外出同行（通院、買い物など）」が15.6％で続きます。前回調査でも移送サービスが21.2％で最多であり、構造は変わっていません。一方、実際に移送サービスを利用している方は6.8％にとどまり、**必要としている方の3分の1しか利用に至っていません。**

介護保険の訪問介護のうち、通院等乗降介助の介護SCRは441.5（全国＝100、令和5年度）で、県内59市町村のうち6番目に高い値です。 通院の移動を介護保険で支えている度合いが高く、移送の需要の大きさを裏づけています。

外出する際の主な移動手段は「自動車（自分で運転）」が73.2％を占めます。現時点で「移動手段がない」ことを困りごととして挙げる方は4.9％ですが、**免許返納が進めば、この層が一斉に移送支援の対象となります。**

また、主な介護者の68.1％が「外出の付き添い、送迎等」を行っており、27.6％がこれを不安に感じています。**送迎の負担が家族介護者に集中している**構造です。

これに対し、介護予防・日常生活支援総合事業の「その他の生活支援サービス」（配食・見守り等）の実績は、令和6・7年度とも0件です（②の表）。調査で最も要望の多い支援が、総合事業の枠組みとしては用意されているのに事業として動いていない状態です。移送は総合事業の対象外であるため任意事業又は一般会計によることになりますが、配食・見守りは総合事業で実施できます。**どの制度で担うかを決めないまま要望だけが残っている構造を、第10期で整理します。**

短期入所系サービスの自給率は12.5ポイント低下しており、町内での受入が縮小しています。主な介護者の69.8％が60歳以上であることを踏まえると、レスパイト機能の確保が重要です。

【施策の方向】移送・外出支援を、生活支援の中心的な課題として位置づけます。介護保険の地域支援事業（任意事業）で対応する部分と、地域公共交通計画に委ねる部分を明確に切り分けます。また、レスパイト機能の確保を家族介護者支援の柱とします。

【関連データ】

【表79】第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（13）

指標	値	時点	出所
外出を控えている	19.80％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
理由　足腰などの痛み	57.00％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
理由　交通手段がない	17.60％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
移動手段　自動車（自分で運転）	73.20％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
必要な支援　移送サービス	20.80％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同（前回）	21.20％	第9期計画	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
必要な支援　外出同行	15.60％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域

			ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 80】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（14）

主な事業	内容	財源
移送・外出支援	移送サービス、外出同行、通院等の支援。**地域公共交通計画との切り分けを明確にする**	任意事業、一般会計、地域公共交通
レスパイトの確保	短期入所の受入体制の確保、緊急時の受入、家族介護者の休養支援	介護保険給付、任意事業
配食・見守り・緊急通報	配食サービス、緊急通報装置の設置、安否確認	任意事業、一般会計
住宅改修・福祉用具	住宅改修費の支給、福祉用具の貸与・購入費の支給	介護保険給付
家族介護支援	介護用品の給付、家族介護者の交流・相談、**仕事と介護の両立支援**	任意事業、一般会計

仕事と介護の両立支援については、次の状況を踏まえて設計します。

【表 81】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（15）

調査結果	値
主な介護者が就労している（フルタイム 28.1％＋パートタイム 18.4％）	**46.5％**
介護を理由に離職・転職した家族・親族がいる	**12.9％**
働き方の調整を行っていない	43.0％
仕事と介護を続けていくのは難しい	16.2％
必要な支援：労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）	25.6％
必要な支援：介護休業・介護休暇等の制度の充実	24.4％
必要な支援：介護をしている従業員への経済的な支援	22.1％
必要な支援：制度を利用しやすい職場づくり	16.3％

必要とされている支援の多くは、勤め先の制度に関するものです。町として直接実施できる範囲は限られますが、町内事業所への情報提供と働きかけ、介護休業制度等の周知、相談窓口の設置により支援します。

【表 82】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（16）

成果指標（案）	現状値	目標値
移送・外出支援の利用者数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
短期入所の利用者数・利用日数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
配食・緊急通報等の利用者数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
仕事と介護の両立に関する相談・周知の実施	【町データ待ち】	【協議会で設定】

⑥ 介護人材の確保とサービスの質の向上

【現状と課題】居宅介護支援事業所が 5 か所から 3 か所に減少し、訪問看護は 1 か所です。介護サービス自給率は令和 5 年度の 72.43％から令和 7 年度の 67.57％へ低下しており、町外のサービスへの依存が拡大しています。第 3 期地域福祉計画の関係団体ヒアリングでも、「移動支援や障がい者へのヘルパーが不足している」との指摘がありました。

【施策の方向】町内事業所の人材確保を支援するとともに、ICT・介護テクノロジーの導入による生産性の向上を進めます。県事業・地域医療介護総合確保基金の活用を図ります。

【関連データ】

【表 83】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（17）

指標	値	時点	出所
介護サービス自給率	67.57％	令和 7 年度	地域包括ケア「見える化」システム
同（令和 5 年度）	72.43％	令和 5 年度	地域包括ケア「見える化」システム
介護を理由に離職・転職した	12.90％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
仕事と介護を続けていける	74.40％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
仕事と介護を続けていくのは難しい	16.20％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
両立に効果がある支援　労働時間の柔軟な選択	25.60％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
同　介護休業・介護休暇等の制度の充実	24.40％	令和 7 年度	令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

【表 84】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（18）

主な事業	内容	財源
人材確保の支援	県の人材確保事業との連携、介護の魅力の発信、資格取得の支援	地域医療介護総合確保基金、県事業
ICT・介護テクノロジーの導入支援	介護記録の ICT 化、見守り機器、ケアプランデータ連携システム等の情報連携基盤	同上
生産性向上・業務改善	業務改善の助言、文書負担の軽減	同上
研修の実施・支援	事業所職員への研修、認知症対応力の向上、虐待防止・身体拘束適正化	地域支援事業、保険者機能強化推進交付金

【表 85】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（19）

成果指標（案）	現状値	目標値
町内介護サービス事業所数	居宅サービス等 18（令和 6 年度）。施設・居住系は【見える化出力待ち】	維持
介護サービス自給率	67.57％	【協議会で設定】
県事業・基金の活用件数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
介護職員の定着（町内事業所の離職率）	【町データ待ち】	【協議会で設定】

※ 人材の指標は、事業所数だけでなく職員の定着でも測ります。町内事業所の離職率は、介護人材実態調査を実施していないため現状値がありません。把握の方法（事業所への照会等）から協議会でお諮りします（【町データ待ち】）。※ 町内事業所の ICT・ケアプランデータ連携システムの導入状況は【町データ待ち】。※ 地域医療介護総合確保基金のメニューと県の交付要綱は県に確認しています（【町データ待ち】）。

⑦ 在宅医療・介護連携の推進

【現状と課題】在宅医療・介護連携推進事業は、包括的支援事業（社会保障充実分）として実施しています。**医療・介護関係者間の情報共有の体制と、相談窓口の設置・多職種を対象とした研修は、すでに整っています。**

一方、国の評価指標（保険者機能強化推進交付金等）に照らすと、在宅医療・介護連携は、本町の取組がもっとも遅れている分野です。仕組みの面で足りていないのは、**①今後のニーズを踏まえた場面ごとの目指すべき姿の設定、②そこから導かれる課題と対応策の立案、③取組の検証と見直しの仕組み**の３つです。

実績の面では、入退院支援と看取りが弱くなっています。入院時情報連携加算の算定者数割合は全保険者の上位１割にある一方、退院・退所加算の算定者数割合は上位７割にも入っていません。在宅ターミナルケアを受けた患者数割合・看取り加算の算定者数割合も上位７割にとどまります。入院時に介護支援専門員から病院へ情報が渡る流れはできている一方、**退院時に病院から介護支援専門員へ戻る流れと、最期まで在宅で過ごすための支援に課題があります。**

提供量でみても、医療系の居宅サービスが少なくなっています。介護 SCR（令和５年度、全国＝100）は、訪問看護 60.4（令和３年度 79.3 から低下）、居宅療養管理指導 7.2、通所リハビリテーション 52.4 です（資料編 12）。見える化システムの医療介護連携の指標（令和７年、偏差値）でも、看取り介護加算・ターミナルケア加算の算定率が 45.1 と全国平均を下回ります。

【施策の方向】**国の評価指標に沿って、在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿を４つの場面ごとに設定し、課題・対応策・検証の仕組みまでを本計画に定めます。**公立小野町地方綜合病院、田村郡医師会、郡内の医療機関等との連携により進めます。

■ 在宅医療と介護の提供体制の目指すべき姿（４つの場面ごと）

【表 86】第５章基本目標２　安全・安心な暮らしの確保（20）

場面	目指すべき姿	主な取組
① 日常の療養支援	**慢性疾患を持ちながら在宅で暮らす高齢者が、かかりつけ医と介護サービスの双方の支援を受けて住み慣れた地域で療養を続けられる**	医療・介護関係者間の情報共有、多職種による支援の調整、訪問看護の確保
② 入退院支援	**入院時に介護支援専門員から病院へ、退院時に病院から介護支援専門員へ、必要な情報が確実に引き継がれる**	入退院時連携の手順の共有、入院時情報連携加算・退院・退所加算の算定状況の把握
③ 急変時の対応	**急変時の連絡先と対応の手順が、本人・家族・関係者の間であらかじめ共有されている**	急変時の対応方針の共有、救急搬送時の情報提供の仕組み
④ 看取り	**本人の希望を踏まえ、在宅での看取りを選ぶことができる体制がある**	人生会議（ACP）の普及、在宅ターミナルケア・看取りの体制の確保、家族への支援

資料：令和８年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）評価指標 目標Ⅲ－（ⅰ）－1。**同指標は、①日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取りの４つの場面ごとに目指すべき姿を設定することを求めています。**※ 目指すべき姿の内容は、関係機関との調整のうえ確定します（【町データ待ち】）。

【関連データ】

【表 87】第５章基本目標２　安全・安心な暮らしの確保（21）

指標	値	時点	出所
支援Ⅲ　在宅医療・在宅介護連携の得点	55 点	令和８年度	令和８年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）
うち体制・取組の配点	68 点	令和８年度	令和８年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）
うち活動の配点	32 点	令和８年度	令和８年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）

交付金の合計	537 点	令和 8 年度	令和 8 年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）
市町村分の平均	454.80 点	令和 8 年度	令和 8 年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）
県内順位	13 位	令和 8 年度	令和 8 年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）

【表 88】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（22）

主な事業	内容	財源
在宅医療・介護連携推進事業	**4 つの場面ごとの目指すべき姿に基づく課題の検討と対応策の立案**、医療・介護関係者の情報共有、相談支援、退院時連携	包括的支援事業（社会保障充実分）
多職種による研修	**グループワーク等の参加型研修、事例検討会。県・医師会主催のものへの主体的な関与を含む**	同上
取組の検証と見直し	**毎年度、評価指標に基づく検証を行い、課題分析の結果を記録として整理したうえで見直します**	同上

【表 89】第 5 章基本目標 2　安全・安心な暮らしの確保（23）

成果指標（案）	現状値	目標値
4 つの場面ごとの目指すべき姿の設定	未設定	**令和 9 年度に設定**
多職種研修の開催回数・参加者数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
入院時情報連携加算の算定者数割合	【見える化出力待ち】	【協議会で設定】
退院・退所加算の算定者数割合	【見える化出力待ち】	【協議会で設定】
取組の検証の実施	—	**毎年度実施**

基本目標 3　介護サービスの充実

① 自立支援・重度化防止に向けた取り組み

【現状と課題】介護保険特別会計の実質収支は 10 年度連続でプラスであり、保険給付費は平成 29 年度をピークにほぼ横ばいで推移しています。介護保険事業状況報告（年報）により、令和 3〜7 年度の実績が確定しました。

保険給付費（総給付費）は令和 3 年度 1,060.7 百万円から令和 7 年度 1,005.1 百万円へ 5.2％減っています。同じ期間に第 1 号被保険者数は 3,498 人から 3,443 人へ 1.6％しか減っておらず、**第 1 号被保険者 1 人当たりの給付費は 303.2 千円から 291.9 千円へ 3.7％下がりました。**

ただし、これを給付適正化の成果と評価することには慎重であるべきです。認定率は県内でも高い方にある一方、給付月額は県内中位であり、在宅の要介護認定者の 42.1％がサービスを利用していないことを踏まえると、**認定と利用のギャップの裏返しである可能性があります。**

また、令和 7 年度は認定者数が 944 人から 792 人へ 16.1％減る一方、受給者延は 4.6％減、給付費は 7.4％減にとどまりました。**認定者の減り方だけが給付の減り方の 2 倍以上であり、これを適正化の成果とみることはできません。**令和 7 年 8〜9 月の計上方法の変更の有無を確認しています（【町データ待ち】）。

【施策の方向】地域ケア会議による自立支援型ケアマネジメントを進めるとともに、介護給付の適正化に取り組みます。

【関連データ】

【表 90】第 5 章基本目標 3　介護サービスの充実

指標	値	時点	出所
推進Ⅱ　公正・公平な給付の得点	84 点	令和 8 年度	令和 8 年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）
うち体制・取組	68 点	令和 8 年度	令和 8 年度 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）
要介護認定率（性・年齢調整後）の地域差指数	1.24	令和 7 年度	地域包括ケア「見える化」システム
受給率の地域差指数	1.07	令和 7 年度	地域包括ケア「見える化」システム
第 1 号被保険者 1 人あたり給付月額の地域差指数	1.08	令和 7 年度	地域包括ケア「見える化」システム
認定者数	792 人	令和 7 年度末	介護保険事業状況報告（年報）様式 1 の 5
同（前年度末）	944 人	令和 6 年度末	介護保険事業状況報告（年報）様式 1 の 5

【表 91】第 5 章基本目標 3　介護サービスの充実（2）

主な事業	内容	財源
地域ケア会議	自立支援型ケアマネジメントの検討、リハビリテーション専門職等の関与	包括的支援事業
介護給付適正化	① 要介護認定の適正化（認定調査結果の点検）、② ケアプランの点検（住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与調査を含む）、③ 縦覧点検・医療情報との突合	保険者機能強化推進交付金
地域リハビリテーション活動支援	通いの場等への専門職の関与	地域支援事業

【表 92】第 5 章基本目標 3　介護サービスの充実（3）

成果指標（案）	現状値	目標値
地域ケア会議の開催回数・検討件数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
要介護認定の適正化の実施状況	**実施**	**継続**
ケアプラン点検の実施件数	【町データ待ち】	【協議会で設定】
医療情報との突合の実施割合	**全国上位 1 割（令和 6 年度）**	**水準の維持**
要介護度の維持・改善率	【町データ待ち】	【協議会で設定】

※ 主要 3 事業の実施状況は、令和 8 年度保険者機能強化推進交付金の該当状況調査に対する本町の回答（3 事業の全てを実施）による。同調査は令和 7 年度の実施（予定を含む）の状況を問うものである。※ 要介護認定の適正化の実施の内容（認定調査の委託の有無と点検件数）は確認中です（【町データ待ち】）。特に要介護認定の適正化については、認定者数の推移との関係を確認する必要があります。※ 医療情報との突合の実施割合は、令和 6 年度実績を全保険者の中で相対評価したもの（上位 1 割）である。

本町は、介護保険法第117条第5項に基づく市町村介護給付適正化計画を本計画に包含し、本項に定めます。「介護給付適正化計画」に関する指針（令和5年9月12日 老介発0912第1号）が求める事業ごとの毎年度の定量的な目標は次のとおりです。

【表93】第5章基本目標3　介護サービスの充実（4）

	事業	指標	令和9年度	令和10年度	令和11年度
①	要介護認定の適正化	認定調査の点検件数（委託分）	【協議会で設定】	【協議会で設定】	【協議会で設定】
①		一次判定から二次判定への軽重度変更率の分析	年1回	年1回	年1回
①		認定調査項目別の選択状況の全国比較による分析	年1回	年1回	年1回
②	ケアプランの点検	点検を行う居宅介護支援事業所数	3事業所	3事業所	3事業所
②		ケアプランの点検件数	【協議会で設定】	【協議会で設定】	【協議会で設定】
②		住宅改修の点検件数	【協議会で設定】	【協議会で設定】	【協議会で設定】
②		福祉用具購入・貸与調査の件数	【協議会で設定】	【協議会で設定】	【協議会で設定】
③	縦覧点検・医療情報との突合	縦覧点検4帳票の全件点検	4帳票	4帳票	4帳票
③		医療情報との突合（突合区分01・02）の点検割合	100％	100％	100％

資料：「介護給付適正化計画」に関する指針（令和5年9月12日 老介発0912第1号）第二の(2)①。※ 【協議会で設定】としたものは、実績及び委託の状況を確かめたうえで協議会にお諮りするものです。※ 本項の位置づけ（節として置くか、本項に置くか、別冊とするか）は協議会にお諮りします。

主要3事業は、いずれも実施しています。縦覧点検は、効果が高いとされる4帳票のすべてについて全件点検を行っています。医療情報との突合の実施割合は、全国的にみて高い水準にあります（令和6年度実績で全保険者の上位1割）。

一方、ケアプラン等の点検は、実施の水準が全国的にみて低位にとどまっています。国の評価指標は、この実施割合を全保険者の中での相対評価（上位7割・5割・3割・1割）で判定しており、本町は上位7割に入っていません。**点検件数は、対象者数に点検対象とした月数を乗じて数えます。**町内の居宅介護支援事業所3か所について、**事業所あたりの件数と点検する月数を定め、令和9年度当初から件数を積み上げます。**

なお、介護給付費財政調整交付金の算定に当たっては、主要3事業の取組状況が勘案されることとされています（同指針 第二の(2)④）。本計画の保険料の算定には、この勘案を織り込んでいません。算定の方法と本町の交付割合の見通しについて、福島県に確認しています（【町データ待ち】）。

② 介護保険サービス等の充実

【現状と課題】本町の要介護認定率は性・年齢調整後の地域差指数で1.24と全国平均を24％上回り、**県内でも高い方にあります**（令和7年3月末の合計認定率26.8％は県内2位）。一方、第1号被保険者1人あたり給付月額は1.08にとどまり、第1号被保険者1人あたり給付月額は、在宅サービスが県内28位／59、施設・居住系が県内33位／59と中位です。

令和7年度の在宅介護実態調査により、**在宅の要介護認定者の42.1％が介護保険サービスを利用していない**ことが確認されました。その理由は次のとおりです。

【表94】第5章基本目標3　介護サービスの充実（5）

利用していない理由	割合	区分
現状では、サービスを利用するほどの状態ではない	**46.8％**	需要側
本人にサービス利用の希望がない	**29.2％**	需要側
家族が介護をするため必要ない	**16.9％**	需要側
住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため	5.2％	—
サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない	4.5％	相談体制
利用料を支払うのが難しい	3.9％	費用
以前、利用していたサービスに不満があった	0.6％	供給側
利用したいサービスが利用できない、身近にない	**0.6％（1人）**	供給側

※ 本設問は、サービスを利用していないと回答した154人に対する**複数回答**である。**割合は延べの選択率であり、足し合わせても回答者に占める割合にはならない**（全項目の合計は132.3％）。**人数に直すと、状態ではない72人・本人の希望なし45人・家族が介護26人に対し、供給側の2項目はいずれも1人である。**ほかにその他25人・無回答13人がある。

供給側の理由を挙げた方は各1人にとどまり、費用は3.9％（6人）、手続きの分かりにくさは4.5％（7人）です。上位3つはいずれも需要側の理由です。すなわち、認定を受けているがサービスを必要とする状態に至っていない層と、本人に利用意向がない層が多数であるということです。これは認定率が高く給付月額が中位であるという構造とよく整合します。

【施策の方向】**「認定と利用をつなぐ支援」を新たに施策として位置づけます。**ただし、その内容は供給確保ではなく、次の3点を軸とします。

【表95】第5章基本目標3　介護サービスの充実（6）

区分	内容	根拠
① 認定の運用の確認	サービス利用の必要が生じる前の申請がどの程度あるかを把握する。認定を受けること自体は制度上妨げられないが、認定率が県内でも高い方にある理由の説明につながる	「利用するほどの状態ではない」46.8％
② 本人の利用意向への働きかけ	サービスの内容と効果の理解促進、体験機会の提供。介護予防事業への利用意向が9割あることと対照的である	「本人に利用の希望がない」29.2％
③ 家族介護に依存する層への支援	レスパイト機能の確保（基本目標2⑤）。主な介護者の69.8％が60歳以上であり、短期入所系の自給率は12.5ポイント低下している	「家族が介護をするため必要ない」16.9％

※ 供給確保の優先度は下げますが、本結果は未利用者154人の回答であり、現に利用している203人が供給に満足していることを示すものではありません。居宅介護支援事業所5→3、訪問看護1事業所、短期入所系の自給率低下という供給側の事実は残るため、基本目標2②・⑤・⑥で引き続き対応します。

その他の主な事業は次のとおりです。

【関連データ】

【表96】第5章基本目標3　介護サービスの充実（7）

指標	値	時点	出所
在宅の認定者でサービスを利用していない方	42.10％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
理由　利用するほどの状態ではない	46.80％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
理由　本人に利用の希望がない	29.20％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査

理由　家族が介護をするため必要ない	16.90％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
理由　利用したいサービスが身近にない	0.60％	令和7年度	令和7年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査
給付月額の県内順位（在宅サービス）	28位／59	令和7年度	地域包括ケア「見える化」システム
給付月額の県内順位（施設・居住系）	33位／59	令和7年度	地域包括ケア「見える化」システム
介護サービス自給率	67.57％	令和7年度	地域包括ケア「見える化」システム

【表97】第5章基本目標3　介護サービスの充実（8）

主な事業	内容
日常生活圏域の設定	本町は町全体を1つの日常生活圏域とする
サービスの質の向上と利用者支援	事業所への指導・助言、苦情への対応、情報公表制度の活用
文書負担の軽減	申請・報告様式の簡素化、電子申請の活用
認定と利用をつなぐ支援	認定後にサービス利用に至っていない方への働きかけ、未利用理由の継続的な把握、地域包括支援センターによる相談

町内の定員と令和11年度の見込量を突き合わせると、次のとおりです。

【表98】第5章基本目標3　介護サービスの充実（9）

サービス	町内定員	令和11年度見込	充足率	見方
介護老人福祉施設	54人	67.6人／月	**125.1％**	**13.6人が町外の施設の利用にあたる**
地域密着型介護老人福祉施設	58人	43.2人／月	74.4％	定員内
認知症対応型共同生活介護	98人	50.2人／月	51.2％	定員は令和5年度71人から令和6年度98人へ増えている
通所介護	139人／日	59.7人／日	43.0％	定員に余力がある
認知症対応型通所介護	12人／日	3.0人／日	25.3％	同上
小規模多機能型居宅介護	通い30人／日	31.3人／月	—	**登録定員の上限は29人。1事業所であれば超える**
介護老人保健施設・介護医療院・特定施設	町内になし	34.1人／月	—	すべて町外の事業所の利用

※ 定員は地域包括ケア「見える化」システムのD 25〜D 27（令和7年度）による。出典は介護サービス情報公表システム。
※ 通所系は見込延べ日数を月26日の営業日で割って1日あたりの人数にしている。**※ 福島県保健医療計画（第八次）図表12−2−9は、本町の介護医療院を58人と記載していますが、同じ見える化システムのD 25は、本町の介護医療院を平成27年度から令和7年度まで一貫して「−」としています。** 58人は、**本町の地域密着型介護老人福祉施設の定員**です（令和2年度以降58人）。本計画はD 25の原票によります。

在宅・通所・地域密着型はいずれも定員に余力があり、供給の制約が利用を妨げている状況にはありません。未利用理由の上位3つが需要側のもので、供給側の理由を挙げた方が各1人にとどまる調査結果と整合します。一方、**施設サービスは町内定員を超えて町外の施設に依存しており、介護老人保健施設と介護医療院は町内に施設がありません。**第10期において施設整備を行うかどうかは、在宅の要介護認定者の24.0％が入所を検討または申込済みであることと、保険料への影響（第5章③）を併せて判断します。

【表 99】第 5 章基本目標 3　介護サービスの充実（10）

成果指標（案）	現状値	目標値
在宅サービス受給率	10.3％	【協議会で設定】
認定者に対する受給者の比率	68.6％（令和 8 年 3 月）	【協議会で設定】
サービス未利用者の割合	**42.1％**	【協議会で設定】
未利用理由の把握状況	令和 7 年度調査で把握	次期調査で継続把握
介護老人福祉施設の町内自給率	79.9％（54 人÷67.6 人）	【協議会で設定】

第6章　介護保険事業等の見込み

サービス見込量は自然体推計によります。令和8年度を国保連合会業務統計表（月報）の実績で置き、第1号被保険者1人当たりの給付費を据え置いて第10期将来推計用推計人口で延ばしたものです。地域包括ケア「見える化」システムの自然体推計（利用率・1人1月あたり給付費の変化を0とする置き方）と総額の置き方が同じです。**ただし区分別の延ばし方は異なり、見える化は施設を利用者数一定とします。**差は保険料の月額で13円です（100円未満切上げ後の水準は変わりません）。

令和8年度は、国保連月報の4〜6月提供分が前年の同じ月の96.0％であることによります。見える化システムのワークシートは令和8年度の1か月分を年換算して実績値としていますが、1か月では年度の水準を代表できません。月報は3か月分あり、前年の同じ提供月と比べられます。

認定者数を基礎としていないのは、令和7年9月審査分に認定者数の断層があり、推計の基礎として安定しないためです（第2章6）。

1　要介護認定者数の見込み

要介護認定者数の見込みは、年齢階層別の認定率を令和7年度で据え置き、第10期将来推計用推計人口に乗じて算定しています。算定の過程は第2章6に示しています。

【表100】要介護認定者数の見込み

区分	令和9年度	令和10年度	令和11年度
第1号被保険者数（人）	3,438	3,428	3,418
認定者数（人）	782	777	772
認定率（％）	22.75	22.67	22.59

※サービス見込量は認定者数を基礎とせず、第1号被保険者1人当たりの給付費で算定しています。令和7年9月審査分の認定者数に断層があり、推計の基礎として安定しないためです（第2章6）。本節の認定者数は、見込量の妥当性を確かめるための参考です。

2　介護給付等サービスの見込量

見込量は、自然体推計のみによらず、人材の供給制約（第6章6）と、介護サービスの提供状況の地域差を示す指標（介護SCR）などの状況を総合的に勘案して定めます（全国介護保険担当課長会議資料、令和8年7月15日）。**本町の介護SCR（令和5年度、全国＝100）は、介護給付全体で73.0、訪問系33.4に対し、多機能系221.3・施設系117.8です**（資料編12）。訪問系の少なさを小規模多機能型居宅介護等が補っている形であり、見込量はこの提供の構造を前提に置いています。

見込量を立てるにあたって勘案した事項（介護保険法第117条第5項）

社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、**介護保険法第117条第5項**が新たに置かれ、市町村は同条第2項第1号から第3号まで（区域、サービス量の見込み、中長期的な推計）を定めるにあたり、次の2つを**勘案しなければならない**こととされました（施行　令和9年4月1日。本計画の期間の初日に当たります）。本計画では次のとおり勘案しています。

【表101】第6章2　介護給付等サービスの見込量

勘案する事項	区域の単位	本計画での扱い	記載箇所

① 住まいの入居定員総数（第1号） 老人福祉法第29条第1項の届出をした有料老人ホーム及び高齢者住まい法第7条第5項の登録住宅の、それぞれの入居定員総数（特定施設入居者生活介護等の**指定を受けていないものに限る**）	**本町**が定める区域	介護保険給付によらない住まいの入居者も居宅サービスを利用するため、入居定員は在宅サービスの見込量に影響します。町内の該当施設の有無と入居定員は【町データ待ち】であり、**確認のうえ見込量を置き直します**	第2章5
② 医療と介護の連携の状況（第2号） 医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者・居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況	**県**が定める区域（本町は**県中医療圏**）	**本町は県中医療圏に属し、町内には公立小野町地方綜合病院があります。同院は、本町と田村市・平田村・川内村・いわき市の2市1町2村で運営する病院です**（第9期計画 第4章（4）②）。県の保健医療計画は、同院を圏域内の病院として掲げています。**在宅療養支援病院・診療所は町内に2か所**です。退院支援・日常の療養支援・急変時の対応・看取りの4場面について連携の状況を整理し、見込量のうち医療系サービス（訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導）の置き方に反映しました	第2章5、第5章 基本目標2⑦

資料：厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案　新旧対照条文」（令和8年法律第51号・全353頁）。**区域の単位が2つで異なる点（本町の区域／県の区域）は条文の文言によります。第2号の「県が定める区域」は、本町では県中医療圏（郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町）に当たります。**在宅療養支援病院・診療所の箇所数は、福島県保健医療計画（第八次）第12章第2節 図表12−2−8（令和3年3月31日現在）による。

〔介護給付（要介護1〜5）〕

【表102】第6章2　介護給付等サービスの見込量（2）

サービス	単位	令和7年度（実績）	令和9年度	令和10年度	令和11年度
訪問介護	回／月	792	754	749	743
	人／月	51.2	48.7	48.4	48.0
訪問入浴介護	回／月	17	16	16	16
	人／月	4.8	4.6	4.6	4.5
訪問看護	回／月	273	260	258	256
	人／月	41.8	39.8	39.5	39.2
訪問リハビリテーション	回／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
居宅療養管理指導	人／月	9.1	8.7	8.6	8.5
通所介護	回／月	1,531	1,458	1,447	1,436
	人／月	167.5	159.5	158.3	157.1
通所リハビリテーション	回／月	186	177	175	174
	人／月	26.5	25.2	25.0	24.9
短期入所生活介護	日／月	237	225	224	222
	人／月	25.6	24.4	24.2	24.0
短期入所療養介護（介護老人保健施設）	日／月	21	20	20	20
	人／月	3.2	3.1	3.1	3.0
短期入所療養介護（病院	日／月	0	0	0	0

等）					
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
短期入所療養介護（介護医療院）	日／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
福祉用具貸与	人／月	192.8	183.7	182.2	180.8
特定福祉用具販売	人／月	4.0	3.8	3.8	3.8
住宅改修	人／月	3.2	3.0	3.0	3.0
特定施設入居者生活介護	人／月	4.0	3.8	3.8	3.8
居宅介護支援	人／月	255.0	242.9	241.0	239.1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
夜間対応型訪問介護	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
地域密着型通所介護	回／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
認知症対応型通所介護	回／月	95	91	90	89
	人／月	9.0	8.6	8.5	8.4
小規模多機能型居宅介護	人／月	22.2	21.2	21.0	20.9
認知症対応型共同生活介護	人／月	44.6	42.5	42.3	42.0
地域密着型特定施設入居者生活介護	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	人／月	40.8	39.2	39.2	39.2
看護小規模多機能型居宅介護	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護老人福祉施設	人／月	71.1	68.2	68.2	68.2
介護老人保健施設	人／月	27.8	26.7	26.7	26.7
介護療養型医療施設	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護医療院	人／月	1.0	1.0	1.0	1.0

〔予防給付（要支援１・２）〕

【表103】第６章２　介護給付等サービスの見込量（3）

サービス	単位	令和７年度（実績）	令和９年度	令和10年度	令和11年度
介護予防訪問入浴介護	回／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護予防訪問看護	回／月	32	31	30	30
	人／月	7.6	7.2	7.2	7.1
介護予防訪問リハビリテーション	回／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護予防居宅療養管理指導	人／月	2.1	2.0	2.0	2.0
介護予防通所リハビリテーション	人／月	27.0	25.7	25.5	25.3
介護予防短期入所生活介護	日／月	3	3	3	3

	人／月	0.8	0.7	0.7	0.7
介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設）	日／月	0	0	0	0
	人／月	0.1	0.1	0.1	0.1
介護予防短期入所療養介護（病院等）	日／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護予防短期入所療養介護（介護医療院）	日／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護予防福祉用具貸与	人／月	54.2	51.7	51.3	50.9
特定介護予防福祉用具販売	人／月	2.5	2.4	2.4	2.3
介護予防住宅改修	人／月	1.8	1.7	1.7	1.7
介護予防特定施設入居者生活介護	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護予防支援	人／月	74.8	71.2	70.6	70.1
介護予防認知症対応型通所介護	回／月	0	0	0	0
	人／月	0.0	0.0	0.0	0.0
介護予防小規模多機能型居宅介護	人／月	7.1	6.7	6.7	6.6
介護予防認知症対応型共同生活介護	人／月	1.2	1.1	1.1	1.1

※ 令和 7 年度の実績は、量（回・日数）と利用者数が地域包括ケア「見える化」システムのワークシート、給付費が介護保険事業状況報告（年報）様式 2 による。**ワークシートの「回数」は給付実績情報の回数であり、国保連合会業務統計表（月報）の実日数とは別のものである。**訪問介護では回数が日数を 26％、訪問看護では 32％上回る。計画書は回数で表記するため、ワークシートの値を採った。※ 第 10 期の見込みは、令和 7 年度の実績に「見込件数÷令和 7 年度の件数」を乗じたもの。見込件数は第 1 号被保険者 1 人当たりの利用率（基準期間の平均）×第 10 期将来推計用推計人口による。※ 量を載せていないサービスは、月額または日額の包括報酬であり、ワークシートにも回（日）数の欄がない。※ 町内に事業所がなく実績のないサービスも、区域外の事業所を利用した場合に給付が生じるため区分として残している。

3　介護保険サービス事業費の見込み

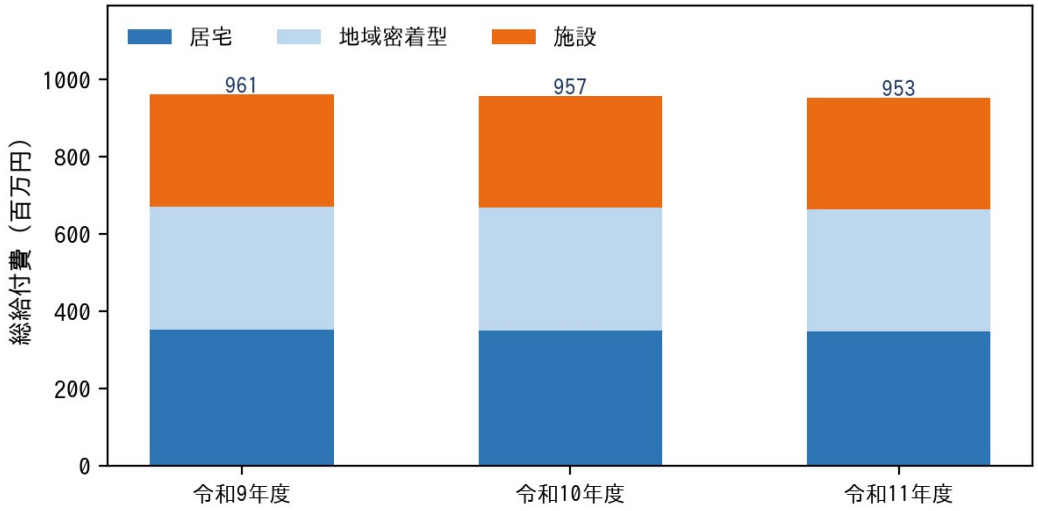
給付費の見込みは次のとおりです。

【表 104】第 6 章 3　介護保険サービス事業費の見込み

区分	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	3 年計
居宅サービス給付費（千円）	352,690	349,979	347,267	1,049,936
地域密着型サービス給付費（千円）	318,448	317,109	315,770	951,328
施設サービス給付費（千円）	289,557	289,557	289,557	868,671
うち介護給付	925,910	922,124	918,338	2,766,373
うち予防給付	34,785	34,521	34,257	103,563
総給付費（千円）	**960,695**	**956,645**	**952,595**	**2,869,936**
特定入所者介護サービス費等（千円）	47,969	47,767	47,565	143,301
高額介護サービス費等（千円）	23,639	23,539	23,439	70,617

高額医療合算介護サービス費等（千円）	2,552	2,542	2,531	7,625
審査支払手数料（千円）	829	823	818	2,470
標準給付費見込額（千円）	**1,035,684**	**1,031,316**	**1,026,948**	**3,093,948**
地域支援事業費（千円）	64,887	64,887	64,887	194,662

【図 4】第 10 期の総給付費の見込み（区分別）



資料：本業務による算定。単位は百万円。**施設サービスは令和 8 年度の利用者数を計画期間中一定として置いている。**

4　地域支援事業の見込量と事業費

地域支援事業費の内訳は次のとおりです。

【表 105】第 6 章 4　地域支援事業の見込量と事業費

区分	事業	令和 6 年度（実績）	令和 9～11 年度（各年度）	3 年計
総合事業	訪問介護相当サービス	4,746	4,746	14,237
総合事業	通所介護相当サービス	21,427	21,427	64,280
総合事業	介護予防ケアマネジメント	2,573	2,573	7,720
総合事業	その他（審査支払手数料等）	531	531	1,592
総合事業	一般介護予防事業	5,305	5,305	15,914
包括的支援事業・任意事業	包括的支援事業・任意事業	29,335	29,335	88,006
合計		**63,916**	**63,916**	**191,749**

※ 単位：千円。実績は年報 様式 4「５．介護保険特別会計経理状況」の歳出の決算額による。総合事業の事業別内訳は年報 様式 4 にないため、国保連合会業務統計表（月報）の総合事業（Ａ１～ＡＦ）で割り付けた。決算額と月報の差は審査支払手数料・高額介護予防サービス相当事業費等とみて「その他」に置いている。**※ 第 10 期は令和 7 年度実績の据え置きとした。令和 7 年度は年報 様式 4 が未入力であるが、地域支援事業交付金（国庫）実績報告書と決算状況（歳出）により実績と事業別の内訳が取れる**（令和 8 年 10 月 15 日受領）。両者は完全に一致し、年報 様式 4 の令和 6 年度の値とも、審査支払手数料を除いた額で 1 円まで一致する。**※ したがって一般介護予防事業費・包括的支援事業・任意事業費の事業別の内訳も、交付金実績報告により確定している。**

地域支援事業については、費用のほかに各年度の量の見込みを定めます（介護保険法第117条第2項第2号）。

【表106】第6章4　地域支援事業の見込量と事業費（2）

区分	事業	単位	令和7年度（実績）	令和9年度	令和10年度	令和11年度
総合事業	訪問介護相当サービス	1月あたり利用者数（人）	24.5	23.1	23.1	23.0
総合事業	通所介護相当サービス	1月あたり利用者数（人）	50.7	50.7	50.5	50.4
総合事業	介護予防ケアマネジメント	年間件数	545.0	552.6	551.0	549.4

このほか、次の13事業について量を定めます。いずれも町の事業実績を要するため、受領後に確定します（【町データ待ち】）。

【表107】第6章4　地域支援事業の見込量と事業費（3）

区分	事業	置く量の単位
総合事業	訪問型サービスA（緩和した基準）	1月あたり利用者数（人）
総合事業	通所型サービスA（緩和した基準）	1月あたり利用者数（人）
総合事業	その他の生活支援サービス	年間延べ利用者数（人）
一般介護予防事業	介護予防普及啓発事業	年間開催回数・延べ参加者数
一般介護予防事業	地域介護予防活動支援事業（通いの場）	箇所数・年間延べ参加者数
一般介護予防事業	地域リハビリテーション活動支援事業	年間派遣回数
包括的支援事業	総合相談支援業務	年間相談件数
包括的支援事業	権利擁護業務	年間対応件数
包括的支援事業	包括的・継続的ケアマネジメント支援業務	地域ケア会議の年間開催回数
包括的支援事業	在宅医療・介護連携推進事業	年間相談件数・研修回数
包括的支援事業	生活支援体制整備事業	生活支援コーディネーター配置数・協議体の開催回数
包括的支援事業	認知症総合支援事業	初期集中支援チームの対象者把握件数・地域支援推進員の配置数・認知症カフェの箇所数
任意事業	家族介護支援事業ほか	年間実施回数・利用者数

※ 介護予防・生活支援サービス事業の3事業は、国保連合会業務統計表（月報）の総合事業（Ａ１～ＡＦ）による。令和6・7年度の第1号被保険者1人当たりの件数率の平均を第10期将来推計用推計人口に乗じて見込んだ。**※ 一般介護予防事業・包括的支援事業・任意事業の量は町の事業実績によるため、受領後に確定する。※ 通いの場は、見える化システムでは週1回以上が平成28年度以降0か所である一方、令和7年度調査では週1回以上の参加が5.5％（高齢者人口換算で約190人）あります。**量の見込みを置く前に実態の確認を行います。

※ 給付費は年報 様式2 の令和7年度のサービス別実績に、自然体推計の係数を乗じて求めた。係数は、国保連月報による令和8年度の前年同期比 0.9598 を起点に、**見える化システムの自然体推計の仕様にそろえて区分別に置いた。**施設は利用者数一定（3年とも 0.9598）、居住系は認定者数で延ばして 0.9538・0.9478・0.9417、在宅は在宅対象者（認定者数−施設−居住系）で延ばして 0.9525・0.9451・0.9377 である。**人数・量・給付費には同じ係数を当てているため、1人1月あたりの回（日）数と給付費は令和7年度のまま動かない。※ 従前は第1号被保険者1人当たりの利用率を令和5〜7年度の平均で**

置いていた。その方式では令和8年度が令和7年度の1.0171倍となり、月報の実績（0.9598）より6.0％高く出る。令和5・6年度の利用率が令和7年度より高く、3年平均が下がり続けている系列を上に引いているためである。従前の方式による総給付費は3年計3,048,418千円で、本計画の2,869,936千円より178,482千円多い（保険料のケース比較を参照）。**令和9年度の介護報酬改定率は0.0％で置いている。**※ 特定入所者介護サービス費等・高額介護サービス費等・高額医療合算介護サービス費等は、総給付費に対する比率（令和5〜7年度の平均）で見込んだ。※ 審査支払手数料は1件60円で仮置きした。※ 地域支援事業費は年報 様式4「５．介護保険特別会計経理状況」の**令和7年度実績**（総合事業34,573千円＋包括的支援事業・任意事業30,314千円＝64,887千円）を3年度とも据え置いた。内訳は次表による。**前年度（令和6年度63,916千円）からは+1.5％である。**

参考として、第9期計画の見込額は次のとおりです。

【表108】第6章4　地域支援事業の見込量と事業費（4）

区分	令和6年度	令和7年度	令和8年度	3年計
標準給付費見込額（千円）	1,185,894	1,189,712	1,190,880	3,566,486
うち総給付費	1,106,604	1,110,764	1,112,373	—
地域支援事業費（千円）	67,320	69,120	70,820	207,260
うち介護予防・日常生活支援総合事業費	36,220	37,020	37,720	—

第10期の標準給付費見込額（3年計3,093,948千円）は、第9期の見込額3,566,486千円の86.8％です。第9期の見込みに対する実績は、令和6年度98.6％、令和7年度91.1％でした。第9期と同じ水準に置くと、同じ幅の過大見積りを繰り返すことになります。

※ 令和8年度の水準について。国保連合会業務統計表（月報）により、令和8年度4〜6月提供分の給付額は前年の同じ月の96.0％であることが確かめられます。**上表は、この水準を起点として人口で延ばした自然体推計によります（総給付費3年計2,869,936千円）。従前は第1号被保険者1人当たりの利用率を令和5〜7年度の平均で置いていましたが、その方式では令和8年度が実績より6.0％高く出ます。**令和5・6年度の利用率が令和7年度より高く、3年平均が下がり続けている系列を上に引いているためです。従前の方式による総給付費は3年計3,048,418千円で、本計画より178,482千円多くなります（保険料のケース比較を参照）。**なお、月報を使わない置き方でも同じところに来ます。**認定者数の伸びを一律に当て、サービス別の趨勢を半分だけ織り込む置き方（乖離の上限20ポイント）では令和8年度が令和7年度の0.9694倍となり、月報による0.9598倍との差は1.0％です。**令和8年度は3か月分しかなく完結年度ではないため、残りの月の実績を見たうえで確定します。**

（参考）特定地域居宅サービス等事業（令和9年4月1日新設）

令和9年4月1日に、地域支援事業に「特定地域居宅サービス等事業」が加わります（介護保険法第115条の45第3項。新設）。区域内に**特定地域**がある市町村は、厚生労働省令で定める基準に従い、特定地域に住所を有する被保険者に対し、次の表のサービス（又はこれに相当するサービス）を**地域支援事業として**行うことができます。

【表109】特定地域居宅サービス等事業の対象（介護保険法第115条の45第3項）

対象となる被保険者	行うことができるサービス
特定地域の区域に住所を有し、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの	訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護
特定地域の区域に住所を有し、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの	介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護

特定地域とは、「人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるもの」です（介護保険法第42条第1項第3号）。定めるのは**県**であり、基準は**厚生労働省令**で定まります。本町の区域が特定地域に定められるかどうかは【町データ待ち】であり、本計画の本文には、指定があることを前提とした記載をしていません。

※ 基準を定める厚生労働省令は、令和8年10月19日現在、公布されていません。 介護保険法施行規則について、令和9年4月1日に効力をもつ版を法令APIで取得したところ、**「特定地域」の語を含む条は1つもありません**（同日現在の最新は令和8年10月1日施行の版）。介護保険法施行令も同じです。**したがって、本計画の策定時点では、本町が特定地域に当たるかどうかを判断する材料がありません。**

※ 費用の扱いが包括的支援事業・任意事業と異なります。 特定地域居宅サービス等事業に要する費用は、介護予防・日常生活支援総合事業と同じく**第2号被保険者の負担（地域支援事業支援交付金）の対象**です（介護保険法第126条第1項）。一方、国が交付する「特定地域支援事業支援額」の対象からは**除かれます**（同法第122条の2第4項）。**したがって、本町が特定地域に定められ、かつ本事業を行う場合は、地域支援事業費と保険料の算定をやり直すことになります。※ 用語に紛らわしさがあります。** 同法第122条の2第4項の「特定地域支援事業支援額」は改正前からある用語で、**ここでいう「特定地域」とは関係がありません。**包括的支援事業・任意事業に係る国の負担の額を指します。

※ この新設により、**同条の項が1つずつ繰り下がります。** 任意事業は第3項から**第4項**に、**地域支援事業費の上限（政令で定める額）の規定は第4項から第5項**に、利用料の請求は第10項から**第11項**になります（全10項→全11項）。本計画で任意事業の根拠を引くときは、令和9年4月1日以後は第115条の45第4項となります。**なお、上限の額を定める介護保険法施行令第37条の13は、令和8年10月19日現在なお「法第115条の45第4項の政令で定める額」と書いており、改正に追従していません。** 法律の改正に政令・省令が追いついていない段階です。

出所：介護保険法（平成9年法律第123号）令和9年4月1日時点。e-Gov法令API（デジタル庁）により令和8年10月19日に取得。改正の本体は社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号。公布 令和8年6月25日）。

5　第1号被保険者の保険料

第1号被保険者の保険料は、標準給付費見込額と地域支援事業費から算定します。本町の第1号保険料月額は平成30年度以降6,600円で据え置かれています。

算定の結果、準備基金を取り崩さない場合の保険料基準額は月額6,053円となります。第9期の6,600円に対し-547円（-8.3％）です。ただし地域支援事業費・介護給付費準備基金の残高・第10期の第1号被保険者負担割合のいずれもが未確定であり、確定値ではありません。

第9期と同じく100円未満を切り上げると6,100円となり、第9期の6,600円から500円下がります。第9期は算定値6,886円を基金3,500万円の取崩により6,597円まで下げたうえで6,600円としたのに対し、第10期は取崩を行わなくてもこの水準になります。給付費の見込みが第9期の86.8％にとどまることによるものです。

ただし、この水準は令和8年度3か月の実績に依っています。令和8年度の残りの月で給付費が持ち直せば、この見込みは上振れします。従前の方式（令和5〜7年度の利用率の平均）によれば月額6,402円（切上げ6,500円）となり、第9期と同額の据え置きになります。**どちらを採るかは、令和8年度の実績を見たうえで協議会にお諮りします。**

【表110】第6章5　第1号被保険者の保険料

区分	第10期（試算）	参考：第9期
標準給付費見込額（3年計）	3,093,948千円	3,566,486千円
地域支援事業費（3年計）	194,662千円	207,260千円
第1号被保険者負担割合	23％（【決定後に記載】）	23％
調整交付金見込交付割合	5.533％（算式）	6.058％（第9期計画の公表値）
保険料収納必要額	739,330千円	832,562千円
介護給付費準備基金取崩額	0千円（【町データ待ち】）	35,000千円
予定保険料収納率	99.35％	99.40％

所得段階別加入割合補正後被保険者数（3年計）	10,245人	10,136人
保険料基準額（月額）	**6,053円**	6,600円（算定値6,886円→取崩後6,597円）

※ 算定の式は次による。①標準給付費＝総給付費＋特定入所者介護サービス費等＋高額介護サービス費等＋高額医療合算介護サービス費等＋審査支払手数料。②第1号被保険者負担分相当額＝（①＋地域支援事業費）×第1号被保険者負担割合。③調整交付金相当額＝（①＋介護予防・日常生活支援総合事業費）×5％。④保険料収納必要額＝②＋③－調整交付金見込額－準備基金取崩額。⑤保険料基準額＝④÷予定保険料収納率÷補正後被保険者数÷12。**③の調整交付金は標準給付費と総合事業費にのみかかり、包括的支援事業・任意事業費は対象外である。**

保険料の水準を左右するのは、給付費の精度ではなく制度側の2つです。第1号被保険者負担割合が1ポイント上がると月額269円、調整交付金の見込交付割合が1ポイント下がると月額262円動きます。いずれも給付費の5％分に相当します。給付費1％は56.9円にとどまります。

【表111】第6章5　第1号被保険者の保険料（2）

項目	動かす幅	月額への効き	確定の見通し
第1号被保険者負担割合	23％→24％（1ポイント）	**+269円**	3年の計画期間ごとに政令で定める。第1期17％から1ポイントずつ上がってきた
調整交付金の見込交付割合	1ポイント（低下）	**+262円**	後期高齢者加入割合・所得段階別加入割合による。国が示す全国値で確定する
介護給付費準備基金の取崩	1,000万円	-82円	**残高は令和5・6年度末とも12,000千円。第9期が見込んだ35,000千円の取崩はこの残高では実行できない。年報 様式4 の保有額は令和4年度末120,000千円から令和5年度末12,000千円へ落ちているが繰入金は全年度ゼロで、系列に矛盾がある**
総給付費・介護報酬改定	1％	+56.9円	令和9年度改定。率は令和8年12月頃
地域支援事業費	1％	+3.6円	**年報 様式4 の令和6年度決算による。事業別の内訳は未受領**

保険料の水準は、次のケースを比較して協議会にお諮りします。

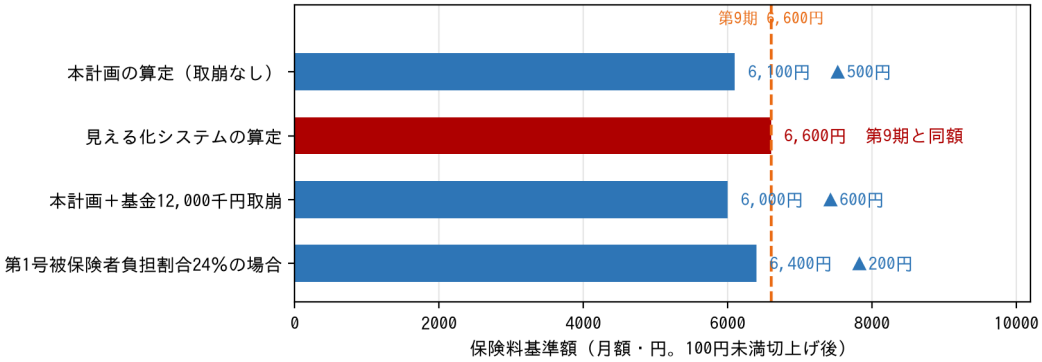
【表112】第6章5　第1号被保険者の保険料（3）

ケース	内容	保険料基準額（月額）	100円未満切上げ	検討の視点
標準ケース	自然体推計により、基金を取り崩さない場合	**6,053円**	**6,100円**	基準となる算定。第9期の6,600円から▲547円（▲8.3％）
基金活用ケース	介護給付費準備基金12,000千円を全額取り崩す場合	**5,955円**	6,000円	**取崩の原資は12,000千円しかない。繰越金144.2百万円の基金積立を含めて検討する**
第9期同額取崩ケース	第9期と同じ35,000千円を取り崩す場合	5,767円	5,800円	**現在の残高では実行できない。基金残高の確認が前提**
負担割合24％ケース	第1号被保険者負担割合が24％となる場合	6,323円	6,400円	政令の公布状況による。第9期までの推移からは上がる可能性がある
従前の方式によるケース	第1号被保険者1人当たりの利用率を令和5〜7年度の平均で置く場合（第4版までの算定）	**6,402円**	**6,500円**	**この方式では令和8年度が令和7年度の1.0171倍となり、国保連月報の実績（0.9598）より6.0％高く出る。**令和5・6年度の利用率が令和7年度

				より高いため
単価の趨勢ケース	単価を令和 7 年度で固定せず、実績の趨勢（年率 +1.13％）で伸ばす場合	**6,248 円**	**6,300 円**	**改定のあった年（+1.25％）と改定のなかった年（+1.09％）で単価の伸びに差がない。固定は過小側の置き方である**
見える化システムによるケース	令和 8 年度を国保連月報の 1 か月分で置く場合（地域包括ケア「見える化」システムの自然体推計）	**6,533 円**	**6,600 円**	**令和 8 年 9 月 28 日に推計が通った。標準給付費は 3,354,617 千円で、標準ケースより 260,669 千円（8.4％）多い。切り上げると第 9 期と同額の据え置きになる**
施設整備ケース	第 10 期に施設整備を行う場合	【決定後に記載】	【決定後に記載】	在宅の要介護認定者の 24.0％が入所を検討または申込済み。町内定員は介護老人福祉施設 54 人・地域密着型 58 人・認知症対応型共同生活介護 98 人
制度改正ケース	国の制度改正（給付と負担の見直し）の影響を織り込む場合	【決定後に記載】	【決定後に記載】	国の基本指針の確定後に反映

※ いずれも地域支援事業費を年報 様式 4 の令和 6 年度決算で置き（3 年計 194,662 千円、うち総合事業費 103,719 千円）、第 1 号被保険者負担割合を 23％、調整交付金見込交付割合を 5.533％として算定した。※ 調整交付金見込額は、調整交付金相当額（5％）と同じ基数（標準給付費見込額＋総合事業費）に見込交付割合を乗じて求める。地域包括ケア「見える化」システムの出力（令和 8 年 9 月 28 日受領のワークシート「5_保険料推計」）と 1 円まで照合して確かめた。※ 見込交付割合は（第 1 号被保険者負担割合＋5％）－第 1 号被保険者負担割合×後期高齢者加入割合補正係数×所得段階別加入割合補正係数で求めた。後期高齢者加入割合補正係数は見える化システムの値（令和 9 年度 0.9558・令和 10 年度 0.9802・令和 11 年度 1.0065）、所得段階別加入割合補正係数は令和 7 年度末の構成による 0.9959。

【図 5】保険料基準額の選択肢（100 円未満切上げ後）



資料：本業務による算定及び地域包括ケア「見える化」システムの出力。**切り上げた水準では 6,100 円と 6,600 円に分かれ、引下げか据え置きかの分かれ目にあたる。**

6　人材の供給制約からみた見込量の妥当性

国が配布する「（改修版）総合事業の充実に向けたワークシート」は、従前相当サービスの利用を過去のトレンドに従って増やし続けることが本当に可能かを、人材の供給の面から確かめることを求めています。本町の将来推計人口を同じ考え方に当てはめると次のとおりです。

【表 113】第 6 章 6　人材の供給制約からみた見込量の妥当性

年	生産年齢人口	認定者数の推計（需要）	生産年齢人口で縮めた供給可能量	過不足
令和 2 年	4,677 人	788 人	788 人	—

令和 7 年	4,286 人	800 人	722 人	**▲78 人（▲9.8%）**
令和 12 年	3,891 人	778 人	656 人	**▲122 人（▲15.7%）**
令和 17 年	3,498 人	805 人	589 人	**▲216 人（▲26.8%）**
令和 22 年	3,118 人	870 人	525 人	**▲345 人（▲39.7%）**
令和 27 年	2,750 人	872 人	463 人	**▲409 人（▲46.9%）**
令和 32 年	2,399 人	808 人	404 人	**▲404 人（▲50.0%）**

※ 認定者数の推計は、年齢階層別認定率（令和 7 年度実績）に国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5 年推計）」を乗じたもの。供給可能量は、令和 2 年（2020 年）の認定者数に、各年の生産年齢人口の令和 2 年に対する比率を乗じたもの。

生産年齢人口は令和 2 年（2020 年）の 4,677 人から令和 32 年（2050 年）の 2,399 人へ半減する一方、認定者数は 788 人から 808 人とほぼ横ばいで推移します。認定者 1 人を支える生産年齢人口は、5.9 人から 3.0 人へ半分になります。

第 10 期（令和 9〜11 年度）の期間中は、なお供給が需要に追いつきます。開きが目立ってくるのは令和 12 年（2030 年）以降です。**本計画がサービス見込量において在宅サービスの利用を増やさず、1 人 1 月あたりの利用回（日）数を令和 7 年度の水準で固定しているのは、この供給の制約とも整合するものです。**

一方で、第 11 期以降に備えた多様なサービス・活動の基盤づくりは、第 10 期のうちに進めておく必要があります。本町の訪問型サービス B・通所型サービス B（住民主体によるサービス）は、**令和 5 年度には合わせて 3 百万円余りの実績がありましたが、令和 7 年度はいずれも 0 円となっています。第 10 期に必要なのは「広げる」ことではなく、いったん途切れたものを立て直すことです。**（第 2 章 7、第 3 章、第 5 章 基本目標 1）。**経緯は【町データ待ち】**

7　見える化システムによる算定との突合

令和 8 年 9 月 28 日、地域包括ケア「見える化」システムへの入力が完了し、推計が通りました。施策反映に係るワーニング（認定者数・施設居住系サービス利用者数・在宅サービス利用者数）はいずれも「該当無し」となりました。**残る 33 件は、本町に提供事業所がない、または該当する利用がないサービスの実績が 0 のまま延びたものであり、推計の誤りによるものではありません。**

システムによる保険料基準額は月額 6,533 円（100 円未満切上げ 6,600 円）で、標準ケースの 6,053 円（同 6,100 円）と 480 円の差があります。差の内訳は次のとおりで、算式そのものは一致しています。

【表 114】第 6 章 7　見える化システムによる算定との突合

入れ替えた前提	保険料基準額（月額）	差	内容
予定保険料収納率を 99.35％→99.40％に	6,050 円	**-3 円**	システムは第 9 期と同じ 99.40％
調整交付金見込交付割合を 5.533％→5.522％に	6,053 円	**+3 円**	**算式は一致。差は 0.011 ポイント**
補正後被保険者数を 10,245 人→10,235 人に	6,062 円	**+9 円**	システムの将来推計人口による
標準給付費をシステムの額に	6,533 円	**+471 円**	**3,093,948 千円→3,354,617 千円（+8.4％）**

差のほとんどは標準給付費の差であり、それは令和 8 年度をどう置くかの違いによるものです。システムは令和 8 年度を国保連月報の 1 か月分で置いており、在宅サービスを 523,408 千円（令和 9 年度）と見込んでいます。**本計画は同 4〜6 月提供分（3 か月）で置いており、前年同期比は 0.9598 です。令和 8 年度の国保連月報が 12 か月そろうのは令和 9 年 5 月であり、それまでどちらが当たっているかを確かめることはできません。**

そのため、協議会には標準ケースと見える化システムによるケースの両方をお示しし、ご判断をいただくこととします。切り上げた水準では、前者が 6,100 円（第 9 期から▲500 円）、後者が 6,600 円（第 9 期と同額の据え置き）となり、引下げか据え置きかの分かれ目にあたります。

所得段階別の保険料率は次のとおり設定します。**段階数と乗率は第 9 期と同じ 13 段階・同一の乗率とすることを案とします。**年額は、標準ケースの基準額（月額 6,053 円）をもとに 100 円未満を切り上げて算出したものです。

【表 115】第 6 章 7　見える化システムによる算定との突合（2）

段階	対象	乗率（案）	年額（案）	被保険者数	構成比	参考：第 9 期の年額
第 1 段階	生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等 82.65 万円以下	0.285	20,800 円	525 人	15.2％	22,600 円
第 2 段階	世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等 82.65 万円超 120 万円以下	0.485	35,300 円	297 人	8.6％	38,500 円
第 3 段階	世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等 120 万円超	0.685	49,800 円	272 人	7.9％	54,300 円
第 4 段階	本人が住民税非課税（世帯に課税者あり）で本人年金収入等 82.65 万円以下	0.900	65,400 円	434 人	12.6％	71,300 円
第 5 段階	本人が住民税非課税（世帯に課税者あり）で本人年金収入等 82.65 万円超	1.000	72,700 円	610 人	17.7％	79,200 円
第 6 段階	本人が住民税課税で合計所得金額 120 万円未満	1.200	87,200 円	491 人	14.3％	95,100 円
第 7 段階	同　120 万円以上 210 万円未満	1.300	94,500 円	418 人	12.1％	103,000 円
第 8 段階	同　210 万円以上 320 万円未満	1.500	109,000 円	231 人	6.7％	118,800 円
第 9 段階	同　320 万円以上 420 万円未満	1.700	123,500 円	77 人	2.2％	134,700 円
第 10 段階	同　420 万円以上 520 万円未満	1.900	138,100 円	36 人	1.0％	150,500 円
第 11 段階	同　520 万円以上 620 万円未満	2.100	152,600 円	14 人	0.4％	166,400 円
第 12 段階	同　620 万円以上 720 万円未満	2.300	167,100 円	7 人	0.2％	182,200 円
第 13 段階	同　720 万円以上	2.400	174,400 円	31 人	0.9％	190,100 円
合計				**3,443 人**	**100.0％**	

※ 被保険者数は年報 様式 1（所得段階別）の令和 7 年度末現在。**合計 3,443 人は第 1 号被保険者数と一致します。**※ 第 9 期の年額は基準額 6,600 円（年額 79,200 円）による。第 10 期の年額は標準ケースの基準額 6,053 円（年額 72,639 円）によるもので、上記のケースのいずれを採るかにより変わります。**※ 年金収入等の基準額は、介護保険法施行令第 38 条（令和 8 年政令第 274 号による改正後）の 82.65 万円によります。**国はこの額を毎年見直す想定としているため、第 10 期の条例を定める時点の額で確定します（【決定後に記載】）。

上表の第 1〜3 段階の乗率（0.285／0.485／0.685）は、公費による低所得者軽減強化を反映した後の、実際に賦課する乗率です。国の標準段階の乗率は 0.455／0.685／0.690 で、軽減相当額は国 2 分の 1・県 4 分の 1・町 4 分の 1 の公費で補填されます。**標準乗率は介護保険法施行令第 38 条第 1 項が 13 段階について定めており、本計画が用いた 13 件すべてが同項と一致することを確かめています**（令和 8 年 10 月 19 日、e-Gov 法令 API により確認。同項は令和 9 年 4 月 1 日時点でも改正されません）。**ただし国は、第 10 期に向けて、高所得者の標準乗率の見直しと、課税化に伴う上昇の緩和を含む標準段階の見直しを検討しています**（社会保障審議会介護保険部会 第 136 回 資料 1、令和 8 年 9 月 18 日）。政令が改正された場合は、段階と乗率を置き直して再算定します（【決定後に記載】）。**したがって保険料基準額の算定では、軽減前の標準乗率で所得段階別加入割合補正後被保険者数を求めます。**第 4 段階以上は賦課する乗率と標準乗率が一致します。第 1〜3 段階に属する方は 1,094 人で、第 1 号被保険者の 31.8％を占めます。

生活保護受給世帯は 65 歳以上が 68％を占めています（第 3 期地域福祉計画）。**低所得者の負担に配慮した現行の乗率を維持することを基本とし、国が示す標準乗率の改定を踏まえて確定します。**

8　介護施設等の整備の基本方針と必要利用定員総数

施設等の整備は、定員を増やすか減らすかだけで決めるものではありません。既にある資源がどれだけ使われているか、町内に事業所がないサービスがあるか、人材が確保できるか、町外の事業所による給付で足りているかをあわせて見て判断します。**町内に事業所がないサービスについては、「整備しない」ということも一つの判断として計画に書きます。**

【表 116】第 6 章 8　介護施設等の整備の基本方針と必要利用定員総数

判断項目	確認すること	本町の基本方針	主な資料
既存資源	定員、入所率・稼働率、空床、待機の状況	**既にある資源を活かすことを優先します。**介護老人福祉施設の町内自給率は 79.9％で、町内の定員に対して町内の方の利用が収まっています	見える化システム、事業所への照会
供給の空白	町内に事業所がないサービス	**町内に事業所がないことと、給付がないことは分けて見ます。**町外の事業所による給付で足りているかを自給率で確かめ、足りている場合は整備しません	見える化システムの自給率、国保連の給付実績
供給制約	従事者数の推移、事業所の休廃止・縮小	**実際に提供できる量で判断します。**生産年齢人口が令和 2 年の 4,677 人から令和 32 年の 2,399 人へ半減する見通しを踏まえ、新たな施設の整備より既存の事業所の継続を優先します	見える化システム、事業所への照会（【町データ待ち】）
広域調整	町外の事業所の利用、事業者間の連携	郡内・県内の事業所との調整により対応します	給付実績、福島県
医療との整合	退院後の受け皿、看取り、医療ニーズ	**公立小野町地方綜合病院及び郡内の医療機関との連携により、退院後の受け皿を確保します。**第 5 章 基本目標 2⑦ の在宅医療・介護連携と一体で進めます	福島県の医療計画、地域医療構想

※ 第10期における施設整備の予定の有無は【決定後に記載】。予定がある場合、保険料の水準が変わります（第6章5の保険料のケース）。

第10期では、新たな施設の整備は見込んでいません。認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数は、現に稼働している定員を前提としています。

介護保険法第117条第2項第1号により各年度の必要利用定員総数を定める地域密着型3サービスについて、第10期の各年度の値は次のとおりです。**町内定員と令和7年度の利用の状況は第2章5に示しています。**

【表117】地域密着型サービスの必要利用定員総数

サービス	令和9年度	令和10年度	令和11年度
認知症対応型共同生活介護	98人	98人	98人
地域密着型特定施設入居者生活介護	0人	0人	0人
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	58人	58人	58人

※ 本町は町全域を1つの日常生活圏域とするため、圏域別の区分は生じません。※ 地域密着型特定施設入居者生活介護は町内に事業所がなく、整備の予定もないため0人とします。

9　老人福祉事業の量の目標

本節は、老人福祉法第20条の8第2項に基づく「当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標」です。 同項は、市町村老人福祉計画に定めることを**義務**としています。本計画は市町村老人福祉計画と一体のものとして策定するものであり（介護保険法第117条第7項・改正後第8項）（第1章2）、本節がこれに当たります。

※ 老人福祉法第20条の8のうち、量の目標を定める第2項は改正されません。ただし**第3項に第3号が新設されます**（下記）。令和9年4月1日施行。e-Gov 法令 API（デジタル庁）により令和8年10月19日に確認。

※ 第3項第3号（新設・努力義務）。 令和9年4月1日から、市町村老人福祉計画には第2項の目標のほか、**「老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者と社会福祉法第4条第3項に規定する支援関係機関との連携に関する事項」**を定めるよう努めるものとされます（社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号））。支援関係機関とは、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関をいいます（社会福祉法第4条第3項）。**本計画では、第5章 基本目標2 及び第4章4（障がい福祉計画との接点）に掲げる関係機関との連携が、これに当たります。** 老人福祉事業を営む者には、介護保険の指定を受けていない事業者（養護老人ホーム、軽費老人ホーム等）も含まれます。

老人福祉事業には、介護保険の見込量と重なるものと、重ならないものがあります。重なるものは第6章2の見込量をそのまま老人福祉事業の量とし、重ならないものを下表に別に掲げます。

【表118】第6章9　老人福祉事業の量の目標

区分	老人福祉法上の事業	本計画での扱い
老人居宅生活支援事業	老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業	**第6章2の見込量による。**訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護が対応する
老人福祉施設（介護保険と重なるもの）	老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、老人介護支援センター	**第6章2及び第6章8による。**特別養護老人ホームは介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設が対応する
老人福祉施設（介護保険と重ならないもの）	**養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター**	**介護保険の見込量にないため、別に量を置きます。**本町及び近隣の施設の状況と、措置の実績は【町データ待ち】です

【表 119】第 6 章 9　老人福祉事業の量の目標（2）

事業・施設	令和 7 年度（実績）	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度
養護老人ホーム（措置人員）	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】
軽費老人ホーム（利用人員）	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】
老人福祉センター（利用延人員）	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】	【町データ待ち】

※ 養護老人ホームへの入所は町の措置によるものであり、介護保険の給付ではありません。 本町に施設がない場合は、措置先の施設と措置人員を掲げます。**町に確認しています（【町データ待ち】）。**※ 老人福祉センターは、本町に該当する施設があるかを含めて確認しています。

※ 本町は既に措置入所を施策として掲げています。 第 9 期計画 第 4 章（1）② は「老人ホームなどへの入所措置」として、**「身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的理由により在宅での生活が極めて困難で、高齢者の福祉に欠けると認められる高齢者を老人ホームに入所させます」**としています。**本節は、この施策に量の目標を付けるものです。**第 10 期で新たに始める事業ではありません。

10　低所得者支援

保険料や利用者負担が重いために必要なサービスを使えない、ということがないようにします。本町では、次の制度を適切に運用し、周知します。

【表 120】第 6 章 10　低所得者支援

制度・取組	内容	確認する指標	状況
保険料の公費軽減	第 1〜3 段階の保険料を公費（国 2 分の 1・県 4 分の 1・町 4 分の 1）により軽減。本町の乗率は 0.285／0.485／0.685	対象者数、適用率	**第 1〜3 段階は 1,094 人（第 1 号被保険者の 31.8％）**
高額介護サービス費	1 か月の利用者負担が上限を超えたときに、超えた分を支給	支給件数、支給額、周知の方法	令和 6・7 年度の支給実績は年報 様式 3 による（【町データ待ち】）
負担限度額認定	施設・短期入所の食費・居住費を、所得等に応じて軽減	認定者数、更新、未申請の把握	認定者数は【町データ待ち】
社会福祉法人等による利用者負担軽減	対象となる法人・サービスの利用者負担を軽減	実施している法人、対象者数	実施状況は【町データ待ち】
納付・利用の相談	**保険料の滞納や、負担を理由とする利用控えを早く把握し、相談・支援につなぎます**	相談件数、分納、必要なサービスへの接続	**保険料収納率は現年度分 98％台で推移（第 2 章 4）**

※ 生活保護受給世帯は 65 歳以上が 68％を占めています（第 3 期地域福祉計画）。**※ 高額介護サービス費は年報 様式 2 の 7、負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）は年報 様式 2 の 5 により、令和 6 年度まで確定しています。**社会福祉法人等軽減の実績は【町データ待ち】です。

11　中長期の見通し（令和 22 年・令和 32 年）

本節は、介護保険法第 117 条第 2 項第 3 号に基づく「介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計」です。 社会福祉法等の一部を改正する法律（令和 8 年法律第 51 号）により、**計画に定めるものとする事項**（義務）として新たに置かれました。施行は**令和 9 年 4 月 1 日**で、**本計画の期間の初日**に当たります。

資料：厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案　新旧対照条文」（令和 8 年法律第 51 号・全 353 頁）。**改正前は第 117 条第 3 項第 3 号（努力義務）で、量・費用・保険料の中長期的な推計をまとめて掲げていました。改正により、量だ**

けが第2項（義務）に移り、地域支援事業の量が加えられました。費用の額と保険料の水準の中長期的な推計は、引き続き第3項第3号（努力義務）です。

第10期の3年間だけを見ていると、見落とすことがあります。第1号被保険者数が減りながら認定者数が増える時期が来るためです。**国が2040年（令和22年）を節目として掲げていることもあり、ここでは令和32年までの姿を置きます。**

置き方は次のとおりです。いずれも実質ベースで、介護報酬の改定は織り込んでいません。認定者数は年齢階層別認定率（令和7年度実績）に将来の年齢階層別人口を乗じたもの、総給付費は認定者1人当たり総給付費（令和11年度の1,234千円）を据え置いて認定者数で延ばしたもの、1人当たりは総給付費を第1号被保険者数（65歳以上人口）で割ったものです。

本節の見通しは、第4章1に定めた「本町の地域包括ケアの姿」を令和22年以降も保てるかを確かめるためのものです。

別の方法による推計とも形が一致します。 介護SCRの将来推計（令和5年度の性・年齢階級別の利用の出現率を据え置き、社人研の推計人口を乗じたもの。2025年＝100）では、本町の介護給付の需要は2040年106.4、2045年107.3、2050年101.0で、下表の総給付費と同じく令和27年（2045年）頃にピークを迎え、令和32年には令和7年並みに戻ります。県中圏域（2040年126.2）や全国（同124.2）より伸びがはるかに小さいことも、本町の特徴です。

【表121】第6章11　中長期の見通し（令和22年・令和32年）

年	第1号被保険者数	認定者数	認定率	総給付費	第1号1人当たり	指数
令和2年	3,389人	788人	23.3％	972百万円	286.9千円	102.9
令和7年	3,455人	800人	23.2％	987百万円	285.7千円	102.5
令和12年	3,406人	778人	22.8％	960百万円	281.9千円	101.1
令和17年	3,206人	805人	25.1％	993百万円	309.8千円	111.2
令和22年	2,993人	870人	29.1％	1,074百万円	358.7千円	**128.7**
令和27年	2,818人	872人	30.9％	1,076百万円	381.8千円	137.0
令和32年	2,565人	808人	31.5％	997百万円	388.7千円	**139.5**

資料：人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」。認定率は令和7年度実績（年齢階層別）。**指数は第10期の末（令和11年度）の第1号1人当たり278.7千円を100としたもの。**

総給付費そのものは、令和11年度から令和22年には+12.7％、令和32年でも+4.7％にとどまります。認定者数が令和22年の870人を頂点として、その後は減っていくためです。

しかし、第1号被保険者1人当たりでみると話が変わります。令和22年で128.7、令和32年で139.5と、**4割近く増えます。**第1号被保険者数が令和11年度の3,418人から令和32年の2,565人へ25％減る一方で、給付費が減らないためです。

認定率も23.2％（令和7年）から31.5％（令和32年）へ上がります。これは年齢階層別の認定率を固定したうえでの値であり、**町民が「弱くなる」のではなく、85歳以上の方が増えることによるものです**（85歳以上人口は令和2年の735人から令和27年の914人へ増えます）。

このことから、第10期に手を打っておくべきことが2つ見えます。

【表122】第6章11　中長期の見通し（令和22年・令和32年）（2）

見えること	第10期で手を打つこと	本計画での位置

令和12年を底に、認定者数が増えに転じる（778人→870人）	**介護予防・重度化防止の積み上げ。**認定率そのものを下げる取組は、効くまでに時間がかかるため、第10期のうちに始める必要があります	第5章 基本目標1
支える人数が減り、1人当たりの負担が4割増える	**サービスの効率と、多様な担い手の確保。**従前相当のサービスだけでは、人材の面でも費用の面でも持ちません	第5章 基本目標1②、第6章7

地域支援事業の量の中長期的な推計

介護保険法第117条第2項第3号は、サービスの量と**あわせて地域支援事業の量**の中長期的な推計を求めています。**第1号被保険者1人当たりの量を令和11年度の水準で据え置き、将来の第1号被保険者数で延ばしました。**サービス量と同じ置き方です。

【表123】第6章11　中長期の見通し（令和22年・令和32年）（3）

区分	事業	単位	令和11年度	令和22年	令和32年
総合事業	訪問介護相当サービス	1月あたり利用者数（人）	23.0	20.1	17.3
総合事業	通所介護相当サービス	1月あたり利用者数（人）	50.4	44.1	37.8
総合事業	介護予防ケアマネジメント	年間件数	549.4	481.1	412.3

※ 令和11年度は第6章4の見込量。第1号被保険者数は令和11年度3,418人、令和22年2,993人、令和32年2,565人（本節の表）。**第1号被保険者数が減るため、量も減る置き方になります。**ただし地域支援事業は介護予防・重度化防止を担うものであり、**認定者数が増える時期にはむしろ量を増やす必要があります。**本表は人口だけで延ばした機械的な推計であり、施策としての方向は次節11に書きます。**一般介護予防事業・包括的支援事業・任意事業の量は町の事業実績を要するため、第6章4と同じく【町データ待ち】です。**

なお、この見通しは第10期の保険料の算定には用いていません。保険料は3年間の見込量から算定するものであり、**本節は施策の方向を考えるための材料として置いています。**

前提の置き方によって動く幅も申し添えます。①年齢階層別認定率を固定していますが、健康寿命が延びれば同じ年齢でも認定率は下がるため、**本節は上振れ側の置き方です。**②認定者1人当たり給付費を令和11年度で据え置いています。介護報酬が実質で上がれば、そのぶん上振れします。③第1号被保険者負担割合を第10期の水準で見ていますが、**これは3年ごとに1ポイントずつ上がってきており、上がれば負担はさらに増えます。**

※ 人口の出所について。本節は社人研の令和5年推計、第6章1〜6の算定は第10期将来推計用推計人口によるもので、系列が異なります。**接続点（令和7年）の65歳以上人口は3,455人と3,460人で、差は5人（0.1%）でよく一致します。**

12　将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策

本節は、介護保険法第117条第2項第4号に基づく「介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項」です。社会福祉法等の一部を改正する法律（令和8年法律第51号）により、**計画に定めるものとする事項**（義務）として新たに置かれました。施行は**令和9年4月1日**で、**本計画の期間の初日**に当たります。前節10が中長期の推計（第2項第3号）、本節がそれを受けた施策です。

条文は「サービスを提供する体制の確保」と「地域支援事業の実施」の両方を掲げています。 本節では、サービスの提供体制を①から⑤に、地域支援事業の実施を⑥に書きます。

資料：厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案　新旧対照条文」（令和8年法律第51号・全353頁）。※ 第10期の国の基本指針は**令和8年11月頃に告示の予定**です（全国介護保険担当課長会議資料（令和8年7月15日）のスケジュール）。本改正をどこまで取り込むかは、告示を待って確かめます。

前節10が示したのは、給付費の総額ではなく『支える人数が減る』ことによる1人当たりの増加でした。 したがって確保すべきは量そのものではなく、**少ない担い手で必要な量を届けられる体制**です。本節では、その体制を5つの面から整理します。**この体制は、第4章1に定めた「本町の地域包括ケアの姿」を令和22年に向けて保つためのものです。**

【表124】第6章12　将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策

面	令和22年に向けて起きること	第10期に確保する体制	本計画での位置
担い手	生産年齢人口の減少により、介護職員・介護支援専門員ともに採用が難しくなります。町内の居宅介護支援事業所は5か所から3か所へ減っています（第2章5）	**介護保険法第117条第3項第4号は、サービス提供の生産性の向上・従事者の確保・安定した経営基盤の確立について、「都道府県と連携した取組に関する事項」を定めるよう努めることとしています。** 本町は福島県が設置する協議会（福祉人材確保・生産性向上等）に参画し、町内・圏域の事業所をつなぎます。令和8年法律第51号により、福祉人材確保の協議会の設置は都道府県の努力義務、生産性向上等の協議会の設置は都道府県の義務とされました（施行　令和9年4月1日）。**介護支援専門員の更新制は廃止され、法定研修が見直されます**（施行　公布後1年6月以内の政令で定める日。本計画の期間中）	第5章 基本目標3②、第6章12
事業所の維持	利用者数が減る時期が来ると、小規模な事業所から先に採算が合わなくなります	**町内事業所の休廃止の兆しを早く知る仕組みを置きます。**現在、休廃止の届出以外に把握する手立てがなく、【町データ待ち】。事業所間の協働化・社会福祉連携推進法人の活用も選択肢です	第5章 基本目標3②、第6章7
町外・広域の活用	介護サービス自給率は令和5年度72.43％から令和7年度67.57％へ下がっており、町外の利用が広がっています（第2章5）	**自給率を上げることを目標にせず、町外の事業所を使い続けられる条件（移動・送迎・情報）を整えます。** 町内で完結させる前提に立つと、人材の面で成り立ちません	第5章 基本目標2①
技術・効率	同じ人数でより多くの方を支える必要があります	介護テクノロジーの活用と事業所間の協働化。**県の介護生産性向上総合相談センターにつなぎます**	第5章 基本目標3②
住まい	在宅での生活が難しくなる方が増える一方、施設の新規整備は人材の面で現実的ではありません	**介護保険給付によらない住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）を含めた供給を把握します。** 町内の該当施設の有無と入居定員は【町データ待ち】（第2章5）	第2章5、第6章8
地域支援事業の実施	第1号被保険者数が減るため、人口だけで延ばすと量は減ります（前節10）。しかし認定者数が増える時期には、**介護予防・重度化防止の量はむしろ増やす必要があります**	**人口で延ばした量ではなく、認定率を下げる目標から逆算して置きます。** 担い手については、介護保険法第117条第3項第4号の2により**地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上**が、同項第5号により**地域支援事業の実施における生産性の向上**が、それぞれ県と連携した取組に関する事項として計画に定めるよう努める事項とされました	第5章 基本目標1、第6章4

本町は「中山間・人口減少地域」の類型に当たります（第1章4）。旧夏井村の区域は、介護保険の特定地域の対象となる見込みです（第1章2）。特定地域では、地域の実情に応じた人員配置基準や包括的な評価の仕組みによる「特定地域サービス」と、事業者が少ない場合に町が事業として行う「特定

地域居宅サービス等事業」を使えるようになります（令和９年４月１日施行）。**町内の事業所の休廃止の兆しを早く把握し、既存の指定サービスでは提供が続けられなくなったときに、これらを選択肢として検討します**（対象サービスと基準は国で検討中。【決定後に記載】）。

条文は「サービスを提供する体制の確保」と「地域支援事業の実施」を並べて掲げており、上の６つはその両方に対応しています。中長期の推計の年次は、同時に策定している第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計画と揃えます。

なお、第10期の国の基本指針は令和８年11月頃に告示の予定です。 本節の構えは条文に基づくものですが、指針が示す記載の仕方との整合は、告示を待って最終稿で確かめます。

本節に掲げた体制は、いずれも第５章の施策としてすでに位置づけているものです。 本節は、それらを『将来に向けた提供体制の確保』という法が求める観点から束ね直したものであり、新たな事業を起こすものではありません。

資料編

【表 125】資料編

区分	内容	状態
1　計画の策定経過	協議会の開催、パブリックコメントの実施	【決定後に記載】
2　小野町高齢者福祉サービス推進協議会 委員名簿	—	【決定後に記載】
3　パブリックコメントの結果	—	【決定後に記載】
4　令和 7 年度調査の概要と主な結果	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査	作成済み（集計結果・分析報告書による）
5　統計資料	人口・世帯、認定者数、給付費、事業所・定員、自給率	一部作成済み
6　**認知症施策推進基本計画との対応表**	国の認知症施策推進基本計画の各項目と本計画 第 5 章 基本目標 2③ の対応	作成予定
7　用語解説	—	作成予定
8　成果指標の定義	**各成果指標の算式・基準時点・データ源**	**本資料編 8 に掲載**
9　年次評価の様式	**毎年度の達成状況を記入する様式**	**本資料編 9 に掲載**
10　施策の見直しの基準	**未達のときに何をするかの基準**	**本資料編 10 に掲載**
11　主な参照資料	**本計画が用いた資料の一覧**	**本資料編 11 に掲載**
12　地域分析の指標	**国の基本指針の案の別表 1 の指標と本計画の対応**	**本資料編 12 に掲載**
13　図表番号一覧	**図と表の通し番号・題の一覧**	**本資料編 13 に掲載**

8　成果指標の定義

成果指標は、毎年度その達成状況を点検します（第 1 章 6）。点検が成り立つためには、指標の意味が年度によって動かないことが要ります。各指標について、何を数えるか、いつの時点か、どの資料から取るかをあらかじめ定めます。

【表 126】資料編 8　成果指標の定義

区分	定めること	内容
算式	分子と分母に何を数えるか	例：週 1 回以上の通いの場の参加率 = 参加者数 ÷ 第 1 号被保険者数
基準時点	いつの時点の値か	各年度末（3 月 31 日）を基本とする。給付に関する指標は年報の年度値による
データ源	どの資料から取るか	介護保険事業状況報告（年報）、地域包括ケア「見える化」システム、事業実績、次期の調査のいずれか
除外するもの	数えないもの	指標ごとに定める（例：町外の事業所の利用を含むか）
定義を変えるとき	変えた場合の扱い	**変えた年度と、変える前後の値を並べて記録します。**定義を変えたことを書かずに数値だけ入れ替えると、達成したのか定義が変わったのかが分からなくなります

※ 各成果指標の算式・基準時点・データ源は、目標値の設定とあわせて協議会でお諮りします（【協議会で設定】）。**第 5 章の各施策に置いた成果指標のうち、現状値が取れているものから順に定義を固めます。**

成果指標は、アウトプット指標とアウトカム指標に分けて扱います。アウトプット指標は事業の実施量と到達（回数・件数・箇所数・受診率など）を、アウトカム指標は高齢者の状態や地域のサービス基盤の変化を測ります。第 5 章に置いた成果指標 48 件の内訳は、アウトプット指標 30 件、アウトカム

指標 18 件です。**アウトプットが目標に届いてもアウトカムが動かないときは、事業の中身を見直します（資料編 10）。**

【表 127】資料編 8　成果指標の定義（2）

施策	成果指標	種類
基本目標 1① 健康づくりの推進	特定健診受診率	アウトプット
	後期高齢者健診受診率	アウトプット
	一体的実施における個別支援の対象者数	アウトプット
基本目標 1② 介護予防・日常生活支援総合事業の推進	週 1 回以上の通いの場の箇所数	アウトプット
	通いの場への参加率（65 歳以上）	アウトプット
	転倒リスク該当者の割合	アウトカム
	閉じこもり傾向該当者の割合	アウトカム
	一般介護予防事業費	アウトプット
基本目標 1③ 生きがいづくりと社会参加の推進	社会的役割の低下該当者の割合	アウトカム
	老人クラブ会員数	アウトカム
	シルバー人材センター会員数・就業実績	アウトカム
基本目標 2① 地域の支え合いの支援	協議体の開催回数	アウトプット
	生活支援コーディネーターの活動実績	アウトプット
	地域の支え合い活動の把握件数	アウトプット
基本目標 2② 包括的支援事業・任意事業の推進	地域包括支援センターの相談件数	アウトプット
	地域包括支援センターの認知度	アウトカム
	地域ケア会議の開催回数・検討件数	アウトプット
	居宅介護支援事業所数	アウトカム
基本目標 2③ 認知症施策の充実	認知症に関する相談窓口の認知度	アウトカム
	認知症初期集中支援チームの対象者の把握件数	アウトプット
	認知症地域支援推進員の活動実績	アウトプット
	認知症カフェの箇所数・参加者数	アウトプット
	認知症サポーター数（65 歳以上人口 10 万対）	アウトプット
基本目標 2④ 災害時等の要支援者への対応	個別避難計画の策定率	アウトプット
	福祉避難所の指定数	アウトプット
基本目標 2⑤ 多様な生活支援の充実	移送・外出支援の利用者数	アウトプット
	短期入所の利用者数・利用日数	アウトプット
	配食・緊急通報等の利用者数	アウトプット
	仕事と介護の両立に関する相談・周知の実施	アウトプット
基本目標 2⑥ 介護人材の確保とサービスの質の向上	町内介護サービス事業所数	アウトカム
	介護サービス自給率	アウトカム
	県事業・基金の活用件数	アウトプット
	介護職員の定着（町内事業所の離職率）	アウトカム
基本目標 2⑦ 在宅医療・介護連携の推進	4 つの場面ごとの目指すべき姿の設定	アウトプット
	多職種研修の開催回数・参加者数	アウトプット

	入院時情報連携加算の算定者数割合	アウトカム
	退院・退所加算の算定者数割合	アウトカム
	取組の検証の実施	アウトプット
基本目標 3① 自立支援・重度化防止に向けた取り組み	地域ケア会議の開催回数・検討件数	アウトプット
	要介護認定の適正化の実施状況	アウトプット
	ケアプラン点検の実施件数	アウトプット
	医療情報との突合の実施割合	アウトプット
	要介護度の維持・改善率	アウトカム
基本目標 3② 介護保険サービス等の充実	在宅サービス受給率	アウトカム
	認定者に対する受給者の比率	アウトカム
	サービス未利用者の割合	アウトカム
	未利用理由の把握状況	アウトプット
	介護老人福祉施設の町内自給率	アウトカム

9　年次評価の様式

毎年度、次の様式により達成状況を記入し、協議会に報告します。

【表 128】資料編 9　年次評価の様式

欄	記入すること
指標名	第 5 章の成果指標の名称
基準値	計画策定時（令和 7 年度）の値
目標値	令和 11 年度の値
当該年度の実績	その年度末の値
判定	**達成／おおむね達成／未達／評価できない の 4 区分**
未達の要因	**需要／供給／人材／制度／実施方法／データ のどれか**
次年度の対応	**何をするか、いつまでに、だれが**

※「評価できない」は、データが取れなかった場合をいいます。**取れなかったこと自体を記録し、翌年度に取れるようにします。**第 9 期では、通いの場の実績が見える化システムと調査とで食い違ったまま残りました（第 3 章 1）。

10　施策の見直しの基準

未達のときに、施策をどう見直すかをあらかじめ定めます。「未達だったので引き続き努めます」で終わらせないためです。

【表 129】資料編 10　施策の見直しの基準

未達の要因	見直しの方向	例
需要が想定と違った	対象の絞り込みを見直す。必要なら指標そのものを見直す	通いの場の参加率が上がらない場合、参加しない理由（移動手段・時間帯）に応じて場所や時間を変える
供給が足りない	既存の資源の活用、広域での利用、代替の提供方法を検討する	町内に事業所がないサービスについて、町外の事業所による給付で足りているかを自給率で確かめる
人材が足りない	**事業の量を増やす前に、担い手の確保策を先に置く**	生産年齢人口が半減する見通しのもとでは、事業の拡大より継続を優先する
制度上できない	国・県への要望、他の制度での対応を検討する	—

やり方に無理があった	実施方法を変える。担当・回数・場所・周知の方法を見直す	認知症の相談窓口の周知は、住民の情報入手先（広報 85.0％・防災無線 51.7％）に合わせる
データが取れなかった	**取れるようにすることを次年度の課題として明記する**	通いの場の実績は、事業実績の様式を先に決めておく

11　主な参照資料

【表 130】資料編 11　主な参照資料

区分	資料
法令・指針	介護保険法、老人福祉法、共生社会の実現を推進するための認知症基本法、国の基本指針、「介護給付適正化計画」に関する指針（令和 5 年 9 月 12 日 老介発 0912 第 1 号）
町の計画	小野町高齢者保健福祉計画・第 9 期介護保険事業計画（令和 6 年 3 月）、小野町第 3 期地域福祉計画（令和 8 年 3 月）、おのまち障がい者計画・障がい福祉計画、小野町こども計画、小野町地域公共交通計画、小野町地域防災計画、小野町過疎地域持続的発展計画
県の計画	福島県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画、福島県の医療計画・地域医療構想
統計・実績	**介護保険事業状況報告（年報）令和 3〜7 年度、国民健康保険団体連合会業務統計表（月報）、地域包括ケア「見える化」システム、第 10 期将来推計用推計人口、住民基本台帳**
調査	**令和 7 年度 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（n=1,835）、令和 7 年度 在宅介護実態調査（n=366）**
交付金	令和 8 年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）の評価指標及び該当状況調査票集計表

12　地域分析の指標（国の基本指針の案の別表 1）

国の第 10 期の基本指針の案は、新たに別表 1 を設け、計画の策定に当たって確認すべき指標・状況を 11 の事項に分けて示しています。 本計画で把握しているものと、まだ取れていないものは次のとおりです。

【表 131】資料編 12　地域分析の指標（国の基本指針の案の別表 1）

事項	確認すべき指標・状況（主なもの）	本計画の箇所	状況
一　地勢と交通	地域特性、交通機関の状況、地理的状況	第 1 章 5	町の面積・公共交通の運行状況は【町データ待ち】
二　人口構造	年齢三区分人口、高齢化率、世帯数（単身高齢・高齢夫婦のみ）	第 2 章 1・6	把握済み
三　人口動態	出生数、死亡数、健康寿命、死亡場所別の死亡数	第 2 章 1	在宅死亡者数（人口 10 万対、令和元年度）は自宅 190.0・老人ホーム 10.0・介護老人保健施設 20.0。死亡総数と病院での死亡は【町データ待ち】
四　認定者数の状況	要介護度別の認定者数、年齢調整後の認定率	第 2 章 3	把握済み
五　介護サービス等の利用状況	受給率、町内事業所による提供割合、1 人当たり費用額、介護 SCR	第 2 章 3・5・本節	把握済み（介護 SCR は下表）
六　介護サービス見込量	サービス別の見込量、計画と実績の乖離、家族の就業の状況	第 2 章 2・第 3 章 3・第 6 章 2	把握済み
七　介護保険施設・事業所の状況	事業所数、利用者数、入所率、稼働率、従事者数	第 2 章 5	町内の事業所数は把握（令和 6 年度、居宅サービス等 18）。施設・居住系の事業所数は

			【見える化出力待ち】、事業所別の稼働率・従事者数は【町データ待ち】
八　高齢者向け住まいの状況	有料老人ホーム等の定員、要介護者である入居者の状況	第 2 章 5・第 6 章 2	入居定員総数は県から提供を受ける（【町データ待ち】）
九　地域支援事業の状況	通いの場の数・参加者数、地域包括支援センターの相談体制	第 3 章 2・第 5 章 基本目標 1②・2②	相談件数は【町データ待ち】
十　医療介護連携の状況	医療介護連携に関する加算の算定状況	第 5 章 基本目標 2⑦	把握済み
十一　認知症の人の数及び関連施策の状況	認知症の人の数・推計値、認知症カフェ等の社会参加の場	第 2 章 6・第 5 章 基本目標 2③	把握済み（自立度Ⅲａ・Ⅲｂは未受領）

資料：全国介護保険担当課長会議資料（令和 8 年 7 月 15 日）資料 3-1、社会保障審議会介護保険部会（第 135 回）資料 2-2「基本指針（案）について（新旧案）」。**別表 1 は基本指針の案であり、告示（令和 8 年 11 月頃の予定）で確定します。**死亡総数と病院での死亡は、人口動態統計で取得します。

本町の介護 SCR（利用者住所地ベース、全国＝100）は次のとおりです。

【表 132】資料編 12　地域分析の指標（国の基本指針の案の別表 1）（2）

サービス区分	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	県中圏域	福島県	県内順位
介護給付系	76.9	73.8	**73.0**	83.7	87.7	29 位
訪問系	39.1	34.4	**33.4**	59.5	58.0	34 位
通所系	96.4	93.3	**90.2**	97.1	98.4	23 位
短期入所系	117.0	81.6	**92.0**	136.4	134.5	49 位
多機能系	224.8	206.8	**221.3**	150.8	121.1	6 位
施設系	106.6	107.9	**117.8**	106.3	115.5	43 位
居住系	88.5	99.5	**96.3**	91.6	84.3	10 位
訪問介護	51.6	47.9	**47.5**	56.5	72.3	26 位
訪問介護（通院等乗降介助）	548.4	493.0	**441.5**	366.4	293.5	6 位
訪問看護	79.3	65.6	**60.4**	92.1	73.6	25 位
居宅療養管理指導	8.5	8.6	**7.2**	39.0	33.3	40 位
通所リハビリテーション	61.2	52.7	**52.4**	102.3	100.0	40 位
小規模多機能型居宅介護	240.4	220.2	**241.4**	172.6	123.8	6 位
認知症対応型共同生活介護	195.0	222.7	**209.9**	127.2	102.2	3 位

資料：厚生労働科学研究費補助金〈長寿科学政策研究〉「2040 年を見据えた地域特性に応じた介護サービス提供体制の最適化と科学的介護の推進に関する調査研究」（研究代表者：陣内裕成）の介護 SCR データセット（介護 DB・住民基本台帳人口による）。県内順位は県内 59 市町村のうち値の高い順（令和 5 年度）。**小規模な町では年度の振れが大きいため、3 か年の推移で読みます。**

13　図表番号一覧

本計画に載せた図と表の通し番号の一覧です。図表の題は、それが置かれている章・節の見出しにより ます。同じ節に複数あるときは枝番を付けています。

題を 1 つずつ手で書いていないのは、見出しを変えたときに題だけが古いまま残ることを避けるためです。番号と題は本文から機械的に拾っています。

区分	番号	題
図	【図 1】	総人口と高齢化率の推移・推計
図	【図 2】	通いの場の実施状況と調査の回答

図	【図3】	認知症施策の体制と活動
図	【図4】	第10期の総給付費の見込み（区分別）
図	【図5】	保険料基準額の選択肢（100円未満切上げ後）
表	【表1】	本素案について
表	【表2】	本素案について　未確定箇所の凡例
表	【表3】	本素案について　未確定箇所の凡例（2）
表	【表4】	目次
表	【表5】	第1章2　第10期計画の基本指針
表	【表6】	第1章2　第10期計画の基本指針（2）
表	【表7】	第1章2　第10期計画の基本指針（3）
表	【表8】	第1章3　計画の位置づけと期間
表	【表9】	第1章4　計画策定の視点
表	【表10】	第1章5　日常生活圏域の設定
表	【表11】	第1章6　計画の進行管理・推進体制
表	【表12】	第1章6　計画の進行管理・推進体制（2）
表	【表13】	第1章6　計画の進行管理・推進体制（3）
表	【表14】	第1章7　計画の策定体制
表	【表15】	第1章7　計画の策定体制（2）
表	【表16】	第2章1　人口と世帯の状況
表	【表17】	第2章1　人口と世帯の状況（2）
表	【表18】	第2章2　令和7年度調査のまとめ
表	【表19】	第2章2　令和7年度調査のまとめ（2）
表	【表20】	第2章2　令和7年度調査のまとめ（3）
表	【表21】	第2章3　小野町の介護保険事業の状況
表	【表22】	第2章3　小野町の介護保険事業の状況（2）
表	【表23】	第2章3　小野町の介護保険事業の状況（3）
表	【表24】	第2章3　小野町の介護保険事業の状況（4）
表	【表25】	第2章3　小野町の介護保険事業の状況（5）
表	【表26】	第2章3　小野町の介護保険事業の状況（6）
表	【表27】	第2章3　小野町の介護保険事業の状況（7）
表	【表28】	第2章4　介護保険財政の状況
表	【表29】	第2章4　介護保険財政の状況（2）
表	【表30】	第2章5　サービス提供体制の状況
表	【表31】	第2章5　サービス提供体制の状況（2）
表	【表32】	第2章5　サービス提供体制の状況（3）
表	【表33】	第2章5　サービス提供体制の状況（4）
表	【表34】	第2章5　サービス提供体制の状況（5）
表	【表35】	第2章6　高齢者数等の将来推計
表	【表36】	第2章6　高齢者数等の将来推計（2）
表	【表37】	第2章6　高齢者数等の将来推計（3）
表	【表38】	第2章7　第10期計画における課題の整理
表	【表39】	第2章7　第10期計画における課題の整理（2）
表	【表40】	第2章7　第10期計画における課題の整理（3）
表	【表41】	第3章1　第9期計画の基本目標と達成状況
表	【表42】	第3章2　地域支援事業の実績
表	【表43】	第3章3　介護保険事業の実績

表	【表44】	第3章3　介護保険事業の実績（2）
表	【表45】	第3章3　介護保険事業の実績（3）
表	【表46】	第3章4　第9期の評価と第10期への課題
表	【表47】	第4章1　計画の基本理念と目標
表	【表48】	第4章2　計画の体系
表	【表49】	第4章2　計画の体系（2）
表	【表50】	第4章3　関連計画との役割分担
表	【表51】	第4章3　関連計画との役割分担（2）
表	【表52】	第4章3　関連計画との役割分担（3）
表	【表53】	第4章3　関連計画との役割分担（4）
表	【表54】	第4章4　障がい福祉計画との接点
表	【表55】	第4章4　障がい福祉計画との接点（2）
表	【表56】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進
表	【表57】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（2）
表	【表58】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（3）
表	【表59】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（4）
表	【表60】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（5）
表	【表61】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（6）
表	【表62】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（7）
表	【表63】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（8）
表	【表64】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（9）
表	【表65】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（10）
表	【表66】	第5章基本目標1　介護予防と生きがいづくりの推進（11）
表	【表67】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保
表	【表68】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（2）
表	【表69】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（3）
表	【表70】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（4）
表	【表71】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（5）
表	【表72】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（6）
表	【表73】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（7）
表	【表74】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（8）
表	【表75】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（9）
表	【表76】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（10）
表	【表77】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（11）
表	【表78】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（12）
表	【表79】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（13）
表	【表80】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（14）
表	【表81】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（15）
表	【表82】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（16）
表	【表83】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（17）
表	【表84】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（18）
表	【表85】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（19）
表	【表86】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（20）
表	【表87】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（21）
表	【表88】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（22）
表	【表89】	第5章基本目標2　安全・安心な暮らしの確保（23）

表	【表90】	第5章基本目標3　介護サービスの充実
表	【表91】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（2）
表	【表92】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（3）
表	【表93】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（4）
表	【表94】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（5）
表	【表95】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（6）
表	【表96】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（7）
表	【表97】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（8）
表	【表98】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（9）
表	【表99】	第5章基本目標3　介護サービスの充実（10）
表	【表100】	要介護認定者数の見込み
表	【表101】	第6章2　介護給付等サービスの見込量
表	【表102】	第6章2　介護給付等サービスの見込量（2）
表	【表103】	第6章2　介護給付等サービスの見込量（3）
表	【表104】	第6章3　介護保険サービス事業費の見込み
表	【表105】	第6章4　地域支援事業の見込量と事業費
表	【表106】	第6章4　地域支援事業の見込量と事業費（2）
表	【表107】	第6章4　地域支援事業の見込量と事業費（3）
表	【表108】	第6章4　地域支援事業の見込量と事業費（4）
表	【表109】	特定地域居宅サービス等事業の対象（介護保険法第115条の45第3項）
表	【表110】	第6章5　第1号被保険者の保険料
表	【表111】	第6章5　第1号被保険者の保険料（2）
表	【表112】	第6章5　第1号被保険者の保険料（3）
表	【表113】	第6章6　人材の供給制約からみた見込量の妥当性
表	【表114】	第6章7　見える化システムによる算定との突合
表	【表115】	第6章7　見える化システムによる算定との突合（2）
表	【表116】	第6章8　介護施設等の整備の基本方針と必要利用定員総数
表	【表117】	地域密着型サービスの必要利用定員総数
表	【表118】	第6章9　老人福祉事業の量の目標
表	【表119】	第6章9　老人福祉事業の量の目標（2）
表	【表120】	第6章10　低所得者支援
表	【表121】	第6章11　中長期の見通し（令和22年・令和32年）
表	【表122】	第6章11　中長期の見通し（令和22年・令和32年）（2）
表	【表123】	第6章11　中長期の見通し（令和22年・令和32年）（3）
表	【表124】	第6章12　将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策
表	【表125】	資料編
表	【表126】	資料編8　成果指標の定義
表	【表127】	資料編8　成果指標の定義（2）
表	【表128】	資料編9　年次評価の様式
表	【表129】	資料編10　施策の見直しの基準
表	【表130】	資料編11　主な参照資料
表	【表131】	資料編12　地域分析の指標（国の基本指針の案の別表1）
表	【表132】	資料編12　地域分析の指標（国の基本指針の案の別表1）（2）

※ 掲載頁は組版の段階で入れます（Wordで開くと目次と同じく更新されます）。※ 参考「本素案の確定に必要な事項」の表は、計画書に載せないため番号を振っていません。

参考　本素案の確定に必要な事項

本素案を計画案として確定するために必要な事項は次のとおりです。

本章は素案の作業用であり、計画書には載せません。このため表に番号を振っていません。

優先	事項	反映先
最優先	令和 8 年 3 月末（令和 7 年度末）時点の要介護度別認定者数の実数	第 2 章 3(1)、第 2 章 6。**これがないとサービス見込量・保険料が算定できない**
最優先	**85 歳以上の認定者の令和 7 年度中の異動の内訳**（死亡・転出・非該当・更新未申請）	第 2 章 3(1)。**減少の 77.0％が 85 歳以上に集中していることの要因特定**
最優先	**認定有効期間の延長特例（令和 2〜4 年度）の適用件数と、令和 7 年度の更新認定の申請・非該当・未申請の件数**	第 2 章 3(1)。**令和 2 年度の＋107 人と令和 7 年度の▲152 人を一つの機序で説明できるかの検証**
高	令和 6・7 年度の介護保険特別会計決算（基金の取崩額・残高を含む）	第 2 章 4、第 5 章 基本目標 3③
高	令和 3〜8 年度のサービス別給付費・受給者数	第 2 章 3(4)、第 5 章 基本目標 3③
高	所得段階別第 1 号被保険者数	第 5 章 基本目標 3③ の保険料算定
高	地域支援事業費の実績と事業別内訳	第 2 章 4、第 5 章の各施策
高	**通いの場の実施箇所・参加者数・開催回数（令和 3〜7 年度）**	**第 2 章 7、第 5 章 基本目標 1②。見える化システムと調査結果の不整合の解明**
中	認知症施策の実績（サポーター養成、初期集中支援チーム、カフェ、推進員）	第 5 章 基本目標 2③
中	介護給付適正化の主要 3 事業の実施状況	第 5 章 基本目標 3①
中	居宅介護支援事業所の担当件数・受付状況	第 2 章 5、第 5 章 基本目標 2②
中	事業所別の定員・稼働率・町内外利用・待機・休廃止の状況	第 2 章 5
中	第 10 期における施設整備の予定の有無	第 5 章 基本目標 3③ の保険料ケース
中	介護用品給付券等の町単独事業の資料（決算科目、補助対象の可否）	第 5 章 基本目標 2②
中	国の基本指針の内容	第 1 章 2、第 5 章 基本目標 3③
中	協議会の開催回数・時期、パブリックコメントの実施時期	第 1 章 4、資料編
中	庁内の検討体制（会議の名称・構成・開催予定）	第 1 章 7
中	健康増進計画・データヘルス計画・特定健康診査等実施計画の計画名と期間	第 4 章 3
中	重層的支援体制整備事業の実施の有無	第 1 章 2
中	町内事業所の離職率、ICT・ケアプランデータ連携システムの導入状況	第 5 章 基本目標 2⑥
中	地域医療介護総合確保基金のメニューと県の交付要綱（県）	第 5 章 基本目標 2⑥
中	地域ケア会議の資料（開催回数・検討件数・事例）	第 5 章 基本目標 2②・3①
中	在宅介護実態調査の個票と、認定データとの連携の有無	第 2 章 2